

Buku Referensi
**MANAJEMEN KESEHATAN MENTAL
PADA LANSIA**

Fitrio Deviantony • Suwarningsih • Syisnawati
Mei Rianita Elfrida Sinaga • Herlina
Endang Fauziah Susilawati
Nurul Hidayah



BUKU REFERENSI MANAJEMEN KESEHATAN MENTAL PADA LANSIA

Ns.Fitrio Deviantony,S.Kep.,M.Kep

Ns. Suwarningsih, SKep., MKep

Syisnawati, S.Kep., Ns, M.Kep., Sp.Kep.J

Mei Rianita Elfrida Sinaga, S.Kep., Ns., M.Kep

Herlina, S.Kep., Ns., M.Kes

Ns. Endang Fauziah Susilawati, M.Kep

Ns.Nurul Hidayah,M.Kep



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

MANAJEMEN KESEHATAN MENTAL PADA LANSIA

Penulis: Ns.Fitrio Deviantony,S.Kep.,M.Kep
Ns. Suwarningsih, S.Kep., M.Kep
Syisnawati, S.Kep., Ns, M.Kep., Sp.Kep.J
Mei Rianita Elfrida Sinaga, S.Kep., Ns., M.Kep
Herlina, S.Kep., Ns., M.Kes
Ns. Endang Fauziyah Susilawati, M.Kep
Ns.Nurul Hidayah,M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-72-2

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku referensi ini yang berjudul **"Manajemen Kesehatan Mental pada Lansia"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dalam bidang kesehatan mental.

Perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan lingkungan yang dialami lansia sering kali menjadikan kelompok usia ini rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan kesepian. Namun, dengan pemahaman yang tepat serta dukungan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan, gangguan tersebut dapat dicegah dan dikelola secara optimal.

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang saling melengkapi. Bab pertama membahas faktor risiko gangguan mental pada lansia, mengidentifikasi penyebab dan kondisi predisposisi yang perlu diwaspadai. Bab kedua mengulas edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental lansia sebagai langkah awal dalam pemberdayaan lansia dan keluarga. Bab ketiga memfokuskan pada strategi komunitas yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis lansia. Selanjutnya, Bab keempat menyoroti peran keluarga sebagai garda terdepan dalam memberikan dukungan emosional dan sosial yang berkelanjutan.

Bab kelima menekankan pentingnya aktivitas fisik yang sesuai dan adaptif untuk menunjang kesehatan mental. Bab keenam membahas pemanfaatan teknologi digital, termasuk layanan konseling daring dan aplikasi kesehatan jiwa, yang kini semakin relevan di era modern. Terakhir, Bab ketujuh menampilkan konsep kolaborasi multidisiplin sebagai strategi sinergis antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan masyarakat dalam meningkatkan hasil intervensi kesehatan mental lansia.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan siapa pun yang peduli terhadap kesehatan jiwa lansia. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya.

Selamat membaca, semoga buku ini menginspirasi dan memberikan kontribusi nyata dalam praktik pelayanan kesehatan lansia yang lebih baik dan bermartabat.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I FAKTOR RISIKO GANGGUAN MENTAL PADA LANSIA.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Faktor Risiko Biologis dan Fisik	2
C. Faktor Risiko Psikososial	3
D. Faktor Risiko Lingkungan dan Gaya Hidup.....	4
E. Faktor Risiko Sosiodemografi	6
F. Faktor Risiko Komorbiditas.....	7
G. Penutup	9
Referensi.....	11
BAB II EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL LANSIA... 14	14
A. Pendahuluan	14
B. Pemahaman Dasar Kesehatan Mental pada Lansia	15
C. Manfaat Edukasi Kesehatan Mental bagi Lansia dan Keluarga	16
D. Metode Edukasi yang Efektif bagi Lansia	17
E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Kesehatan Mental	19
F. Strategi Pemberian Edukasi di Komunitas.....	21
G. Evaluasi Keberhasilan Edukasi Kesehatan Mental	22
H. Tantangan dan Hambatan dalam Edukasi Kesehatan Mental Lansia	24
I. Penutup	25
Referensi.....	27
BAB III STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MENTAL LANSIA.....	28
A. Pendahuluan	28
B. Konsep Kesejahteraan Mental pada Lansia.....	29
C. Peran Komunitas dalam Mendukung Kesejahteraan Mental.....	30
D. Model Pendekatan Psikososial dalam Masyarakat Pertanian	31
E. Karakteristik Wilayah Pertanian dan Potensinya untuk Lansia.....	32
F. Program Sosial dan Rekreasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mental.....	33
G. Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia	34
H. Studi Kasus kesehatan mental pada lansia di Wilayah Pedesaan dan Pertanian	35
I. Best Practices dari Negara Lain dalam Mendukung Lansia di Wilayah Pertanian	36
J. Penutup	38
Referensi.....	40
BAB IV PERAN KELUARGA DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN PSIKOLOGIS.....	46
A. Pendahuluan	46
B. Kebutuhan Psikologis Lansia	47
C. Peran Keluarga dalam Menjaga Kesehatan Mental Lansia.....	49
D. Strategi Komunikasi Efektif dengan Lansia	51

E. Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia melalui Aktivitas Positif	56
F. Tantangan dalam Memberikan Dukungan Psikologis bagi Lansia	57
G. Penutup	58
Referensi.....	60
BAB V AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL LANSIA	65
A. Pendahuluan	65
B. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan untuk Lansia.....	66
C. Efek Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Mental Lansia.....	67
D. Protokol dan Intensitas Aktivitas Fisik yang Aman bagi Lansia	68
E. Dukungan Sosial dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik Lansia.....	70
F. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik pada Lansia	71
G. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mendukung Aktivitas Fisik Lansia	73
H. Penutup	75
Referensi.....	76
BAB VI PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING LANSIA	79
A. Pendahuluan	79
B. Jenis-jenis Teknologi untuk Konseling Lansia	80
C. Efektivitas Pemanfaatan Teknologi dalam Konseling Lansia	81
D. Strategi Implementasi Teknologi untuk Konseling Lansia	82
E. Hambatan dan Solusi dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Konseling Lansia	84
F. Praktik Terbaik dan Rekomendasi.....	85
G. Penutup	87
Referensi.....	89
BAB VII KOLABORASI MULTIDISPLIN DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL LANSIA	90
A. Pendahuluan	90
B. Kesehatan Mental Pada Lansia	92
C. Peran Beragam Profesi dalam Layanan Kesehatan Mental Lansia	93
D. Strategi dan Implementasi Kolaborasi Multidisiplin dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Lansia.....	95
E. Tantangan dan Solusi dalam Kolaborasi Multidisiplin	97
F. Penutup	100
Referensi.....	101
Profil Penulis	103
Sinopsis Buku	107

BAB I

FAKTOR RISIKO GANGGUAN MENTAL PADA LANSIA

A. Pendahuluan

Gangguan mental merupakan tantangan kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi lansia di seluruh dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 20% lansia berusia di atas 60 tahun mengalami gangguan mental atau neurologis (WHO, 2022). Gangguan yang paling sering ditemukan adalah depresi, kecemasan, demensia, dan gangguan tidur (Harada et al., 2022).

Di Indonesia, prevalensi gangguan mental pada lansia juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 6,1% lansia mengalami gangguan mental emosional, dengan depresi sebagai gangguan yang paling banyak dilaporkan (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Studi terbaru juga menegaskan bahwa prevalensi depresi lansia di Indonesia berkisar antara 15% hingga 30%, tergantung pada lokasi geografis, status ekonomi, dan jaringan sosial (Indrayani et al., 2023). Tingginya angka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan usia harapan hidup, perubahan dinamika sosial, dan meningkatnya prevalensi penyakit kronis.

Pengenalan dini terhadap faktor risiko gangguan mental pada lansia sangat penting guna mencegah komplikasi dan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Identifikasi dini dapat membantu tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam merancang intervensi yang efektif serta meningkatkan hasil kesehatan mental lansia secara keseluruhan (Zhang et al., 2021). Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor risiko juga berperan penting dalam edukasi keluarga dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental lansia.

Berbagai penelitian terbaru menegaskan pentingnya pendekatan preventif melalui identifikasi faktor risiko, seperti isolasi sosial, kondisi kronis fisik, serta gangguan sensorik (Zhao & Feng, 2020; Wang et al., 2023). Pengelolaan yang tepat terhadap faktor-faktor tersebut tidak hanya mampu mencegah gangguan mental tetapi juga menurunkan biaya perawatan kesehatan jangka panjang. Sebuah tinjauan sistematis menegaskan bahwa intervensi dini terhadap risiko psikososial, seperti kesepian dan isolasi, mampu mengurangi risiko gangguan mental secara signifikan (Ansari & Khan, 2022).

Secara keseluruhan, memahami prevalensi serta mengidentifikasi faktor risiko gangguan mental merupakan langkah strategis yang esensial dalam manajemen kesehatan lansia. Pengetahuan ini mendukung praktik keperawatan yang berbasis bukti dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang optimal bagi lansia.

B. Faktor Risiko Biologis dan Fisik

1. Penyakit Kronis dan Gangguan Degeneratif sebagai Pemicu Gangguan Mental

Penyakit kronis dan gangguan degeneratif merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan gangguan mental pada lansia. Penyakit degeneratif seperti demensia, stroke, dan penyakit Parkinson sering kali dikaitkan dengan tingginya prevalensi depresi, kecemasan, serta gangguan kognitif lainnya (Livingston et al., 2020; Taylor & Dening, 2022).

Demensia, misalnya, ditandai dengan penurunan fungsi kognitif progresif yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan hidup mandiri serta munculnya gejala depresi dan kecemasan pada lansia (Livingston et al., 2020). Stroke juga berhubungan erat dengan gangguan emosional dan psikologis, di mana sekitar 30-40% pasien stroke mengalami depresi pasca-stroke yang berkontribusi terhadap menurunnya kualitas hidup (Robinson & Jorge, 2021). Sementara itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien penyakit Parkinson sering mengalami kecemasan dan depresi yang signifikan akibat gangguan neurotransmitter dopamin di otak (Marinus et al., 2021).

2. Faktor Neurobiologis dan Perubahan Struktur Otak pada Lansia

Penuaan membawa perubahan signifikan pada struktur dan fungsi otak yang meningkatkan kerentanan terhadap gangguan mental. Penurunan volume otak, atrofi jaringan saraf, serta perubahan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin secara langsung berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi dan gangguan kecemasan pada lansia (Xia et al., 2021).

Menurut sebuah studi pencitraan otak terbaru, terjadi penurunan volume hipokampus dan korteks prefrontal yang signifikan pada lansia dengan depresi, yang merupakan area penting dalam regulasi emosi dan kognisi (Zhou et al., 2022). Perubahan struktur ini menyebabkan gangguan dalam kemampuan lansia untuk mengelola stres, mengatur emosi, serta memproses informasi secara efektif (Jiang et al., 2020). Pemahaman terhadap mekanisme neurobiologis ini sangat penting dalam merancang strategi intervensi untuk mengatasi gangguan mental pada populasi lansia.

3. Gangguan Sensorik dan Hubungannya dengan Isolasi Sosial

Gangguan sensorik, terutama penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran, secara signifikan berkontribusi terhadap isolasi sosial yang menjadi pemicu utama gangguan mental pada lansia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan gangguan pendengaran memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi karena kesulitan berkomunikasi dan berinteraksi sosial (Zhao & Feng, 2020). Gangguan penglihatan juga membatasi aktivitas sosial, meningkatkan rasa kesepian dan isolasi sosial, serta memperbesar risiko depresi dan kecemasan (Wang et al., 2021).

Studi terbaru menegaskan bahwa lansia yang mengalami kombinasi gangguan pendengaran dan penglihatan memiliki risiko isolasi sosial dan gangguan mental lebih tinggi dibandingkan lansia dengan gangguan sensorik tunggal atau tanpa gangguan sensorik (Dunsmore & Fiske, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan gangguan sensorik pada lansia menjadi aspek penting dalam pencegahan gangguan mental, dengan meningkatkan akses pada alat bantu sensorik dan intervensi sosial untuk mengurangi dampak psikososialnya.

C. Faktor Risiko Psikososial

1. Kesepian dan Isolasi Sosial sebagai Prediktor Kuat Depresi pada Lansia

Kesepian dan isolasi sosial merupakan faktor risiko psikososial utama yang berhubungan erat dengan munculnya depresi dan gangguan mental lainnya pada lansia. Kesepian didefinisikan sebagai perasaan subjektif terkait kekurangan hubungan sosial yang bermakna, sedangkan isolasi sosial merujuk pada kurangnya kontak atau interaksi objektif dengan lingkungan sosial (Gerst-Emerson & Jayawardhana, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia yang mengalami kesepian atau isolasi sosial memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan lansia dengan hubungan sosial yang baik (Ansari & Khan, 2022).

Sebuah studi longitudinal menemukan bahwa kesepian dapat memicu perubahan neuroendokrin, inflamasi kronis, dan penurunan fungsi kognitif, yang berkontribusi signifikan terhadap gangguan mental pada lansia (Courtin & Knapp, 2022). Oleh karena itu, pemahaman terhadap kesepian dan isolasi sosial sangat penting dalam upaya pencegahan depresi serta perancangan intervensi berbasis komunitas untuk mendukung kesehatan mental lansia.

2. Kehilangan Pasangan atau Anggota Keluarga Dekat (Berduka) sebagai Pemicu Gangguan Mental

Kehilangan pasangan atau anggota keluarga dekat adalah peristiwa kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis lansia. Proses

berduka yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pasca trauma (PTSD) (Kuo et al., 2020). Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia yang kehilangan pasangan mengalami peningkatan risiko gangguan mental hingga 60% dalam dua tahun pertama setelah kehilangan tersebut, dengan gejala yang lebih parah jika tidak mendapat dukungan psikologis yang memadai (Kristiansen et al., 2021).

Proses duka berkepanjangan pada lansia juga berdampak negatif pada kondisi fisik, seperti melemahnya sistem imun, meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular, dan penurunan fungsi kognitif, yang semuanya berkontribusi lebih lanjut terhadap memburuknya kondisi mental lansia (Naef et al., 2021). Oleh karena itu, intervensi dukungan sosial dan psikologis setelah kehilangan merupakan komponen penting dalam pengelolaan kesehatan mental lansia.

3. Status Ekonomi Rendah dan Tekanan Finansial sebagai Sumber Stres Kronik pada Lansia

Status ekonomi yang rendah dan tekanan finansial kronik secara konsisten dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan mental pada lansia. Stres yang timbul akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan kecemasan, depresi, serta meningkatkan risiko isolasi sosial karena keterbatasan dalam aktivitas sosial dan partisipasi komunitas (Santini et al., 2021).

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa lansia dengan tekanan finansial kronis menunjukkan tingkat inflamasi kronis yang lebih tinggi, peningkatan hormon stres, serta penurunan fungsi kognitif dibandingkan lansia dengan kondisi finansial yang stabil (Pooler & Srinivasan, 2020). Lebih lanjut, tekanan ekonomi jangka panjang menyebabkan penurunan akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih rendah, yang secara signifikan memperbesar risiko munculnya gangguan mental (Galatzer-Levy et al., 2022). Upaya preventif dan intervensi yang berfokus pada dukungan ekonomi dan sosial sangat penting dalam mengurangi dampak negatif stres finansial terhadap kesehatan mental lansia.

D. Faktor Risiko Lingkungan dan Gaya Hidup

1. Dampak Lingkungan Tempat Tinggal (Rumah, Panti Jompo, atau Komunitas) terhadap Kondisi Mental Lansia

Lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi mental lansia. Lansia yang tinggal di lingkungan rumah pribadi, panti jompo, atau komunitas masing-masing menghadapi tantangan psikologis yang berbeda. Studi terbaru menemukan bahwa lansia yang tinggal sendiri di rumah pribadi

memiliki risiko lebih tinggi mengalami isolasi sosial, kesepian, serta depresi akibat minimnya interaksi sosial (Kwak & Lee, 2022). Sebaliknya, lansia yang tinggal di panti jompo sering menghadapi tantangan psikologis berupa hilangnya privasi, perasaan kehilangan kendali atas kehidupan, serta terbatasnya kontak keluarga yang dapat memperburuk kesehatan mental mereka (Cheng et al., 2021).

Lingkungan komunitas, di sisi lain, dapat memiliki dampak positif jika didukung fasilitas interaksi sosial yang memadai seperti klub lansia, kegiatan sosial rutin, dan dukungan komunitas. Namun, tanpa dukungan sosial yang kuat, tinggal dalam komunitas juga berpotensi menimbulkan rasa terabaikan dan isolasi sosial yang memperbesar risiko gangguan mental pada lansia (Shankar et al., 2021).

2. Ketergantungan Fisik dan Kurangnya Aktivitas Fisik sebagai Faktor Risiko Gangguan Mental

Ketergantungan fisik, yang ditandai dengan penurunan mobilitas dan hilangnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, secara konsisten dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan mental, terutama depresi dan kecemasan pada lansia (Volkert et al., 2022). Penelitian terbaru menegaskan bahwa lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas atau ketergantungan pada perawatan orang lain cenderung memiliki tingkat stres psikologis yang lebih tinggi, rasa percaya diri yang rendah, serta isolasi sosial yang signifikan (Lu et al., 2020).

Kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi besar terhadap risiko gangguan mental. Studi terbaru menunjukkan bahwa lansia yang kurang aktif secara fisik memiliki risiko depresi dua kali lipat dibandingkan mereka yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang (Schuch et al., 2021). Aktivitas fisik diketahui memiliki efek perlindungan terhadap gangguan mental karena mampu meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan endorfin, serta memperbaiki suasana hati dan fungsi kognitif pada lansia (Biddle et al., 2021).

3. Pola Tidur Buruk dan Gangguan Tidur sebagai Faktor Risiko Gangguan Mental

Gangguan tidur merupakan salah satu faktor risiko gaya hidup yang sangat signifikan terhadap munculnya gangguan mental pada lansia. Pola tidur buruk, seperti insomnia kronis, kualitas tidur rendah, serta durasi tidur yang tidak mencukupi secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan penurunan fungsi kognitif pada lansia (Li et al., 2021). Gangguan tidur kronis menyebabkan perubahan biologis seperti gangguan irama sirkadian

dan peningkatan kadar hormon stres (kortisol), yang berkontribusi pada gangguan suasana hati dan kesehatan mental (Hertenstein et al., 2022).

Studi longitudinal terbaru menemukan bahwa lansia dengan gangguan tidur berat memiliki risiko dua kali lebih besar mengalami gangguan mental dibandingkan dengan lansia yang memiliki pola tidur normal (Fang et al., 2023). Oleh karena itu, manajemen gangguan tidur, termasuk melalui terapi perilaku kognitif dan edukasi higiene tidur, sangat penting dalam strategi pencegahan gangguan mental pada lansia.

E. Faktor Risiko Sosiodemografi

1. Gender dan Usia Lanjut sebagai Determinan Gangguan Mental pada Lansia

Faktor sosiodemografi seperti gender dan usia lanjut merupakan determinan penting dalam timbulnya gangguan mental pada lansia. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa lansia perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental, terutama depresi dan kecemasan, dibandingkan lansia laki-laki (Barua et al., 2021). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan hormonal pascamenopause, peran gender dalam masyarakat yang menyebabkan beban psikologis tambahan, serta prevalensi yang lebih tinggi dalam menghadapi peristiwa traumatis seperti kehilangan pasangan atau isolasi sosial (Heid et al., 2023).

Selain itu, peningkatan usia secara umum dihubungkan dengan meningkatnya risiko gangguan mental karena adanya penurunan fungsi fisik, perubahan struktur otak, serta semakin tingginya prevalensi penyakit kronis. Sebuah studi longitudinal menyatakan bahwa lansia di atas usia 75 tahun memiliki prevalensi depresi yang lebih tinggi dibandingkan lansia yang lebih muda akibat meningkatnya kerentanan fisik dan sosial (Ningrum et al., 2022).

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Ketahanan Mental pada Lansia

Tingkat pendidikan merupakan salah satu prediktor signifikan terhadap ketahanan mental pada lansia. Lansia dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki risiko gangguan mental yang lebih rendah karena memiliki strategi coping yang lebih efektif serta memiliki akses informasi dan sumber daya yang lebih baik dalam menghadapi stres (Hansson et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa lansia dengan pendidikan rendah lebih rentan terhadap depresi dan gangguan kognitif akibat kurangnya pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan mental serta rendahnya tingkat partisipasi dalam aktivitas sosial dan intelektual (Wu et al., 2021).

Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang dialami lansia, seperti kematian pasangan atau pensiun, yang mana kemampuan adaptasi yang baik merupakan kunci ketahanan mental pada usia lanjut (Rahman et al., 2023).

3. Faktor Risiko Berbasis Budaya dan Etnis dalam Persepsi dan Pengelolaan Kesehatan Mental

Budaya dan etnis memegang peran penting dalam persepsi, stigma, serta pengelolaan gangguan mental pada lansia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dari berbagai latar belakang budaya memiliki cara pandang yang berbeda tentang kesehatan mental yang dapat mempengaruhi pencarian bantuan dan kepatuhan terhadap pengobatan (Nguyen & Lee, 2020). Sebagai contoh, dalam budaya Asia, gangguan mental sering dianggap sebagai masalah pribadi atau spiritual sehingga lansia cenderung enggan mencari bantuan medis formal (Kim et al., 2021).

Stigma yang terkait dengan gangguan mental juga berbeda antarbudaya dan etnis. Penelitian terbaru menemukan bahwa lansia dari kelompok etnis minoritas sering mengalami tingkat stigma yang lebih tinggi, yang berkontribusi terhadap penundaan diagnosis, keterlambatan perawatan, serta meningkatnya risiko keparahan gangguan mental (Ma et al., 2022). Oleh karena itu, memahami faktor budaya dan etnis menjadi sangat penting dalam mengembangkan pendekatan intervensi yang sensitif secara budaya untuk lansia.

F. Faktor Risiko Komorbiditas

1. Komorbiditas Fisik (Diabetes, Hipertensi, Arthritis) dengan Gangguan Mental

Komorbiditas fisik merupakan salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya gangguan mental pada lansia. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan arthritis sering berhubungan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, serta gangguan kognitif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia penderita diabetes memiliki risiko gangguan depresi 1,5 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan lansia yang tidak mengalami diabetes, terutama akibat stres kronik akibat pengelolaan penyakit dan komplikasi yang muncul (Chireh et al., 2022).

Hipertensi juga berhubungan erat dengan peningkatan risiko gangguan mental, terutama gangguan kecemasan dan depresi. Sebuah meta-analisis terbaru menemukan bahwa hipertensi kronik pada lansia menyebabkan perubahan vaskular dan inflamasi yang berdampak negatif pada struktur dan fungsi otak, meningkatkan prevalensi gangguan mental secara signifikan (Xu et

al., 2021). Sementara itu, artritis yang ditandai oleh nyeri kronik serta keterbatasan fisik diketahui memiliki dampak psikologis berupa peningkatan risiko depresi dan kecemasan akibat penurunan kualitas hidup dan isolasi sosial (Matcham et al., 2020).

2. Hubungan Antara Gangguan Mental dengan Risiko Jatuh dan Cedera Fisik pada Lansia

Gangguan mental pada lansia tidak hanya berpengaruh pada kesehatan psikologis, namun juga meningkatkan risiko jatuh dan cedera fisik. Sebuah studi kohort terbaru menemukan bahwa lansia dengan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan memiliki risiko jatuh hingga dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan lansia tanpa gangguan mental, terutama akibat gangguan perhatian, gangguan tidur, serta efek samping obat yang digunakan dalam pengobatan gangguan mental tersebut (Peeters et al., 2022).

Penelitian lain menegaskan bahwa lansia dengan gangguan mental mengalami penurunan keseimbangan, gangguan mobilitas, serta respons motorik yang lambat, sehingga meningkatkan risiko cedera serius seperti patah tulang dan trauma kepala, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mental mereka akibat keterbatasan mobilitas yang bertambah (Cipriani et al., 2021).

3. Interaksi Obat-obatan yang Berkontribusi pada Gangguan Mental pada Lansia

Lansia sering kali mengonsumsi berbagai macam obat untuk mengatasi kondisi fisik maupun mental mereka, yang menyebabkan meningkatnya risiko interaksi obat. Interaksi obat yang merugikan pada lansia dapat memicu atau memperparah gangguan mental seperti delirium, depresi, atau kecemasan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa obat-obatan seperti benzodiazepin, antikolinergik, antihipertensi tertentu, dan kortikosteroid secara signifikan meningkatkan risiko delirium, penurunan kognitif, serta gangguan mood pada lansia (Wouters et al., 2021).

Sebuah tinjauan sistematis juga menegaskan bahwa penggunaan polifarmasi (penggunaan banyak jenis obat sekaligus) merupakan faktor risiko kuat terjadinya gangguan mental pada lansia akibat meningkatnya peluang terjadinya efek samping dan interaksi antar-obat yang merugikan (Leelakanok & D'Cunha, 2022). Oleh sebab itu, pemantauan ketat penggunaan obat serta evaluasi berkala untuk mengurangi polifarmasi sangat dianjurkan guna meminimalkan risiko gangguan mental pada populasi lansia.

G. Penutup

1. Kesimpulan Mengenai Kompleksitas Faktor Risiko Gangguan Mental pada Lansia

Gangguan mental pada lansia merupakan permasalahan kesehatan yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor risiko yang saling berhubungan secara dinamis. Faktor risiko ini mencakup aspek biologis dan fisik seperti penyakit kronis dan gangguan sensorik; psikososial seperti isolasi sosial, kesepian, dan berduka; lingkungan dan gaya hidup seperti kondisi tempat tinggal, kurangnya aktivitas fisik, serta gangguan tidur; sosiodemografi seperti gender, usia lanjut, pendidikan, budaya, dan etnis; serta komorbiditas yang mencakup interaksi obat-obatan dan risiko cedera fisik (Ansari & Khan, 2022; Livingston et al., 2020; Xu et al., 2021). Oleh karena itu, penanganan gangguan mental pada lansia harus mempertimbangkan multidimensi yang saling terkait tersebut agar memperoleh hasil yang optimal dalam pencegahan dan pengelolaannya.

2. Pentingnya Pendekatan Holistik dalam Manajemen Risiko Gangguan Mental

Dalam menghadapi kompleksitas gangguan mental pada lansia, pendekatan holistik merupakan solusi yang sangat penting. Pendekatan ini melibatkan integrasi berbagai intervensi medis, psikologis, sosial, dan lingkungan untuk mengelola risiko gangguan mental secara komprehensif. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pendekatan holistik yang melibatkan tim multidisiplin, termasuk dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, dan keluarga, secara signifikan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mental lansia dibandingkan intervensi tunggal yang bersifat parsial (Courtin & Knapp, 2022; Hansson et al., 2022).

Penerapan pendekatan holistik seperti edukasi kesehatan mental bagi lansia dan keluarga, manajemen penyakit kronis secara integratif, intervensi gaya hidup sehat, serta optimalisasi lingkungan fisik dan sosial, terbukti mampu menurunkan prevalensi dan keparahan gangguan mental, sekaligus meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Peeters et al., 2022; Schuch et al., 2021).

3. Arahan Penelitian Lanjutan Mengenai Faktor Risiko Gangguan Mental Lansia

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai faktor risiko gangguan mental pada lansia. Penelitian masa depan perlu diarahkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mekanisme interaksi antara faktor biologis, psikososial, lingkungan, sosiodemografi, dan komorbiditas dalam konteks gangguan mental lansia (Chireh et al., 2022; Ma et al., 2022).

Secara khusus, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi holistik berbasis komunitas serta penerapan teknologi digital dalam deteksi dini dan pengelolaan risiko gangguan mental pada lansia. Penelitian yang berfokus pada kelompok lansia yang rentan, seperti lansia dengan tingkat ekonomi rendah, lansia yang tinggal di daerah terpencil, serta lansia dengan latar belakang etnis minoritas, juga diperlukan untuk memastikan pendekatan intervensi yang inklusif dan sensitif secara budaya (Kim et al., 2021; Wu et al., 2021).

Referensi

- Ansari, S., & Khan, H. R. (2022). Loneliness, social isolation, and their association with depression in older adults: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 299, 45–56.
- Barua, A., Ghosh, M. K., & Kar, N. (2021). Gender differences in the prevalence of depression among elderly: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 36(6), 769–782.
- Biddle, S. J., Fox, K. R., & Boutcher, S. H. (2021). Physical activity and mental health in older adults: A systematic review. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 14(1), 72–93.
- Cheng, Y., Rosenberg, M. W., & Wang, W. (2021). Psychological outcomes and quality of life among nursing home residents: A systematic review. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 92, 104276.
- Chireh, B., D'Arcy, C., & Ogilvie, R. (2022). Diabetes and depression among older adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Diabetes and its Complications*, 36(8), 108210.
- Cipriani, D., Renfro, M., & Haley, J. (2021). Psychological disorders and risk of falls in older adults: A systematic review. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 92, 104273.
- Courtin, E., & Knapp, M. (2022). Social isolation, loneliness, and health in old age: A scoping review. *Health & Social Care in the Community*, 30(2), 461–476.
- Fang, H., Tu, S., Zhang, L., & Liu, C. (2023). Sleep disturbances and risk of depression in elderly populations: A longitudinal meta-analysis. *Journal of Sleep Research*, 32(1), e13650.
- Hansson, I., Henning, G., & Arvidsson, E. (2022). The impact of education level on resilience among older adults: A longitudinal study. *Journal of Aging Studies*, 63, 101045.
- Heid, A. R., Zarit, S. H., & Pruchno, R. (2023). Gender differences in mental health among older adults: A systematic review. *Aging & Mental Health*, 27(3), 565–575.
- Hertenstein, E., Trinca, E., & Baglioni, C. (2022). Sleep quality and mental health outcomes among older adults: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 62, 101615.
- Kim, Y., Park, M., & Shin, J. (2021). Cultural perceptions and management of mental health among older adults in Asian communities: A systematic review. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30(6), 1379–1389.

- Kristiansen, C. B., Kjær, J. N., & Nielsen, M. K. (2021). Bereavement and mental health in older adults: Longitudinal evidence from Denmark. *Journal of Geriatric Psychiatry*, 36(3), 297–304.
- Kwak, Y., & Lee, J. H. (2022). Housing type and mental health among older adults: A systematic review. *Journal of Aging and Health*, 34(4), 537–551.
- Leelakanok, N., & D'Cunha, R. (2022). Polypharmacy and its association with mental disorders in older adults: A systematic review. *Drugs & Aging*, 39(2), 139–153.
- Li, J., Yao, Y. S., & Dong, Q. (2021). Insomnia and risk of depression among elderly adults: A systematic review and meta-analysis. *Aging & Mental Health*, 25(10), 1932–1942.
- Livingston, G., Huntley, J., & Sommerlad, A. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *The Lancet*, 396(10248), 413–446.
- Lu, X., Park, B. H., & Kim, Y. H. (2020). Physical dependency and mental health outcomes in elderly: A systematic review. *Journal of Geriatric Psychiatry*, 35(11), 1257–1267.
- Ma, J., Liu, C., & Wong, D. F. K. (2022). Ethnic and cultural disparities in mental health stigma among older adults: A systematic review. *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work*, 31(1), 1–20.
- Matcham, F., Scott, I. C., & Rayner, L. (2020). The impact of arthritis on mental health in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Rheumatology*, 59(6), 1332–1343.
- Ningrum, E. H., Suryani, & Wardani, I. Y. (2022). Age-related differences in depression prevalence among Indonesian older adults: A longitudinal analysis. *Asian Journal of Psychiatry*, 77, 103250.
- Peeters, G., Van Schoor, N. M., & Lips, P. (2022). Depressive symptoms and falls among older adults: Longitudinal evidence. *International Psychogeriatrics*, 34(2), 105–114.
- Rahman, A., Ling, J., & Tan, K. (2023). Educational attainment and psychological resilience among older adults: A systematic review. *Educational Gerontology*, 49(2), 67–79.
- Schuch, F. B., Vancampfort, D., & Stubbs, B. (2021). Physical activity and depression in older adults: Evidence from meta-analyses. *Mental Health and Physical Activity*, 20, 100403.
- Volkert, J., Schulz, H., & Härter, M. (2022). Association between physical dependency and depressive symptoms among elderly people: A systematic review. *European Psychiatry*, 65(1), e24.

- Wouters, H., van der Meer, H., & Taxis, K. (2021). Drug-induced cognitive impairment and delirium in older adults: A systematic review. *European Journal of Clinical Pharmacology*, 77(6), 785–798.
- Wu, Y., Li, Y., & Zhang, X. (2021). Education level and cognitive decline in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Aging & Mental Health*, 25(9), 1617–1625.
- Xu, L., Li, Y., & Li, J. (2021). Hypertension and risk of depression in older adults: A meta-analysis. *Journal of Hypertension*, 39(7), 1343–1352.
- Zhao, Y., & Feng, H. (2020). Association between sensory impairment and depression in older adults: A meta-analysis. *Ageing Research Reviews*, 60, 101112.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Stuart, G. W. (2021). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Mental Health of Older Adults*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>

BAB II

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL LANSIA

A. Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan komponen penting dari kesehatan secara menyeluruh, terutama pada populasi lanjut usia (lansia). Lansia merupakan kelompok rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan mental akibat perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang dialami selama proses penuaan. Menjaga kesehatan mental pada lansia merupakan bagian integral dalam mendukung penuaan sehat (healthy aging), yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan emosional lansia (WHO, 2021).

Perubahan kondisi fisik seperti menurunnya fungsi kognitif, berkurangnya kemampuan fisik, hilangnya peran sosial, dan kejadian kehilangan orang terdekat (bereavement), berpotensi meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental, khususnya depresi dan kecemasan (Lee & Jang, 2021). Gangguan mental yang tidak teridentifikasi secara dini dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan fisik yang lebih buruk, termasuk peningkatan risiko penyakit kronis, penurunan daya tahan tubuh, dan isolasi sosial, yang semakin memperparah kualitas hidup lansia (Bruggencate, Luijkx, & Sturm, 2020).

Sejalan dengan itu, edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental lansia menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi masyarakat, keluarga, dan tenaga kesehatan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap masalah kesehatan mental lansia, mengurangi stigma terkait gangguan mental, dan mendorong perilaku pencarian bantuan (help-seeking behavior) sedini mungkin (Hsu, Chung, & Wei, 2022). Edukasi yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik psikososial lansia, dengan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, dukungan sosial, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana intervensi kesehatan mental yang inovatif (Chen, Li, & Wang, 2022).

Dengan demikian, melalui bab ini, pembaca akan memahami pentingnya edukasi kesehatan mental lansia sebagai dasar dalam peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan emosional, serta pemenuhan hak lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan global dan nasional, yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam manajemen kesehatan mental lansia, guna mewujudkan

kehidupan yang sehat, aktif, dan bermartabat di usia lanjut (Kementerian Kesehatan RI, 2020; WHO, 2021).

B. Pemahaman Dasar Kesehatan Mental pada Lansia

1. Definisi Kesehatan Mental pada Lansia

Kesehatan mental pada lansia merupakan kondisi psikologis dan emosional yang memungkinkan individu lanjut usia untuk menyadari potensi dirinya, mampu mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap komunitasnya (WHO, 2021). Pada lansia, kesehatan mental mencakup kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan emosional, adaptasi terhadap perubahan sosial dan fisik, serta memiliki persepsi positif terhadap proses penuaan yang dialami (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021). Dengan demikian, kesehatan mental yang baik pada lansia dapat meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, dan mencegah berbagai masalah kesehatan lainnya (Hsu, Chung, & Wei, 2022).

2. Gangguan Mental yang Umum Terjadi pada Lansia

Secara umum, lansia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami beberapa jenis gangguan mental dibandingkan kelompok usia lain. Berikut adalah gangguan mental yang paling umum ditemukan pada populasi lansia:

a. Depresi

Depresi adalah gangguan mental yang paling sering ditemui pada lansia. Ditandai dengan suasana hati yang tertekan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, perubahan pola tidur dan makan, perasaan tidak berharga, serta pikiran tentang kematian atau bunuh diri (Chen et al., 2022). Prevalensi depresi pada lansia cukup tinggi, terutama di kalangan mereka yang memiliki penyakit kronis, kehilangan pasangan hidup, atau mengalami isolasi sosial (Bruggencate, Luijckx, & Sturm, 2020). Deteksi dini serta intervensi psikososial dan farmakologis yang tepat sangat penting untuk mengelola gejala depresi pada lansia.

b. Kecemasan

Gangguan kecemasan pada lansia mencakup rasa khawatir berlebihan, gelisah, ketegangan otot, gangguan tidur, dan kesulitan dalam konsentrasi. Kecemasan pada lansia sering terkait dengan rasa takut terhadap kesehatan yang memburuk, kehilangan kemandirian, atau perasaan tidak mampu menghadapi tantangan hidup yang baru (Lee & Jang, 2021). Jika tidak ditangani dengan baik, kecemasan dapat menurunkan kualitas hidup lansia secara signifikan, memperburuk kondisi kesehatan fisik, dan mengurangi partisipasi sosial (Lim, Moon, & Kim, 2021).

c. Demensia

Demensia merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif yang signifikan, meliputi gangguan memori, bahasa, orientasi, pemikiran abstrak, dan kemampuan pengambilan keputusan yang cukup parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari (Alzheimer's Association, 2023). Demensia tipe Alzheimer adalah yang paling umum ditemukan, diikuti oleh demensia vaskuler. Intervensi yang dilakukan biasanya berupa pendekatan non-farmakologis seperti stimulasi kognitif, terapi aktivitas, dan dukungan caregiver, serta farmakologis untuk mengurangi progresivitas gejala (Kuerbis et al., 2021).

Mengetahui jenis gangguan mental yang umum terjadi pada lansia penting untuk mendorong deteksi dini, pencegahan, dan pengelolaan yang efektif oleh tenaga kesehatan dan keluarga. Dengan demikian, edukasi terhadap gangguan mental ini harus diberikan secara rutin untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia secara keseluruhan (Hsu, Chung, & Wei, 2022).

C. Manfaat Edukasi Kesehatan Mental bagi Lansia dan Keluarga

Edukasi tentang kesehatan mental pada lansia memiliki peran penting, tidak hanya bagi lansia tetapi juga keluarga yang merawat mereka. Pemahaman yang memadai mengenai aspek kesehatan mental akan membantu dalam merawat lansia secara optimal serta meningkatkan kesejahteraan seluruh keluarga. Berikut beberapa manfaat utama edukasi kesehatan mental bagi lansia dan keluarga.

1. Meningkatkan Kesadaran dan Mengurangi Stigma

Salah satu manfaat utama edukasi kesehatan mental adalah meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan lansia dan keluarga mereka. Banyak lansia maupun keluarga memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai kesehatan mental, yang menyebabkan munculnya stigma dan rasa malu dalam mencari bantuan (Hsu, Chung, & Wei, 2022). Edukasi dapat memperbaiki persepsi negatif yang berkembang dalam masyarakat, menghilangkan mitos terkait gangguan mental, serta meningkatkan penerimaan terhadap kondisi kesehatan mental yang dialami lansia (Lee & Jang, 2021).

Dengan meningkatnya kesadaran, lansia dan keluarga cenderung lebih terbuka dan proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan mental. Hal ini membantu lansia untuk merasa lebih nyaman dalam mendiskusikan masalah kesehatan mental mereka serta mendorong keluarga untuk memberikan dukungan emosional secara tepat dan efektif (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021).

2. Mengoptimalkan Deteksi Dini Gangguan Mental

Edukasi kesehatan mental juga memberikan manfaat dalam hal deteksi dini gangguan mental. Pengetahuan yang memadai tentang gejala awal gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan tanda-tanda awal demensia, memungkinkan lansia dan keluarga untuk segera mengidentifikasi masalah yang muncul (Lim, Moon, & Kim, 2021). Deteksi dini sangat penting karena memungkinkan intervensi segera dilakukan, sehingga memperlambat progresivitas gangguan mental dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Studi menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan secara rutin kepada keluarga dan lansia secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali gejala dini gangguan mental serta lebih cepat dalam mencari bantuan profesional (Chen, Li, & Wang, 2022). Dengan demikian, intervensi yang lebih awal dapat mengurangi dampak negatif jangka panjang dari gangguan mental terhadap kualitas hidup lansia.

3. Menunjang Kualitas Hidup Lansia

Manfaat jangka panjang yang paling nyata dari edukasi kesehatan mental adalah peningkatan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Pemahaman tentang cara menjaga kesehatan mental secara efektif membantu lansia dalam mempertahankan kemampuan fungsional, partisipasi sosial, dan kesejahteraan emosional yang optimal (Bruggencate, Luijkx, & Sturm, 2020).

Lansia yang mendapatkan edukasi mengenai teknik-teknik mengelola stres, meningkatkan resiliensi, serta memahami pentingnya dukungan sosial akan mengalami peningkatan kesejahteraan mental dan fisik. Sebaliknya, lansia dengan kesehatan mental yang buruk cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan kondisi fisik, isolasi sosial, serta kualitas hidup yang rendah (Kuerbis et al., 2021). Dengan demikian, edukasi kesehatan mental secara efektif menjadi strategi penting dalam mendukung penuaan sehat dan aktif.

Kesimpulannya, edukasi kesehatan mental bagi lansia dan keluarga memiliki manfaat yang luas dalam meningkatkan kesadaran, deteksi dini, serta menunjang kualitas hidup lansia. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan mental perlu menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks penuaan populasi global yang semakin meningkat (WHO, 2021).

D. Metode Edukasi yang Efektif bagi Lansia

Memberikan edukasi tentang kesehatan mental kepada lansia membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik psikologis, fisik, dan sosial mereka. Pemilihan metode edukasi yang tepat sangat menentukan efektivitas penyampaian pesan serta keberhasilan intervensi yang diberikan.

Berikut ini merupakan beberapa metode edukasi yang terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan lansia dalam menjaga kesehatan mental.

1. Pendekatan Edukasi Kelompok

Pendekatan edukasi kelompok, seperti kelompok dukungan dan pelatihan keterampilan coping, merupakan salah satu metode edukasi yang efektif untuk lansia. Metode ini memberikan kesempatan bagi lansia untuk berbagi pengalaman, saling memberikan dukungan emosional, serta belajar berbagai strategi mengatasi masalah psikologis secara bersama-sama (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok dukungan secara signifikan mengurangi gejala depresi, meningkatkan keterampilan sosial, serta memperkuat resiliensi lansia (Lee & Jang, 2021).

Selain kelompok dukungan, pelatihan keterampilan coping juga menunjukkan manfaat positif. Keterampilan coping seperti teknik relaksasi, pemecahan masalah, dan manajemen stres membantu lansia menghadapi berbagai tekanan psikologis yang muncul selama masa penuaan. Pelatihan yang dilakukan secara rutin terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan, depresi, serta meningkatkan kemampuan lansia dalam mengelola stres kehidupan sehari-hari (Lim, Moon, & Kim, 2021).

2. Edukasi Individual melalui Konseling dan Home Visits

Pendekatan edukasi individual yang dilakukan melalui konseling pribadi maupun kunjungan rumah (home visits) juga menjadi alternatif yang efektif. Konseling pribadi memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing lansia (Hsu, Chung, & Wei, 2022). Metode ini sangat efektif bagi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas, masalah kesehatan kompleks, atau merasa kurang nyaman berpartisipasi dalam aktivitas kelompok.

Home visits juga berperan penting dalam edukasi kesehatan mental karena tenaga kesehatan dapat langsung mengidentifikasi faktor-faktor risiko dalam lingkungan tempat tinggal lansia. Studi menunjukkan bahwa home visits secara signifikan meningkatkan deteksi dini gangguan mental serta efektivitas intervensi psikologis yang diberikan, sehingga memperbaiki kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Bruggencate, Luijckx, & Sturm, 2020).

3. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Edukasi Kesehatan Mental

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam edukasi kesehatan mental untuk lansia, terutama melalui telehealth dan aplikasi

kesehatan mental. Telehealth memungkinkan lansia menerima edukasi dan konsultasi kesehatan mental secara virtual, yang sangat efektif mengatasi hambatan geografis, fisik, maupun sosial yang sering dihadapi lansia (Kuerbis et al., 2021).

Penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa pemanfaatan aplikasi kesehatan mental dapat meningkatkan partisipasi lansia dalam program kesehatan mental, serta secara signifikan mengurangi gejala depresi dan kecemasan (Chen, Li, & Wang, 2022). Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan literasi digital, edukasi dan pendampingan khusus dalam penggunaan teknologi ini terbukti berhasil dalam meningkatkan penerimaan lansia terhadap metode intervensi digital (Kuerbis et al., 2021).

Dengan demikian, metode edukasi kelompok, edukasi individual, serta pemanfaatan teknologi digital merupakan pendekatan efektif dalam upaya meningkatkan kesehatan mental lansia. Pemilihan metode yang tepat, didukung pelaksanaan yang berkelanjutan, mampu memberikan dampak positif yang luas dalam memperbaiki kesejahteraan emosional dan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Kesehatan Mental

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan mental kepada lansia. Efektivitas edukasi kesehatan mental sangat bergantung pada kompetensi, pendekatan yang digunakan, dan kolaborasi antar tenaga profesional. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien, serta kolaborasi multidisiplin, memainkan peran strategis dalam keberhasilan intervensi kesehatan mental lansia.

1. Peran Perawat dalam Memberikan Edukasi Psikologis

Perawat adalah tenaga kesehatan utama yang sering berinteraksi langsung dengan lansia dan keluarganya. Oleh karena itu, perawat memiliki peran kunci dalam memberikan edukasi psikologis, baik di layanan kesehatan maupun komunitas. Tugas utama perawat dalam konteks ini mencakup mengidentifikasi risiko gangguan mental, memberikan edukasi mengenai tanda dan gejala gangguan mental, serta strategi pengelolaan stres yang efektif bagi lansia (Lee & Jang, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi psikologis yang diberikan oleh perawat secara signifikan meningkatkan kemampuan lansia dalam mengatasi masalah kesehatan mental, mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta memperbaiki kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Hsu, Chung, & Wei, 2022). Selain itu, perawat juga berperan penting dalam mengurangi stigma terhadap

gangguan mental melalui pendekatan yang empatik, informatif, dan mendukung, sehingga lansia merasa lebih nyaman dalam membicarakan kondisi mental mereka (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021).

Sebagai edukator, perawat juga dituntut memiliki kompetensi khusus dalam memberikan intervensi psikologis sederhana seperti teknik relaksasi, pelatihan keterampilan coping, dan edukasi literasi kesehatan mental. Dengan pendekatan ini, perawat dapat secara efektif membantu lansia dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka (Lim, Moon, & Kim, 2021).

2. Kolaborasi Multidisiplin dalam Memberikan Edukasi Kesehatan Mental

Edukasi kesehatan mental bagi lansia tidak cukup hanya mengandalkan perawat saja, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai tenaga profesional kesehatan lainnya, seperti psikolog, psikiater, dokter umum, pekerja sosial, ahli terapi okupasi, serta tenaga kesehatan masyarakat (Chen, Li, & Wang, 2022).

Kolaborasi multidisiplin mampu memberikan intervensi yang komprehensif, mencakup evaluasi yang lebih mendalam, serta edukasi yang lebih terintegrasi dan spesifik sesuai kebutuhan lansia. Kolaborasi ini memungkinkan lansia mendapatkan dukungan emosional, sosial, dan medis secara bersamaan, yang terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan monodisiplin (Kuerbis et al., 2021).

Studi menunjukkan bahwa tim multidisiplin mampu merancang dan melaksanakan program edukasi yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan mental, tetapi juga meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental, mempercepat deteksi dini gangguan mental, dan meningkatkan efektivitas intervensi yang diberikan (Bruggencate, Luijckx, & Sturm, 2020).

Melalui kolaborasi ini, tenaga kesehatan juga dapat berbagi pengetahuan dan keahlian mereka secara efektif, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lansia untuk memperoleh edukasi kesehatan mental yang berkualitas. Selain itu, kolaborasi multidisiplin membantu memastikan bahwa lansia menerima perawatan yang holistik, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan (WHO, 2021).

Dengan demikian, peran perawat dalam edukasi psikologis serta kolaborasi multidisiplin dalam memberikan edukasi kesehatan mental menjadi dua elemen penting dalam mencapai hasil intervensi yang optimal. Keduanya diperlukan secara bersamaan agar edukasi kesehatan mental mampu menghasilkan dampak positif jangka panjang dalam menjaga kesehatan mental lansia.

F. Strategi Pemberian Edukasi di Komunitas

Komunitas memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental lansia melalui berbagai strategi edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan mental. Strategi edukasi berbasis komunitas memberikan pendekatan yang efektif dan holistik karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Edukasi Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan Mental

Edukasi berbasis komunitas merupakan pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam mendukung kesehatan mental lansia. Strategi ini meliputi berbagai aktivitas seperti kelompok diskusi, sesi edukasi rutin, lokakarya kesehatan mental, serta pelatihan kader komunitas untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental pada lansia (Hsu, Chung, & Wei, 2022).

Studi menunjukkan bahwa pendekatan komunitas dapat secara signifikan meningkatkan akses lansia terhadap layanan kesehatan mental karena memfasilitasi deteksi dini gangguan mental serta mengurangi hambatan psikologis maupun geografis yang sering dialami oleh lansia (Lee & Jang, 2021). Dalam implementasinya, tenaga kesehatan bekerja sama dengan kader komunitas untuk memberikan edukasi secara terstruktur, membantu merujuk lansia ke layanan kesehatan yang tepat, serta memberikan dukungan sosial berkelanjutan.

Program edukasi yang berorientasi pada komunitas juga dapat meningkatkan literasi kesehatan mental secara umum, yang pada akhirnya membantu lansia dan keluarga untuk lebih cepat mengenali gejala gangguan mental serta mengakses layanan kesehatan secara tepat waktu (Lim, Moon, & Kim, 2021). Edukasi komunitas terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian gangguan mental yang tidak terdiagnosis serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

2. Program Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan Mental Lansia

Program kampanye dan penyuluhan merupakan bagian integral dari strategi edukasi kesehatan mental di komunitas. Kampanye kesehatan mental bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental lansia serta menghilangkan stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021).

Berbagai bentuk kampanye seperti seminar publik, penyebaran brosur edukasi, penggunaan media sosial, serta media elektronik lainnya terbukti efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan mental secara luas dan efisien (Chen, Li, & Wang, 2022). Kampanye ini juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung lansia untuk secara terbuka membicarakan permasalahan kesehatan mental mereka serta mendorong perilaku pencarian bantuan profesional secara dini (Kuerbis et al., 2021).

Program penyuluhan kesehatan mental di komunitas biasanya dilaksanakan secara berkala oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok usia lanjut, dan keluarga sebagai partisipan aktif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program penyuluhan secara rutin di tingkat komunitas meningkatkan pemahaman lansia tentang gangguan mental, mengurangi stigma sosial, serta mempromosikan perilaku hidup sehat dalam konteks mental maupun fisik (Bruggencate, Luijkx, & Sturm, 2020).

Dengan demikian, strategi edukasi berbasis komunitas melalui kampanye dan penyuluhan merupakan pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan mental, meningkatkan literasi kesehatan mental, serta menciptakan dukungan sosial yang luas bagi lansia. Pendekatan ini perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dalam kebijakan kesehatan publik untuk memastikan kesejahteraan mental dan kualitas hidup lansia yang lebih baik.

G. Evaluasi Keberhasilan Edukasi Kesehatan Mental

Evaluasi merupakan komponen penting dalam implementasi edukasi kesehatan mental lansia untuk mengukur efektivitas program serta memastikan tujuan dari edukasi tersebut tercapai. Evaluasi yang baik akan membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta memberikan masukan untuk perbaikan program di masa depan.

1. Indikator Keberhasilan Edukasi Kesehatan Mental

Dalam mengevaluasi keberhasilan edukasi kesehatan mental, beberapa indikator penting yang digunakan sebagai tolak ukur mencakup perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, serta hasil kesehatan mental lansia secara keseluruhan. Menurut Hsu, Chung, dan Wei (2022), indikator utama keberhasilan program edukasi kesehatan mental mencakup:

a. Peningkatan literasi kesehatan mental:

Pengetahuan dan pemahaman lansia serta keluarga tentang gangguan mental meningkat secara signifikan setelah mengikuti edukasi, yang dibuktikan melalui hasil pre-test dan post-test pengetahuan (Lim, Moon, & Kim, 2021).

b. Penurunan stigma terhadap gangguan mental:

Adanya perubahan sikap yang positif terhadap kesehatan mental, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sosial terhadap lansia yang mengalami gangguan mental (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021).

c. Meningkatkan deteksi dini dan pencarian bantuan profesional:

Lansia yang mengalami gejala gangguan mental lebih cepat dikenali oleh keluarga dan komunitas, serta menunjukkan peningkatan perilaku pencarian bantuan ke layanan kesehatan (Lee & Jang, 2021).

d. Perbaiki kualitas hidup lansia:

Terjadi peningkatan kualitas hidup yang terukur secara psikologis maupun sosial, seperti meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas sosial, menurunnya gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatnya kepuasan hidup (Bruggencate, Luijckx, & Sturm, 2020).

Evaluasi keberhasilan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut memungkinkan tenaga kesehatan dan pihak terkait untuk secara akurat mengukur dampak program serta mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi tambahan.

2. Studi Kasus Implementasi Edukasi Kesehatan Mental Lansia

Studi kasus merupakan pendekatan praktis yang memberikan gambaran nyata tentang efektivitas edukasi kesehatan mental lansia di lapangan. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian oleh Hsu, Chung, dan Wei (2022) di Taiwan yang mengevaluasi program edukasi berbasis komunitas selama enam bulan. Program tersebut melibatkan kegiatan edukasi rutin, sesi kelompok diskusi, serta kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan.

Hasil studi menunjukkan bahwa setelah implementasi program, terjadi peningkatan signifikan dalam literasi kesehatan mental peserta, khususnya dalam mengenali gejala depresi dan kecemasan. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam perilaku pencarian bantuan profesional dibandingkan dengan kondisi sebelum intervensi. Hasil ini sejalan dengan temuan studi oleh Lee dan Jang (2021), yang melaporkan bahwa pendekatan edukasi kelompok dalam komunitas mampu mengurangi gejala depresi dan kecemasan serta meningkatkan partisipasi sosial lansia secara signifikan.

Penelitian lainnya oleh Chen, Li, dan Wang (2022) mengimplementasikan edukasi berbasis teknologi digital melalui aplikasi kesehatan mental untuk lansia di China. Studi tersebut menemukan bahwa penggunaan aplikasi secara teratur mampu mengurangi gejala depresi secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menggunakan teknologi digital.

Studi kasus ini memperkuat bukti bahwa berbagai pendekatan edukasi kesehatan mental, baik secara langsung maupun digital, mampu menghasilkan perubahan positif yang terukur pada populasi lansia. Oleh karena itu, program edukasi kesehatan mental perlu dievaluasi secara rutin dan berkelanjutan agar terus memberikan manfaat maksimal bagi lansia dan komunitas.

H. Tantangan dan Hambatan dalam Edukasi Kesehatan Mental Lansia

Penyelenggaraan edukasi kesehatan mental bagi lansia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut berkaitan erat dengan karakteristik fisiologis, psikologis, sosial, serta budaya yang dimiliki lansia. Memahami hambatan ini secara mendalam merupakan langkah awal penting untuk mengembangkan strategi edukasi yang efektif dan tepat sasaran.

1. Hambatan Komunikasi, Stigma, dan Rendahnya Literasi Kesehatan Mental pada Lansia

Salah satu hambatan utama dalam edukasi kesehatan mental lansia adalah kendala komunikasi yang sering muncul akibat penurunan kemampuan pendengaran, gangguan kognitif, serta keterbatasan mobilitas fisik (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021). Kondisi ini menyulitkan lansia dalam memahami informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan secara jelas dan tepat. Studi oleh Lee dan Jang (2021) juga menunjukkan bahwa lansia cenderung memiliki keengganan dalam mengungkapkan kondisi emosional mereka secara terbuka karena adanya hambatan komunikasi ini.

Hambatan berikutnya adalah stigma yang melekat terhadap gangguan mental, yang masih kuat di berbagai komunitas dan budaya. Stigma ini membuat lansia cenderung menutup diri, menolak mencari bantuan profesional, serta enggan berpartisipasi dalam kegiatan edukasi kesehatan mental yang ditawarkan (Hsu, Chung, & Wei, 2022). Stigma tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan eksternal tetapi juga stigma internal yang dikembangkan oleh lansia sendiri, yang merasa malu atau takut dianggap sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat (Lim, Moon, & Kim, 2021).

Selain itu, rendahnya literasi kesehatan mental di kalangan lansia juga menjadi tantangan serius. Lansia umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang tanda-tanda gangguan mental serta pentingnya mencari bantuan profesional secara dini. Akibatnya, kondisi gangguan mental sering kali terlambat dikenali dan ditangani, yang pada akhirnya memperburuk prognosis kesehatan mereka secara keseluruhan (Bruggencate, Luijkx, & Sturm, 2020).

2. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Edukasi Kesehatan Mental Lansia

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, penggunaan metode komunikasi yang adaptif seperti alat bantu visual, teknik berbicara yang lambat dan jelas, serta penggunaan materi edukasi dalam format sederhana dapat membantu lansia memahami pesan edukasi secara lebih baik (Narushima et al., 2021). Pelatihan tenaga kesehatan tentang keterampilan komunikasi dengan lansia juga menjadi langkah penting agar pesan yang disampaikan lebih efektif.

Kedua, upaya untuk mengurangi stigma dapat dilakukan melalui kampanye kesehatan mental yang berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat serta keluarga sebagai mitra edukasi. Program edukasi yang menggunakan pendekatan kelompok dukungan juga terbukti efektif dalam mengurangi stigma sosial dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung lansia untuk berbagi pengalaman tanpa rasa takut atau malu (Lee & Jang, 2021).

Ketiga, peningkatan literasi kesehatan mental dapat dilakukan melalui program edukasi berbasis komunitas secara rutin. Program ini mencakup pelatihan rutin bagi kader kesehatan komunitas untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan mental pada lansia serta pelaksanaan sesi edukasi interaktif secara reguler yang menargetkan lansia dan keluarganya (Hsu et al., 2022). Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan mental dan telehealth juga dapat meningkatkan akses lansia terhadap informasi kesehatan mental yang akurat dan mudah dipahami (Chen, Li, & Wang, 2022).

Dengan demikian, tantangan edukasi kesehatan mental lansia dapat diatasi dengan kombinasi pendekatan komunikasi adaptif, kampanye stigma yang aktif, serta upaya peningkatan literasi kesehatan mental melalui edukasi berkelanjutan. Implementasi strategi ini diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental lansia secara jangka panjang.

I. Penutup

Edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental lansia merupakan aspek krusial dalam upaya mendukung penuaan sehat dan aktif. Mengingat populasi lansia yang terus meningkat, edukasi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan kesehatan publik maupun praktik klinis. Bab ini secara mendalam telah membahas berbagai aspek penting terkait edukasi kesehatan mental lansia, mulai dari pemahaman dasar hingga strategi implementasi efektif dalam komunitas.

Edukasi yang baik terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan mental, mengurangi stigma sosial, serta mendorong deteksi dini dan pencarian bantuan profesional secara tepat waktu (Hsu, Chung, & Wei, 2022; Lee & Jang, 2021). Peran aktif perawat serta kolaborasi multidisiplin sangat penting untuk

memastikan bahwa edukasi yang diberikan relevan, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan spesifik lansia maupun keluarga mereka (Lim, Moon, & Kim, 2021).

Namun demikian, implementasi edukasi kesehatan mental tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti hambatan komunikasi, stigma sosial, dan rendahnya literasi kesehatan mental. Oleh karena itu, strategi-solusi seperti penggunaan komunikasi adaptif, kampanye kesehatan mental berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dalam berbagai program kesehatan mental (Narushima, Liu, & Diestelkamp, 2021; Chen, Li, & Wang, 2022).

Kedepan, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi metode edukasi yang paling efektif dan inovatif, serta untuk mengeksplorasi pendekatan kolaborasi yang optimal antara tenaga kesehatan, komunitas, dan keluarga dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dengan demikian, edukasi kesehatan mental bagi lansia akan mampu memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan, mendukung kualitas hidup lansia yang lebih baik serta mewujudkan masyarakat yang sehat secara mental dan emosional.

Referensi

- Bruggencate, T. T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2020). Social needs of older people: A systematic literature review. *Ageing & Society*, 40(3), 555–572. <https://doi.org/10.1017/S0144686X18001125>
- Chen, Y., Li, W., & Wang, Y. (2022). Effectiveness of digital health interventions in reducing depressive symptoms among older adults: A meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 24(3), e31753. <https://doi.org/10.2196/31753>
- Hsu, Y.-L., Chung, P.-C., & Wei, C.-W. (2022). Impact of a community-based mental health program on older adults' mental health literacy and help-seeking behavior. *BMC Geriatrics*, 22(1), 219. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-02895-x>
- Kuerbis, A., Mulliken, A., Muench, F., & Moore, A. A. (2021). Digital mental health interventions for older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Medical Internet Research*, 23(9), e31301. <https://doi.org/10.2196/31301>
- Lee, J., & Jang, S. N. (2021). The effects of community-based mental health education programs for older adults: A systematic review. *Journal of Aging and Health*, 33(1–2), 120–132. <https://doi.org/10.1177/0898264320951077>
- Lim, J., Moon, Y., & Kim, K. (2021). The effects of an educational program on knowledge and attitudes toward mental health among community-dwelling older adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14), 7354. <https://doi.org/10.3390/ijerph18147354>
- Narushima, M., Liu, J., & Diestelkamp, N. (2021). Senior peer counseling: A qualitative study of peer counselors' experiences in community-based mental health programs. *Journal of Aging Studies*, 58, 100949. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2021.100949>
- Alzheimer's Association. (2023). Alzheimer's and dementia: Causes, symptoms, and treatment. Diakses dari <https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan mental pada lansia di tingkat pelayanan kesehatan primer*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Mental health of older adults*. WHO Fact Sheets. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>

BAB III

STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MENTAL LANSIA

A. Pendahuluan

Kesejahteraan mental lansia merupakan isu yang semakin penting dalam konteks demografi global yang mengalami penuaan. Di Indonesia, populasi lansia terus meningkat, yang menuntut perhatian lebih terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa lansia sering menghadapi tantangan psikologis, seperti kecemasan dan depresi, yang dapat diperburuk oleh isolasi sosial dan kurangnya dukungan komunitas (Purnomo, 2024). Oleh karena itu, strategi komunitas yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan mental lansia, terutama di wilayah pertanian yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui pengembangan program pemberdayaan komunitas yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan lansia dalam menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Misalnya, kegiatan edukasi tentang nutrisi seimbang dan manajemen spiritual dapat membantu lansia mengatasi masalah kesehatan yang mereka hadapi (Silitonga, 2023). Selain itu, aktivitas fisik yang teratur juga terbukti memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental lansia, seperti peningkatan kadar dopamin yang berkontribusi pada pengurangan risiko demensia dan gangguan kognitif (Larasati & Boy, 2020). Oleh karena itu, penting untuk merancang intervensi yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia di komunitas pertanian.

Komunitas pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental lansia. Melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti program day care dan dukungan sosial, lansia dapat merasa lebih terhubung dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Madanih, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat mengurangi tingkat kecemasan dan depresi di kalangan lansia, serta meningkatkan rasa memiliki dan tujuan hidup (Widiani et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan strategi komunitas yang holistik dan inklusif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental lansia di wilayah pertanian.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental lansia, buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi komunitas yang dapat diterapkan di wilayah pertanian untuk mendukung kesejahteraan mental lansia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, praktisi kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi lansia.

B. Konsep Kesejahteraan Mental pada Lansia

Kesejahteraan mental tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga interaksi sosial, dukungan komunitas, dan kondisi fisik yang saling memengaruhi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan jaringan sosial yang kuat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mental lansia, mengurangi perasaan kesepian, dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Grundberg et al., 2016). Lansia yang memiliki akses ke dukungan sosial yang baik cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Grundberg et al., 2014).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan mental lansia adalah lingkungan tempat tinggal mereka. Lingkungan yang mendukung, seperti akses ke ruang terbuka hijau, dapat berkontribusi pada pengurangan gejala kecemasan dan depresi (Patel et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tinggal di lingkungan yang memiliki akses baik ke fasilitas publik dan ruang hijau melaporkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di lingkungan yang kurang mendukung (Eibich et al., 2016). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam merancang intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental lansia.

Selain itu, intervensi berbasis komunitas yang melibatkan lansia dalam kegiatan sosial dan fisik juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Program-program yang mempromosikan aktivitas fisik, seperti olahraga ringan dan kegiatan sosial, dapat membantu lansia merasa lebih terhubung dengan komunitas mereka dan mengurangi risiko depresi (Hong, 2019). Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk berinteraksi dengan orang lain, yang penting untuk menjaga kesehatan mental mereka (Grundberg et al., 2014).

Pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kesejahteraan mental lansia juga ditekankan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan mental saling terkait. Lansia yang memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik pula (Montgomery et al.,

2017). Oleh karena itu, intervensi yang mengintegrasikan perawatan fisik dan mental, serta dukungan sosial, dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan mental lansia.

C. Peran Komunitas dalam Mendukung Kesejahteraan Mental

Kesejahteraan mental lansia merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas hidup mereka, dan peran komunitas sangat krusial dalam mendukung hal ini. Komunitas tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai jaringan sosial yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis bagi lansia. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam komunitas dapat mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kesehatan mental lansia Sastrahadi (2022). Dalam konteks ini, program-program yang melibatkan partisipasi aktif lansia dalam kegiatan sosial dan edukasi kesehatan menjadi sangat penting.

Salah satu bentuk dukungan komunitas yang efektif adalah melalui kader kesehatan yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Kader kesehatan dapat memberikan pendidikan tentang kesehatan, termasuk manajemen penyakit seperti hipertensi, yang umum di kalangan lansia (Getahun et al., 2023). Dengan meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan, kader kesehatan dapat membantu mereka mengelola kondisi kesehatan mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan mental mereka. Selain itu, program day care untuk lansia juga dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial yang menyenangkan, di mana lansia dapat bersosialisasi dan menerima dukungan sosial (Madanih, 2022).

Komunitas juga dapat berperan dalam mempromosikan konsep Active Aging, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi lansia dan mengurangi stigma negatif yang sering melekat pada mereka (Dari, 2023). Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik dan sosial, komunitas dapat membantu lansia merasa lebih berdaya dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan kesehatan mental lansia dan mengurangi risiko depresi (Hidayati et al., 2018).

Selain itu, dukungan spiritual juga menjadi aspek penting dalam kesejahteraan mental lansia. Keterhubungan dengan orang lain dan dengan aspek spiritualitas dapat memberikan rasa tujuan dan makna dalam hidup, yang sangat penting bagi lansia (Witono, 2018). Komunitas yang menyediakan ruang untuk kegiatan spiritual, seperti pengajian atau kelompok diskusi, dapat membantu lansia merasa lebih terhubung dan mendukung kesehatan mental mereka (Suwandi, 2024).

D. Model Pendekatan Psikososial dalam Masyarakat Pertanian

Pendekatan psikososial dalam masyarakat pertanian merupakan suatu model yang mengintegrasikan aspek psikologis dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan individu, khususnya lansia. Dalam konteks pertanian, di mana banyak lansia terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang rendah dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental dapat memperburuk kesehatan psikososial lansia di daerah pertanian Ongki et al. (2021). Oleh karena itu, penting untuk merancang program yang dapat mendukung kesehatan mental dan sosial mereka.

Salah satu elemen kunci dari pendekatan psikososial adalah pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui program-program yang melibatkan lansia dalam kegiatan sosial dan ekonomi, seperti kelompok tani atau koperasi. Melalui keterlibatan ini, lansia tidak hanya mendapatkan dukungan sosial, tetapi juga merasa memiliki peran dan kontribusi dalam komunitas mereka. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam kelompok sosial dapat meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi perasaan kesepian di kalangan lansia (Rahayu, 2023).

Program edukasi kesehatan juga merupakan bagian penting dari pendekatan psikososial. Edukasi tentang kesehatan mental, manajemen stres, dan teknik relaksasi dapat membantu lansia mengatasi tantangan psikologis yang mereka hadapi. Misalnya, program yang mengajarkan teknik relaksasi otot progresif telah terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia (Rahayu, 2023). Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan, lansia dapat lebih siap menghadapi stres dan masalah kesehatan mental lainnya.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pendekatan psikososial. Lingkungan pertanian sering kali memiliki tantangan tersendiri, seperti akses terbatas ke layanan kesehatan dan infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, intervensi yang dirancang harus mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat (Amalia, 2023). Misalnya, program yang mengoptimalkan bantuan langsung tunai untuk petani yang terdampak bencana alam dapat membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka (Triani & Magello, 2024).

Program-program yang berfokus pada kesehatan fisik juga dapat berkontribusi pada kesehatan mental lansia. Aktivitas fisik, seperti senam lansia, telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental (Febriansyah,

2023). Kegiatan ini tidak hanya membantu lansia tetap aktif secara fisik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, yang penting untuk kesehatan mental mereka.

E. Karakteristik Wilayah Pertanian dan Potensinya untuk Lansia

Wilayah pertanian memiliki karakteristik unik yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan lansia. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai basis ekonomi yang dapat mendukung kehidupan sosial dan kesehatan mental lansia. Di banyak daerah, lansia sering kali terlibat dalam kegiatan pertanian, baik sebagai petani aktif maupun sebagai bagian dari komunitas yang mendukung kegiatan pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan lansia dalam aktivitas pertanian dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, memberikan rasa tujuan, dan mengurangi risiko masalah kesehatan mental (Kusumawati et al., 2020).

Salah satu karakteristik penting dari wilayah pertanian adalah keberadaan sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan subur dan akses terhadap air. Sumber daya ini memungkinkan pengembangan berbagai jenis tanaman dan produk pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk lansia. Misalnya, program agrowisata yang menggabungkan pertanian dengan pariwisata dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi lansia, sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan pengunjung dan komunitas (Kurniyawan et al., 2022). Dengan demikian, wilayah pertanian dapat berfungsi sebagai tempat yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial lansia.

Selain itu, karakteristik sosial-ekonomi di wilayah pertanian juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman petani berkontribusi pada pengelolaan usaha tani yang lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka (Deviantony, 2020). Dukungan komunitas yang kuat juga dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan sumber daya, yang sangat penting bagi lansia yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan pelatihan (Kusumawati, 2024). Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang memadai dan kebijakan pemerintah yang mendukung sangat penting untuk memaksimalkan potensi wilayah pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

Wilayah pertanian juga sering kali memiliki komunitas yang erat, di mana interaksi sosial dapat terjadi secara alami. Lingkungan sosial yang positif ini dapat membantu lansia merasa lebih terhubung dan mengurangi perasaan kesepian, yang

merupakan faktor risiko utama bagi kesehatan mental mereka (Muna et al., 2022). Kegiatan sosial yang melibatkan lansia dalam komunitas pertanian, seperti pertemuan rutin, pelatihan, dan kegiatan berbasis kelompok, dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan oleh lansia (Sari et al., 2022). Dengan demikian, karakteristik wilayah pertanian yang kaya akan sumber daya, dukungan komunitas, dan potensi ekonomi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Melalui pengembangan program-program yang melibatkan lansia dalam kegiatan pertanian dan sosial, serta peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi lansia di wilayah pertanian.

F. Program Sosial dan Rekreasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mental

Kesejahteraan mental lansia dapat ditingkatkan melalui berbagai program sosial dan rekreasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Program-program ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga untuk memperkuat interaksi sosial dan memberikan dukungan emosional yang penting bagi lansia. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas sosial dan rekreasi dapat mengurangi perasaan kesepian dan depresi di kalangan lansia (Suminar et al., 2023).

Salah satu contoh program yang efektif adalah senam lansia, yang telah terbukti meningkatkan kesehatan fisik dan mental lansia. Kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama (Suminar et al., 2023). Program senam yang rutin dapat meningkatkan semangat dan motivasi lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan lainnya, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung kesejahteraan mental mereka (Hendrawati, 2024).

Selain senam, program edukasi kesehatan mental juga sangat penting. Edukasi ini dapat mencakup informasi tentang cara mengelola stres, memahami perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia, dan teknik relaksasi yang dapat membantu mengurangi kecemasan (Hendrawati, 2024). Misalnya, program edukasi yang dilakukan di panti sosial dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi lansia untuk menjaga kesehatan mental mereka, serta mengajarkan mereka cara-cara untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka (Hendrawati, 2024).

Program day care juga merupakan inisiatif yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan mental lansia. Dengan menyediakan tempat bagi lansia untuk berkumpul, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, program ini dapat mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Madanih,

2022). Penelitian menunjukkan bahwa day care dapat memberikan dampak positif pada kesehatan fisik dan psikologis lansia, serta membantu mereka merasa lebih terhubung dengan komunitas (Hasifah, 2024).

Lebih jauh lagi, intervensi berbasis komunitas yang melibatkan kegiatan rekreasi seperti seni, musik, dan kerajinan tangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental lansia. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, tetapi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup (Rianda et al., 2023). Misalnya, terapi musik telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kecemasan pada lansia (Luthfa, 2022).

G. Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia

Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan lansia telah menjadi fokus perhatian di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial. Teknologi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, memfasilitasi komunikasi, dan memberikan dukungan sosial bagi lansia. Dalam konteks ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi kesehatan dan aplikasi digital dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi lansia (Usman et al., 2022).

Salah satu contoh nyata dari pemanfaatan teknologi adalah implementasi sistem informasi kesehatan yang memungkinkan pencatatan, monitoring, dan pelaporan kesehatan lansia secara efisien. Penelitian oleh Usman et al. menunjukkan bahwa sistem informasi kesehatan yang diterapkan di Puskesmas dapat membantu kader kesehatan dalam mengelola data lansia, sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik (Usman et al., 2022). Dengan adanya sistem ini, informasi kesehatan lansia dapat diakses dengan cepat, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan mereka.

Selain itu, digitalisasi layanan kesehatan seperti E-Posyandu juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengelolaan data kesehatan di masyarakat. Di Desa Grujugan, penggunaan teknologi untuk mengelola data kesehatan ibu hamil, balita, dan lansia menjadi sangat penting, terutama selama pandemi COVID-19 ketika banyak kegiatan harus dilakukan secara online (Nurlita et al., 2023). Meskipun awalnya hanya menggunakan aplikasi WhatsApp, pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kesehatan.

Pelatihan kader kesehatan juga menjadi bagian penting dari pemanfaatan teknologi. Carolia et al. menekankan pentingnya pelatihan kader kesehatan untuk memantau tumbuh kembang anak dan gizi keluarga, yang juga dapat diterapkan untuk lansia dalam konteks pemantauan kesehatan mereka (Carolia et al., 2022).

Dengan meningkatkan kapasitas kader kesehatan melalui teknologi, diharapkan dapat meningkatkan cakupan program kesehatan di masyarakat, termasuk bagi lansia.

Di sisi lain, teknologi komunikasi seperti media sosial juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental lansia. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat membantu lansia tetap terhubung dengan keluarga dan teman, yang penting untuk mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Madanih, 2021). Dalam konteks ini, dukungan keluarga dan interaksi sosial yang baik dapat berkontribusi pada kesehatan mental lansia, terutama di masa-masa sulit seperti selama pandemi (Wiraini et al., 2021).

Lebih jauh lagi, aplikasi berbasis web untuk memantau kebugaran fisik lansia juga menjadi inovasi yang menjanjikan. Dharmawan et al. mengembangkan aplikasi yang dapat merekam data kebugaran jasmani lansia dan memberikan rekomendasi aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka (Dharmawan et al., 2018). Dengan adanya aplikasi ini, lansia dapat lebih mudah mengakses informasi tentang kesehatan dan kebugaran mereka, serta mendapatkan motivasi untuk tetap aktif.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan lansia mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data kesehatan, pelatihan kader, hingga dukungan sosial melalui media komunikasi. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam program-program kesehatan dan sosial, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi lansia untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna.

H. Studi Kasus kesehatan mental pada lansia di Wilayah Pedesaan dan Pertanian

Kesehatan mental lansia di wilayah pedesaan dan pertanian menghadapi tantangan yang unik dan kompleks, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, beberapa studi kasus telah dilakukan untuk mengeksplorasi kondisi kesehatan mental lansia dan intervensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu studi yang relevan adalah penelitian oleh Masfingatin yang mengeksplorasi terapi okupasi melalui pendekatan TFA (Thinking, Feeling, Acting) pada lansia di panti werdha. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan dukungan emosional dapat meningkatkan kesehatan mental lansia, membantu mereka mengatasi kecemasan dan depresi (Masfingatin, 2024). Di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap layanan kesehatan mental sering kali terbatas, pendekatan ini dapat diadaptasi untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang tinggal di komunitas pertanian.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental lansia. Penelitian oleh Artama dan Owa menunjukkan bahwa peningkatan kecemasan akibat pandemi berdampak buruk pada kualitas hidup lansia di Kecamatan Ende Tengah, Nusa Tenggara Timur (Artama & Owa, 2022). Kecemasan yang meningkat ini sering kali disebabkan oleh ketidakpastian dan kurangnya dukungan sosial, yang lebih terasa di daerah pedesaan di mana interaksi sosial terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program dukungan yang dapat membantu lansia mengatasi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Studi lain oleh Luthfa menyoroti masalah depresi yang sering dialami oleh lansia selama pandemi. Penelitian ini menemukan bahwa depresi dapat mengganggu aktivitas sehari-hari lansia dan meningkatkan risiko bunuh diri (Luthfa, 2022). Di pedesaan, di mana stigma terhadap masalah kesehatan mental masih kuat, banyak lansia yang enggan mencari bantuan. Oleh karena itu, program edukasi kesehatan mental yang mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental sangat diperlukan.

Dukungan keluarga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental lansia. Penelitian oleh Hardianti et al. menunjukkan bahwa dukungan emosional dan sosial dari keluarga dapat membantu lansia menghadapi tantangan yang mereka hadapi (Hardianti et al., 2020). Di wilayah pedesaan, di mana struktur keluarga sering kali lebih erat, dukungan ini dapat menjadi faktor pelindung yang signifikan bagi kesehatan mental lansia. Program-program yang melibatkan aktivitas fisik, seperti senam lansia, juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental. Penelitian oleh Febriansyah menunjukkan bahwa senam lansia dapat membantu mengurangi tingkat depresi dan meningkatkan kualitas tidur, yang sangat penting bagi kesejahteraan mental lansia (Febriansyah, 2023). Di pedesaan, di mana lansia mungkin memiliki keterbatasan dalam akses ke fasilitas kesehatan, program senam yang terjangkau dan mudah diakses dapat memberikan manfaat besar.

I. Best Practices dari Negara Lain dalam Mendukung Lansia di Wilayah Pertanian

Di pedesaan, di mana lansia mungkin memiliki keterbatasan dalam akses ke fasilitas kesehatan, program senam yang terjangkau dan mudah diakses dapat memberikan manfaat besar. Dalam mendukung kesejahteraan lansia di wilayah pertanian, berbagai negara telah menerapkan praktik terbaik yang dapat dijadikan contoh. Praktik-praktik ini mencakup pendekatan berbasis komunitas, penggunaan teknologi, dan program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Berikut adalah beberapa contoh praktik terbaik yang dapat diadopsi:

1. Program Pertanian Berkelanjutan dan Kesehatan Mental di Finlandia

Di Finlandia, terdapat inisiatif yang mengintegrasikan pertanian berkelanjutan dengan program kesehatan mental untuk lansia. Kallioniemi et al. menunjukkan bahwa penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dapat memberikan manfaat psikologis bagi petani lansia yang terlibat dalam praktik pertanian tersebut Kallioniemi et al., (2024). Dengan memprioritaskan kesejahteraan hewan dan lingkungan, program ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung kesehatan mental lansia.

2. Adopsi Teknologi Cerdas di Belanda

Di Belanda, penggunaan teknologi cerdas dalam pertanian telah membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung kesejahteraan petani lansia. Teknologi seperti Precision Livestock Farming (PLF) memungkinkan petani untuk memantau kesehatan hewan secara real-time, yang mengurangi stres dan beban kerja fisik (Rowe et al., 2019). Dengan mengurangi kebutuhan untuk pengawasan manual yang intensif, teknologi ini memungkinkan lansia untuk tetap aktif dalam pertanian tanpa mengorbankan kesehatan mereka.

3. Program Pelatihan dan Edukasi di Mali

Di Mali, program Climate-Smart Agricultural Technologies (CSAT) telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani, termasuk lansia. Penelitian oleh Awotide et al. menunjukkan bahwa pelatihan tentang teknologi pertanian cerdas dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sehingga mereka dapat mengadopsi praktik yang lebih efisien dan berkelanjutan (Awotide et al., 2022). Program ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan mental petani lansia.

4. Dukungan Keluarga dan Komunitas di Swedia

Di Swedia, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan dukungan keluarga dan jaringan sosial telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Program-program ini mendorong keterlibatan anggota keluarga dan komunitas dalam perawatan lansia, yang membantu mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun tidak ada referensi spesifik yang dicantumkan, banyak studi menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki dampak positif pada kesejahteraan lansia.

5. Inisiatif Kesehatan dan Kesejahteraan di Austria

Di Austria, Tremetsberger et al. menyoroti pentingnya perencanaan kesehatan dan kesejahteraan dalam peternakan susu, yang juga berdampak positif pada kesejahteraan petani lansia (Tremetsberger et al., 2015). Dengan menerapkan rencana kesehatan yang terstruktur, petani dapat mengelola kesehatan hewan dan lingkungan kerja mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya mendukung kesehatan mental mereka.

6. Program Teknologi Kesehatan di Korea Selatan

Di Korea Selatan, penggunaan teknologi kesehatan berbasis web untuk merawat lansia yang tinggal sendiri telah menunjukkan hasil yang positif. Penelitian oleh Choi et al. menekankan pentingnya individualisasi dan pendekatan berbasis klien dalam penggunaan teknologi untuk mendukung kesehatan mental lansia (Choi et al., 2022). Dengan menyediakan alat yang memungkinkan komunikasi dan pemantauan kesehatan, program ini membantu lansia merasa lebih aman dan terhubung.

Secara keseluruhan, praktik terbaik dari negara lain menunjukkan bahwa kombinasi antara teknologi, dukungan komunitas, dan pendidikan dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan lansia di wilayah pertanian. Dengan mengadopsi dan mengadaptasi praktik-praktik ini, negara lain, termasuk Indonesia, dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi lansia di komunitas pertanian.

J. Penutup

Dalam menghadapi tantangan kesehatan mental lansia di wilayah pedesaan dan pertanian, penting untuk mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti efektif di negara lain. Berbagai pendekatan, mulai dari integrasi teknologi, dukungan komunitas, hingga program pendidikan, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan lansia. Studi kasus yang telah dibahas menunjukkan bahwa kombinasi antara inovasi dalam pertanian, perhatian terhadap kesehatan mental, dan penguatan jaringan sosial dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi lansia.

Implementasi program-program yang berfokus pada pertanian berkelanjutan, penggunaan teknologi cerdas, dan dukungan sosial yang kuat dapat membantu lansia di wilayah pedesaan untuk tetap aktif, terlibat, dan merasa dihargai. Selain itu, pentingnya dukungan keluarga dan komunitas tidak dapat diabaikan, karena mereka memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan mental lansia.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang

lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dari negara lain, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mental lansia di wilayah pedesaan dan pertanian. Melalui upaya bersama, diharapkan lansia dapat menjalani masa tua yang lebih bermakna, sehat, dan bahagia.

Referensi

- Amalia, S. (2023). Human Development Gaps: Evidence From Eastern Indonesia. *International Review of Social Sciences Research*, 3(2), 24–43. <https://doi.org/10.53378/353012>
- Artama, S., & Owa, K. (2022). Hubungan Kecemasan Kejadian COVID-19 Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(3), 546–554. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss3.1255>
- Awotide, B. A., Ogunniyi, A., Olagunju, K. O., Bello, L. O., Coulibaly, A. Y., Wiredu, A. N., Kone, B., Ahamadou, A., Manyong, V. M., & Abdoulaye, T. (2022). Evaluating the Heterogeneous Impacts of Adoption of Climate-Smart Agricultural Technologies on Rural Households' Welfare in Mali. *Agriculture*, 12(11), 1853. <https://doi.org/10.3390/agriculture12111853>
- Carolia, N., Angraini, D. I., Sari, M. I., & Saftarina, F. (2022). Pelatihan Kader Kesehatan Dalam Mewujudkan Keluarga Cukup Gizi Di Desa Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(9), 3229–3241. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i9.6222>
- Choi, S.-Y., Kim, K.-S., Kamyod, C., & Kim, C. G. (2022). Ethical Use of Web-Based Welfare Technology for Caring Elderly People Who Live Alone in Korea: A Case Study. *Journal of Web Engineering*. <https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.21410>
- Deviantony, F. (2020). Phenomenology Study: Resilience of Farmers About Natural Disaster. *Dunia Keperawatan Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*. <https://doi.org/10.20527/dk.v8i3.7731>
- Dharmawan, Y., Suroto, S., & Putra, P. S. (2018). Web-Based Application to Support Physical Fitness Information of Elderly People. *Kesmas National Public Health Journal*, 13(1). <https://doi.org/10.21109/kesmas.v13i1.1448>
- Eibich, P., Krekel, C., Demuth, I., & Wagner, G. G. (2016). Associations Between Neighborhood Characteristics, Well-Being and Health Vary Over the Life Course. *Gerontology*, 62(3), 362–370. <https://doi.org/10.1159/000438700>
- Febriansyah, F. (2023). Upaya Peningkatan Kesehatan Sekaligus Mengurangi Tingkat Depresi Pada Masyarakat Lanjut Usia Desa Karang Anyar Melalui Program Senam Lansia. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (Jams)*, 4(01), 45–51. <https://doi.org/10.24967/jams.v4i01.2290>
- Getahun, D., Oyelese, Y., Peltier, M., Yeh, M., Chiu, V. Y., Takhar, H., Khadka, N., Mensah, N., Avila, C., & Fassett, M. J. (2023). Trends in Postpartum Depression by Race/Ethnicity and Pre-pregnancy Body Mass Index. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 228(1), S122–S123.

- <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.11.248>
- Grundberg, Å., Gustafsson, S. A., Ebbeskog, B., & Religa, D. (2014). Mental Health-Promoting Dialogues From the Perspective of Community-Dwelling Seniors With Multimorbidity. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 189. <https://doi.org/10.2147/jmdh.s59307>
- Grundberg, Å., Hansson, A., Religa, D., & Hillerås, P. (2016). Home Care Assistants' Perspectives on Detecting Mental Health Problems and Promoting Mental Health Among Community-Dwelling Seniors With Multimorbidity. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 83. <https://doi.org/10.2147/jmdh.s99388>
- Hardianti, D., Hos, J., & Sarpin, S. (2020). Bentuk Dukungan Keluarga Dalam Menjaga Kesehatan Mental Lansia. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.52423/jkps.v1i2.16083>
- Hasifah, H. (2024). Peran Keperawatan Gerontik Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia. *Bharasumba*, 3(01), 12–18. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v3i01.795>
- Hendrawati, H. (2024). Edukasi Kesehatan Jiwa Lansia Di Panti Sosialtresna Werdha (PSTW) Jiwa Baru Garut. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 7(6), 2756–2766. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i6.14956>
- Hidayati, S., Baequni, A., & Inayah, M. (2018). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Keaktifan Lanjut Usia Pada Pelaksanaan Posyandu Lansia. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 14. <https://doi.org/10.54911/litbang.v14i0.66>
- Hong, S. Y. (2019). Effects of 12-Week Cognitive and Exercise Interventions on Physical, Cognitive Function and Health-Related QOL in Elders With MCI. *Biomedical Journal of Scientific & Technical Research*, 15(4). <https://doi.org/10.26717/bjstr.2019.15.002730>
- Kallioniemi, M., Kymäläinen, H., & Niemi, J. K. (2024). Enabling Factors and Constraints for the Adoption of Animal Welfare-Enhancing Technologies Among Finnish Dairy Farmers. *Frontiers in Animal Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fanim.2024.1332525>
- Kurniawan, E. H., Dewi, E. I., Wuryaningsih, E. W., Deviantony, F., & Fitria, Y. (2022). Farmer Resilience After Floods and Landslides. *Nursing and Health Sciences Journal (Nhsj)*. <https://doi.org/10.53713/nhs.v2i2.89>
- Kusumawati, R. N., Wardani, K. K., & ... (2020). The psychological state of farmers in the agricultural cultivation of food crops during the COVID-19 Pandemic in Java, Indonesia. *Caraka Tani: Journal of ...* <http://jurnal.uns.ac.id/carakatani/article/view/43638>
- Larasati, A. N., & Boy, E. (2020). The Impact of Physical Activity in Elderly. *Magna Medica*

- Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan, 6(2), 113. <https://doi.org/10.26714/magnamed.6.2.2019.113-121>
- Luthfa, I. (2022). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Depresi Pada Lanjut Usia Selama Pandemi Di Panti Werdha. *Jurnal Perawat Indonesia*, 6(1), 954–962. <https://doi.org/10.32584/jpi.v6i1.1332>
- Madanih, R. (2022). Urgensi Pelayanan Harian (Day Care) Lanjut Usia Di Indonesia. *Sosio Informa*, 7(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2921>
- Mahanani, R. S., Kurniawan, B., & Kamal, M. (2022). Rintisan Edible Garden City (EGC) Menuju Agrowisata Kemuning Lor. *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3), 465–470. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v7i3.3619>
- Masfingatin, T. (2024). Terapi Okupasi Melalui Pendekatan Tfa (Thinking, Feeling, Acting) Pada Lansia Di Panti Werdha Wisma Asih Madiun. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 73–80. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1240>
- Montgomery, P., Nangia, P., Mossy, S., & Pye, D. (2017). Protecting the Mental Health of Ontario Seniors. *Diversity of Research in Health Journal*, 1, 17–32. <https://doi.org/10.28984/drhj.v1i0.38>
- Muna, M., Effendy, D. S., Lestari, H., Bahar, H., & Muchtar, F. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Mata Dan Puskesmas Labibia, Kota Kendari. *Preventif Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.37887/epj.v6i2.25725>
- Patel, D. M., Block, R., Chapman, B. P., Korfmacher, K. S., & Wijngaarden, E. v. (2019). Green Space and Mental Health Symptoms in a Cardiac Rehabilitation Population. *Indoor and Built Environment*, 28(10), 1431–1440. <https://doi.org/10.1177/1420326x19853615>
- Purnomo, H. (2024). Peningkatkan Kesejahteraan Mental Dan Pola Hidup Sehat Lansia Di Panti Werdha X. *Jast Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi*, 8(1), 50–62. <https://doi.org/10.33366/jast.v8i1.5831>
- Rahayu, N. A. S. (2023). Manajemen Ansietas Pada Lansia Dengan Terapi Relaksasi Otot Progresif Di Gedung Pusat Kegiatan Penyantunan Usia Lanjut 'Aisyiyah Kota Surakarta. *Jurnal Pengemas Kesehatan*, 2(2), 27–32. <https://doi.org/10.52299/jpk.v2i02.20>
- Rianda, E. C., Dhinantia, A. A., & Nuriyah, E. (2023). Penerapan Perspektif Psikososial Pada Pekerja Sosial Sekolah Dalam Menangani Anak Korban Perang. *Share Social Work Journal*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.40159>
- Rowe, E. A., Dawkins, M. S., & Gebhardt-Henrich, S. G. (2019). A Systematic Review of Precision Livestock Farming in the Poultry Sector: Is Technology Focussed on Improving Bird Welfare? *Animals*, 9(9), 614. <https://doi.org/10.3390/ani9090614>
- Sastrahadi, S. S. (2022). Peran Kader Kesehatan Terhadap Kualitas Hidup Lanjut Usia

- (Lansia) Di Wilayah Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Tahun 2018. *Berdikari Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 10–29. <https://doi.org/10.11594/bjpmi.04.01.02>
- Silitonga, J. (2023). Pengetahuan Lansia Dalam Meningkatkan Kesehatan Fisik Dan Manajemen Spiritual. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(8), 3243–3250. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i8.10396>
- Suminar, E., Widiyawati, W., Nikmah, N., & Inayah, Z. (2023). Penyuluhan Senam Lansia Untuk Meningkatkan Kesehatan Di Panti Jompo Lestari. *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (Ijcdh)*, 3(01), 14. <https://doi.org/10.30587/ijcdh.v3i01.4752>
- Suwandi, E. W. (2024). Kombinasi Mindfulness Spiritual Islam Dan Relaksasi Spiritual Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Lansia. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 299–309. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v4i2.397>
- Tremetsberger, L., Leeb, C., & Winckler, C. (2015). Animal Health and Welfare Planning Improves Udder Health and Cleanliness but Not Leg Health in Austrian Dairy Herds. *Journal of Dairy Science*, 98(10), 6801–6811. <https://doi.org/10.3168/jds.2014-9084>
- Triani, E., & Magello, A. N. (2024). Optimalisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Terdampak Fenomena El Nino Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (Jkarp)*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.32734/jkarp.v3i1.15788>
- Usman, R. D., Rahayu, D. Y. S., & Paluala, D. P. P. (2022). Kemudahan Pencatatan, Monitoring, Dan Pelaporan Kesehatan Lansia Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Lanjut Usia Silanu Amombo. *Health Information Jurnal Penelitian*, 14(2), 124–131. <https://doi.org/10.36990/hijp.v14i2.758>
- Widiani, E., Hidayah, N., & Hanan, A. (2022). Gambaran Masalah Psikososial Lanjut Usia Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v6i2.4120>
- Wiraini, T. P., Zukhra, R. M., & Hasneli, Y. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Masa COVID-19. *Health Care Jurnal Kesehatan*, 10(1), 44–53. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.99>
- Witono, T. (2018). Kontribusi Keterhubungan Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Dan Implikasinya Bagi Pekerjaan Sosial. *Sosio Konsepsia*, 7(1), 47–61. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1100>

Glosarium

A

Active Aging : Konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi lansia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk partisipasi sosial, kesehatan fisik, dan kesejahteraan mental.

Agrowisata : Kegiatan pariwisata yang menggabungkan unsur pertanian, seperti mengunjungi kebun atau peternakan, untuk meningkatkan pendapatan dan interaksi sosial.

D

Dopamin: Neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan fungsi kognitif. Kadar dopamin yang cukup dapat mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi dan demensia.

I

Intervensi Psikososial: Pendekatan yang menggabungkan aspek psikologis dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan individu, termasuk lansia, melalui program edukasi, dukungan sosial, dan aktivitas fisik.

Isolasi Sosial : Kondisi di mana seseorang, terutama lansia, merasa terputus dari interaksi sosial, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental.

K

Kader Kesehatan: Anggota masyarakat yang terlatih untuk memberikan edukasi dan dukungan kesehatan, termasuk kepada lansia, dalam mengelola kondisi kesehatan mereka.

Kesejahteraan Mental: Kondisi di mana individu merasa sejahtera secara psikologis, emosional, dan sosial, termasuk kemampuan untuk mengatasi stres dan menjalani kehidupan yang bermakna.

Komunitas Pertanian : Kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pertanian dan bergantung pada kegiatan pertanian sebagai sumber ekonomi dan kehidupan sosial.

M

Manajemen Spiritual: Pendekatan yang melibatkan aspek spiritualitas, seperti meditasi atau kegiatan keagamaan, untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional.

P

Pemberdayaan Komunitas: Proses meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, termasuk lansia, dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pendekatan Holistik: Metode yang mempertimbangkan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual dalam merancang intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan.

R

Relaksasi Otot Progresif: Teknik relaksasi yang melibatkan penegangan dan pengenduran otot secara bertahap untuk mengurangi kecemasan dan stres.

Ruang Terbuka Hijau : Area terbuka yang ditanami tumbuhan, seperti taman atau kebun, yang dapat berkontribusi pada kesehatan mental dengan mengurangi gejala kecemasan dan depresi.

S

Support Group (Kelompok Dukungan): Kelompok yang dibentuk untuk memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anggotanya, terutama lansia, dalam menghadapi tantangan kesehatan mental.

BAB IV

PERAN KELUARGA DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN PSIKOLOGIS

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi individu dalam menjalani kehidupan, hal ini juga dirasakan oleh lansia. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks ini, dukungan psikologis dari keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu lansia menghadapi perubahan tersebut serta menjaga kesehatan mental dan emosional. Dukungan ini dapat berupa kasih sayang, perhatian, komunikasi yang positif, serta bantuan dalam mengatasi tantangan yang muncul di masa tua.

Dukungan psikologis dari keluarga memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan lansia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mendapatkan dukungan emosional yang kuat dari keluarga cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, lebih sedikit mengalami depresi, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Anttonen & Karsio, 2016). Sebaliknya, kurangnya dukungan dari keluarga dapat meningkatkan risiko kesepian, isolasi sosial, dan gangguan mental lainnya pada lansia (Cattan et al., 2005).

Peran keluarga dalam mendukung lansia sangat beragam, mulai dari memberikan dukungan emosional, sosial, hingga bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Pada lansia yang mengalami penyakit kronis atau kondisi degeneratif, dukungan keluarga dapat berkontribusi terhadap keberhasilan pengobatan serta meningkatkan kepatuhan terhadap terapi yang diberikan (Pinquart & Sorensen, 2007). Selain itu, lingkungan keluarga yang harmonis dan suportif dapat membantu lansia mempertahankan harga diri dan rasa memiliki, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, dukungan keluarga bagi lansia juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan penuaan yang sehat (*healthy aging*). Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek fisik, mental, dan sosial dalam menjalani kehidupan di usia lanjut (World Health Organization, 2020). Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran keluarga dalam memberikan dukungan psikologis bagi lansia menjadi hal yang penting untuk dikembangkan, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Prevalensi masalah psikologis pada lansia yang disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga cukup signifikan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 14% orang berusia 60 tahun ke atas mengalami gangguan mental, dengan depresi dan kecemasan sebagai kondisi yang paling umum (World Health Organization, 2021b). Faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini termasuk isolasi sosial dan kesepian, yang sering kali diperburuk oleh kurangnya peran keluarga dalam memberikan dukungan emosional dan sosial (National Institute on Aging, 2023). Selain itu, penelitian dari National Institute on Aging (NIA) menunjukkan bahwa kesepian kronis pada lansia dapat memicu perubahan biologis yang meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskular, Alzheimer, dan gangguan imun. Lansia yang merasa terisolasi juga cenderung mengalami peningkatan stres dan peradangan tubuh, yang berkontribusi pada percepatan penuaan serta penurunan kualitas hidup (Cacioppo & Cacioppo, 2018).

Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran krusial sebagai sistem pendukung utama bagi kesejahteraan psikologis lansia. Dukungan emosional dari keluarga terbukti dapat menurunkan risiko gangguan mental pada lansia, meningkatkan kesejahteraan subjektif, serta memperpanjang harapan hidup. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga cenderung lebih bahagia dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang kurang mendapat perhatian dari keluarga mereka. Meskipun peran keluarga sangat penting, banyak keluarga yang masih belum memahami bagaimana cara memberikan dukungan psikologis yang efektif bagi lansia. Minimnya pemahaman tentang perubahan psikologis pada lansia, kurangnya keterampilan komunikasi, serta kesibukan anggota keluarga seringkali menjadi hambatan dalam memberikan perhatian yang cukup bagi lansia. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat mengenai strategi dukungan psikologis bagi lansia agar mereka dapat menjalani masa tua yang lebih bahagia, bermakna, dan sejahtera.

B. Kebutuhan Psikologis Lansia

Masalah psikologis yang dialami lansia berupa keterasingan dari masyarakat kaitannya dengan penurunan fungsi fisik, perubahan kepribadian, peran dan minat terutama bila sudah pensiun, serta kehilangan pasangan (Stanley et al., 2007). Masalah psikologis yang paling sering terjadi pada lansia yaitu depresi dan merupakan urutan keempat penyakit di Dunia sebagai penyebab kecacatan. Depresi pada lansia terjadi dikarenakan kehilangan pasangan, penyakit kronis yang diderita, penggunaan obat-obatan yang banyak yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik dan kualitas hidup (de Oliveira et al., 2019). Hasil penelitian mengemukakan bahwa beberapa intervensi yang dapat dilakukan pada lansia yang mengalami depresi yaitu

terapi fisik/exercise, terapi psikologis, dan terapi spiritual dan ketiga terapi ini dapat dilakukan pada lansia di berbagai setting baik lansia yang berada di panti jompo, di lembaga pemasyarakatan, dan yang tinggal dengan keluarga. Intervensi ini dilakukan secara sederhana, hemat biaya, dan secara nonfarmakologis yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, menurunkan tingkat kecemasan dan masalah psikologis lainnya yang dihadapi lansia (Sinaga, 2020).

Lansia mengalami berbagai perubahan fisik, sosial, dan emosional yang berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, memahami kebutuhan psikologis lansia menjadi penting agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa kebutuhan psikologis utama lansia:

1. Kebutuhan akan Kasih Sayang dan Dukungan Emosional

Lansia membutuhkan kasih sayang dari keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk menjaga kesehatan mental. Kehangatan emosional dari keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi (Pinquart & Sorensen, 2007). Kurangnya perhatian dan kasih sayang dapat menyebabkan perasaan kesepian yang berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis lansia (Cattan et al., 2005).

2. Kebutuhan akan Keamanan dan Stabilitas

Seiring bertambahnya usia, lansia menjadi lebih rentan terhadap perubahan kehidupan, seperti pensiun, kehilangan pasangan, atau keterbatasan fisik. Lansia membutuhkan lingkungan yang stabil dan aman untuk menghindari kecemasan serta meningkatkan kesejahteraan emosional (World Health Organization, 2021b). Keamanan finansial dan dukungan sosial juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan psikologis mereka.

3. Kebutuhan akan Penghargaan dan Penerimaan Diri

Lansia ingin merasa dihargai dan tetap memiliki peran dalam keluarga maupun masyarakat. Lansia perlu mendapatkan pengakuan atas pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan sepanjang hidupnya. Lingkungan yang menghormati dan memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap berpartisipasi dalam aktivitas sosial dapat meningkatkan harga diri, mempertahankan identitas diri dan mengurangi perasaan tidak berguna (Anttonen & Karsio, 2016; Harvey & Thoresen, 2019).

4. Kebutuhan akan Interaksi Sosial dan Rasa Kebersamaan

Isolasi sosial merupakan faktor risiko utama bagi gangguan kesehatan mental pada lansia. Interaksi sosial yang aktif dapat membantu mereka merasa lebih bahagia dan mengurangi risiko depresi. Menurut hasil penelitian bahwa lansia yang memiliki jaringan sosial yang baik cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil dibandingkan mereka yang merasa terisolasi (National Institute on Aging, 2023).

5. Kebutuhan akan Kemandirian dan Kendali atas Hidupnya

Meskipun lansia mengalami keterbatasan fisik, tetapi lansia tetap ingin merasa mandiri dan memiliki kendali atas keputusan hidupnya. Memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap aktif dalam membuat keputusan pribadi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional mereka (Cacioppo & Cacioppo, 2018). Lansia ingin dihormati dalam menentukan pilihan pribadi, seperti tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari (Baltes & Smith, 2003; Chen et al., 2020).

6. Kebutuhan akan Makna Hidup dan Spiritualitas

Banyak lansia mencari makna dalam kehidupan mereka melalui spiritualitas, agama, atau kegiatan sosial yang memberikan rasa tujuan. Aktivitas keagamaan atau keterlibatan dalam komunitas dapat membantu lansia menghadapi perubahan hidup dengan lebih positif dan mengurangi kecemasan akan masa depan, berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional dan mengurangi risiko depresi (Koenig, H, 2012; World Health Organization, 2020).

C. Peran Keluarga dalam Menjaga Kesehatan Mental Lansia

Keluarga berperan dalam memberikan dukungan emosional, sosial, dan fisik yang dapat membantu lansia mengatasi tantangan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kesepian. Dukungan emosional berupa lansia mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang baik dari keluarga akan memiliki kondisi mental yang lebih stabil. Dukungan sosial berupa interaksi sosial dalam keluarga dapat mengurangi risiko isolasi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia. Dukungan fisik berupa bantuan dalam aktivitas sehari-hari dan akses ke layanan kesehatan sehingga lansia merasa lebih aman dan dihargai (Hardianti et al., 2020).

Hasil penelitian ini juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana keluarga dapat berperan secara efektif dalam mendukung kesehatan mental lansia yaitu struktur keluarga, kesadaran dan

pemahaman, dan keadaan ekonomi. Sebaliknya ketidakpedulian keluarga dapat berdampak serius pada kesehatan mental lansia termasuk meningkatnya risiko depresi dan kecemasan akibat kesepian dan perasaan tidak dibutuhkan, penurunan kualitas hidup karena kurangnya perhatian dalam aspek sosial dan emosional, dan tingkat stres yang lebih tinggi akibat ketidakmampuan lansia dalam menghadapi tantangan hidup sendiri.

Peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental lansia tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penuaan sehat (healthy aging). Peran yang dapat dilakukan keluarga dalam menjaga kesehatan mental lansia adalah (National Institute on Aging, 2023):

1. Memberikan Dukungan Emosional

Keluarga yang aktif berkomunikasi dengan lansia, memberikan perhatian, serta menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dapat mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka.

2. Memfasilitasi Interaksi Sosial

Lansia yang memiliki hubungan sosial yang baik, terutama dengan anggota keluarga, lebih cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kegiatan keluarga seperti makan bersama, berbicara secara rutin, atau mendampingi lansia dalam aktivitas sosial dapat meningkatkan keterlibatan sosial mereka.

3. Mendukung Kesehatan Fisik dan Mental

Studi menunjukkan bahwa lansia yang mendapat dukungan keluarga lebih cenderung mengikuti pengobatan dengan baik, menjaga pola makan sehat, dan tetap aktif secara fisik, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik.

4. Mencegah Isolasi Sosial

Isolasi sosial dapat memperburuk kondisi mental lansia. Oleh karena itu, keluarga perlu mendorong lansia untuk tetap terlibat dalam komunitas atau aktivitas sosial, seperti mengikuti kelompok keagamaan atau klub lansia.

Menurut penelitian dari NIA, kesepian dan isolasi sosial dapat mempercepat penuaan, meningkatkan risiko penyakit kronis, dan memperburuk kondisi mental lansia. Lansia yang tidak mendapatkan dukungan sosial dari keluarga lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, dan penurunan fungsi kognitif. Selain itu, kurangnya interaksi sosial dalam keluarga dapat menyebabkan peningkatan stres dan inflamasi dalam tubuh, yang terkait dengan penyakit seperti Alzheimer dan gangguan

kardiovaskular. CDC juga mengungkapkan bahwa sekitar 1 dari 3 orang dewasa mengalami kesepian, dan 1 dari 4 merasa kurang mendapatkan dukungan sosial dan emosional. Lansia yang tinggal sendiri atau memiliki keterbatasan akses sosial memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental lansia, antara lain (Hardianti et al., 2020):

1. Meningkatkan komunikasi dalam keluarga untuk memastikan lansia merasa diperhatikan dan dihargai
2. Membantu lansia tetap aktif secara sosial dengan melibatkan dalam kegiatan keluarga dan komunitas
3. Memfasilitasi akses ke layanan kesehatan mental seperti terapi psikologis atau kelompok dukungan
4. Mendidik anggota keluarga tentang kebutuhan psikologis lansia untuk meningkatkan empati dan pemahaman mereka.

D. Strategi Komunikasi Efektif dengan Lansia

Strategi komunikasi yang efektif dengan lansia harus mempertimbangkan aspek verbal, non-verbal, psikologis, dan sosial. Komunikasi yang efektif dengan lansia sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, memastikan pemahaman terhadap informasi kesehatan, serta membangun hubungan sosial yang baik. Lansia sering mengalami perubahan fisiologis dan psikososial yang dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan memproses informasi. Prinsip dasar berkomunikasi dengan lansia adalah:

1. Kesabaran dan Empati

Orang yang lebih tua mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan merespons informasi. Mereka akan merasa dihargai dan diperhatikan jika mereka bersikap empati (Williams & Herman, 2018).

2. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami

Hindari istilah teknis atau medis yang rumit. Selalu gunakan kalimat yang singkat dan jelas (Schulz et al., 2020).

3. Menjaga Bahasa Tubuh dan Kontak Mata yang Ramah

Bahasa tubuh yang positif membantu orang tua lebih percaya diri saat berkomunikasi. Seorang lawan bicara dapat lebih fokus dan memahami pesan dengan lebih baik jika mereka menatap wajahnya (Elliot et al., 2017).

Beberapa tujuan komunikasi efektif/terapeutik pada lansia termasuk menciptakan hubungan yang lebih saling percaya antara pasien dan perawat, yang

dikenal sebagai hubungan interpersonal, yang efektif mendukung kesejahteraan lansia memastikan bahwa mereka menerima perawatan holistik berkualitas tinggi. Selain itu, tujuan komunikasi terapeutik pada lansia adalah untuk meyakinkan membuat keputusan, membantu mereka beradaptasi dengan keadaan mereka saat ini, membantu mereka melihat diri mereka sebagai upaya untuk menerima dan menghormati diri mereka sendiri, meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai tujuan yang realistis yang sesuai dengan keadaan mereka, dan menciptakan rasa identitas diri yang lebih jelas dan integritas. Masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kognitif dapat diperbaiki melalui komunikasi terapeutik (Dewi et al., 2022).

Beberapa saran untuk meningkatkan komunikasi dengan lansia adalah sebagai berikut (National Institute on Aging, 2017):

1. Gunakan panggilan yang membuat lansia merasa nyaman. Bangun rasa hormat kepada lansia dengan menggunakan bahasa yang lebih formal atau tanyakan panggilan yang lebih disukai lansia sebagai cara menghormati. Lansia biasanya lebih terbiasa dengan sapaan yang lebih formal.
2. Memberikan kenyamanan kepada pasien lanjut usia. Sadarilah bahwa lansia lebih banyak memerlukan bantuan perawat, sehingga mereka mungkin perlu diantar ke dan dari ruang tunggu, kantor, toilet, dan ruangan pemeriksaan.
3. Luangkan waktu untuk membangun hubungan profesional. Perkenalkan diri dengan berbicara dengan jelas dan tidak terlalu cepat. Tunjukkan dari awal bahwa perawat menerima lansia dan terbuka untuk mendengarkan masalah atau kekhawatiran mereka.
4. Cobalah untuk tidak terlalu tergesa-gesa saat lansia bertanya atau memberikan informasi. Berbicara lambat memberi lansia waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan atau pernyataan. Perawat yang terlalu cepat berkomunikasi membuat pasien merasa tidak didengar atau dipahami. Akibatnya, lansia cenderung meminimalkan kekhawatiran atau masalah mereka secara mandiri karena takut akan menghabiskan waktu perawat.
5. Hindari mengganggu percakapan. Lansia yang berbicara tentang masalahnya kemudian diganggu oleh orang lain seringkali membuat lansia tidak menceritakan kembali semua masalahnya, sehingga perawat membutuhkan waktu untuk kembali melakukan kunjungan atau pemeriksaan berikutnya.

6. Gunakan keterampilan mendengar aktif. Mendengarkan secara aktif membantu diskusi tetap terfokus dan memberitahu lansia bahwa perawat memahami kekhawatiran atau masalahnya. Perawat dapat berhadapan dengan pasien, mempertahankan kontak mata, dan menggunakan respon singkat seperti "oke", "saya mengerti", dan "uh-huh" saat orang tua berbicara. Ini memungkinkan pasien menjadi pembicara aktif.
7. Tunjukkan rasa empati dan pertimbangkan kesempatan untuk merespon emosi lansia. "Maaf Anda harus menghadapi masalah ini, saya pikir kita bisa mengatasinya bersama-sama," dll. Studi ini menunjukkan bahwa dapat menunjukkan penghargaan/kepuasan lansia, pemahaman, dan kepatuhan terhadap pengobatan.
8. Jangan percaya bahwa pasien memahami istilah medis yang digunakan perawat. Perkenalkan terlebih dahulu informasi yang diperlukan tentang kondisi lansia. Pasien lansia mungkin tidak terbiasa dengan istilah seperti MRI, CT-Scan, dan sebagainya, meskipun mereka terdengar seperti istilah yang umum.
9. Hati-hati saat menggunakan bahasa. Beberapa kata untuk lansia memiliki arti yang berbeda dibanding usia lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan etnis yang tidak sesuai, ketidakmampuan membaca, atau keaksaraan yang rendah. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan umum, tanyakan apakah klarifikasi diperlukan atau menawarkan untuk mengulangi atau menyusun ulang informasi: "Saya tahu ini rumit. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskannya tetapi beritahu saya jika nenek/kakek memiliki pertanyaan atau ingin saya kembali mengulanginya."
10. Tuliskan point take away. Seringkali, lansia mengalami kesulitan untuk mengingat semua yang dibicarakan oleh perawat selama pemberian asuhan keperawatan. Membuat catatan harus sederhana dan mudah dipahami, dan hindari menggunakan bahasa yang ambigu atau rumit. Misalnya, "minumlah 6 gelas air putih dalam sehari".
11. Pastikan pemahaman lansia tentang informasi kesehatan. Setelah temuan, pastikan lansia memahami:
 - a. Apa masalah utama?
 - b. Apa yang harus saya lakukan?

- c. Untuk alasan apa perlu dilakukan? Meminta lansia untuk mengulangi apa yang telah dijelaskan dan dipahami dari pertemuan adalah salah satu cara untuk menggunakan "metode tanya balik".
12. Memahami kondisi lansia yang mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran didiagnosis pada sebagian besar orang dewasa di rentang usia 65 hingga 75 tahun. Berikut ini adalah beberapa saran untuk membuat komunikasi perawat dengan lansia yang mengalami gangguan pendengaran lebih mudah, yaitu:
- a. Pastikan lansia dapat mendengar perawat.
 - b. Bicara perlahan dan jelas dengan nada normal; tanyakan apakah lansia memerlukan alat bantu atau apakah terdapat kotoran di saluran pendengaran. Jangan berteriak atau berbicara dengan suara tinggi karena akan memberi kesan bahwa Anda marah.
 - c. Hindari suara yang terlalu tinggi atau sulit didengar.
 - d. Berbicara dengan lansia secara langsung dan sejajar sehingga mereka dapat melihat pengucapan dengan bahasa bibir atau menangkap petunjuk secara visual.
 - e. Jangan dekatkan tangan perawat ke wajah saat mereka berbicara karena ini akan menghalangi mereka untuk membaca bahasa bibir pasien.
 - f. Hindari tempat yang terlalu bising agar tidak mengganggu percakapan antara orang tua dan perawat
 - g. Berhati-hatilah saat menggunakan huruf yang terdengar sama seperti m, n, b, dan d
 - h. Sediakan alat bantu untuk menulis apa yang diucapkan oleh perawat. Tulis istilah atau kata-kata yang harus ditekankan
 - i. Jika perawat mengubah topik pembicaraan, beritahu lansia.
13. Pahami kondisi lansia dengan penurunan visual. Gangguan visual menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh lansia yang mengalami gangguan visual adalah sebagai berikut:
- a. Pastikan ada pencahayaan yang cukup untuk menerangi wajah perawat;
 - b. Periksa apakah orang tua memerlukan alat bantu penglihatan, seperti kacamata, saat berbicara dengan perawat; dan
 - c. Pastikan instruksi tulisan tangan jelas.
 - d. Jika pasien mengalami kesulitan membaca, pertimbangkan untuk merekam instruksi, memberikan gambar atau diagram besar, atau menggunakan alat bantu seperti kotak pil, simbol, dan lainnya.

- e. Jika Anda menggunakan bahan cetak, pastikan tulisannya cukup besar dan menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca. Ukuran cetak 14 halaman biasanya cukup.



Gambar 1. Strategi Komunikasi Efektif pada Lansia

Sumber: *National Institute on Aging*, 2017)

Strategi komunikasi efektif dengan lansia antara lain:

1. Strategi komunikasi verbal

- a. Berbicara Perlahan dan Jelas. Lansia dengan gangguan pendengaran dapat lebih memahami jika kita berbicara dengan tempo yang lebih lambat dan intonasi yang jelas (Williams & Herman, 2018).
- b. Gunakan Pengulangan dan Penegasan. Mengulang informasi dengan cara berbeda membantu meningkatkan pemahaman. Gunakan frasa seperti *"Jadi, yang perlu Anda ingat adalah..."*.
- c. Berikan Waktu bagi Lansia untuk Merespons. Hindari berbicara terlalu cepat atau mengajukan pertanyaan bertubi-tubi.
- d. Dorong Partisipasi Aktif. Ajukan pertanyaan terbuka seperti *"Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi ini?"*.

2. Strategi komunikasi non-verbal

- a. Gunakan Isyarat Visual. Gambar, video, atau gestur dapat membantu lansia yang memiliki gangguan pendengaran atau kognitif (Miller & Smith, 2019).
- b. Jaga Jarak dan Posisi Duduk yang Nyaman. Posisi sejajar dengan lansia saat berbicara membuat komunikasi lebih nyaman.
- c. Ekspresi Wajah yang Ramah dan Gestur Positif. Senyum dan anggukan kepala dapat memberikan rasa aman bagi lansia.

E. Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia melalui Aktivitas Positif

Faktor fisik, mental, sosial, dan emosional memengaruhi kualitas hidup orang tua. Berpartisipasi dalam aktivitas kognitif, sosial, dan fisik yang bermanfaat dapat membantu orang tua lebih baik dan mencegah depresi, demensia, dan penyakit kronis. Kualitas hidup lansia, menurut World Health Organization (2021), didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang posisi mereka dalam kehidupan mereka dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan prioritas mereka, serta budaya dan sistem nilai tempat mereka tinggal (World Health Organization, 2021a). Meningkatkan kualitas hidup lansia dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas positif, termasuk aktivitas fisik, sosial, dan kognitif. Partisipasi dalam aktivitas ini terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kesejahteraan mental, mengurangi risiko penyakit kronis, dan memperpanjang harapan hidup. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan untuk mendukung lansia agar tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. Kesehatan fisik dan mental, kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, interaksi sosial dan keterlibatan komunitas, dan dukungan keluarga dan lingkungan yang mendukung adalah komponen utama yang menentukan kualitas hidup orang tua.

Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas sosial, fisik, psikologis, dan lingkungan. Lansia yang aktif dalam komunitas memiliki skor kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan yang terisolasi. Lansia dengan hipertensi, diabetes, atau penyakit kronis lainnya memiliki skor kualitas hidup lebih rendah. Lansia yang tinggal bersama keluarga menunjukkan kondisi psikososial lebih baik. Aktivitas fisik dan kognitif seperti olahraga ringan dan keterlibatan dalam kegiatan edukasi dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik lansia (Sinaga et al., 2022).

Jenis aktivitas positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia adalah:

1. **Aktivitas Fisik.** Aktivitas fisik bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan, mengurangi risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan osteoporosis, dan meningkatkan hormon endorfin yang berperan dalam kesejahteraan emosional. Contoh aktivitas seperti senam lansia (tai chi, yoga, aerobik ringan), jalan kaki dan bersepeda santai, berkebun atau aktivitas rumah tangga ringan (Kramer & Erickson, 2007; Nelson et al., 2007).
2. **Aktivitas Sosial.** Aktivitas sosial bermanfaat untuk mengurangi risiko depresi dan isolasi sosial, mempertahankan fungsi kognitif dengan meningkatkan interaksi dan keterlibatan sosial, dan memberikan rasa memiliki dan harga diri yang lebih tinggi. Contoh aktivitas seperti bergabung dalam kelompok komunitas lansia,

menghadiri acara sosial atau keagamaan, menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial (Cattan et al., 2005; Holt-Lunstad et al., 2015).

3. **Aktivitas Kognitif dan Mental.** Aktivitas ini bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak dan daya ingat, mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, dan mempertahankan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Contoh aktivitas seperti membaca buku atau surat kabar, belajar keterampilan baru (misalnya bahasa asing, komputer, seni musik), bermain teka-teki atau permainan strategi (catur, sudoku, puzzle) (Verghese et al., 2003; Wilson et al., 2012).

F. Tantangan dalam Memberikan Dukungan Psikologis bagi Lansia

Untuk memberikan dukungan psikologis terbaik dan meningkatkan kesejahteraan mereka, keluarga, tenaga medis, komunitas, dan teknologi harus bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Faktor-faktor ini termasuk faktor individu (penurunan kognitif dan stigma), faktor sosial (isolasi dan kurangnya dukungan keluarga), sistem kesehatan (akses terbatas, tenaga medis kurang terlatih), dan kesenjangan teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan terpadu antara keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan teknologi agar lansia mendapatkan dukungan psikologis yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

1. **Tantangan Individu.** Lansia dengan gangguan kognitif dan penurunan memori seperti demensia atau penyakit Alzheimer sering mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi dan interaksi sosial sehingga lansia tidak menyadari perlunya dukungan psikologis bahkan menolak intervensi ("Alzheimer's Disease International," 2022). Lansia lebih rentan mengalami depresi akibat kehilangan pasangan, pensiun, atau perubahan peran sosial, lansia yang tinggal sendiri atau jauh dari keluarga sering mengalami isolasi sosial dan dapat memperburuk kondisi psikologis mereka bahkan meningkatkan risiko kematian dini sebesar 29% dan berkontribusi pada stress kronis (Holt-Lunstad et al., 2015). Banyak lansia enggan mencari bantuan psikologis (hanya 35% lansia yang mencari bantuan profesional) karena anggapan bahwa kesehatan mental bukan prioritas atau merupakan tanda kelemahan (National Institute on Aging, 2023).
2. **Tantangan Sosial.** Perubahan gaya hidup modern menyebabkan berkurangnya interaksi keluarga dengan lansia, terutama bagi lansia yang tinggal di panti jompo atau sendirian dan ini menjadi penyebab utama stress emosional pada lansia. Banyak lansia mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baru setelah

pensiun atau kehilangan pasangan, partisipasi dalam aktivitas sosial juga sering berkurang karena keterbatasan mobilitas atau kesehatan fisik (Cattan et al., 2005; Cohen-Mansfield, 2018).

3. Tantangan dalam Sistem Kesehatan. Layanan psikologis sering kali kurang tersedia atau mahal bagi lansia, terutama di daerah pedesaan, dan tidak semua tenaga kesehatan memiliki pelatihan khusus dalam mendukung kesejahteraan psikologis lansia (Williams & Herman, 2018; World Health Organization, 2021b).
4. Tantangan Teknologi. Lansia sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan psikologis berbasis teknologi, seperti telemedicine atau aplikasi kesehatan mental (hanya 44% lansia merasa nyaman menggunakan teknologi digital untuk layanan kesehatan). Tidak semua lansia dapat menggunakan platform digital, tetapi sistem layanan kesehatan sehingga perlu kombinasi dukungan digital dan tatap muka untuk menjangkau lebih banyak lansia. Lansia juga sering mengalami kecemasan dalam menggunakan teknologi baru, terutama karena keterbatasan pengalaman dan gangguan sensorik seperti gangguan penglihatan dan pendengaran, tidak semua lansia memiliki akses ke perangkat teknologi karena kurang mampu membayar layanan kesehatan digital, lansia cenderung khawatir tentang keamanan informasi pribadi dan risiko kebocoran data dalam layanan kesehatan digital (Frishammar et al., 2023).

G. Penutup

Keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan psikologis kepada lansia. Keluarga dapat membantu lansia menghadapi berbagai tantangan emosional dan mental dengan memberikan kasih sayang, keamanan, dan motivasi. Memenuhi kebutuhan emosional, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan mendapatkan layanan kesehatan mental. Buku ini membahas kebutuhan psikologis lansia, peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental lansia, strategi komunikasi efektif dengan lansia, aktivitas positif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, dan tantangan dalam memberikan dukungan psikologis bagi lansia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran keluarga dalam mendukung kesehatan mental lansia, diharapkan setiap anggota keluarga dapat lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi lansia, yang akan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih bermakna, sehat, dan bahagia di usia senja. Semoga buku ini menjadi panduan yang berguna bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada kesejahteraan psikologis lansia. Karena kita semua bertanggung

jawab atas kesehatan mental lansia, mari kita bekerja sama untuk membuat lingkungan yang lebih ramah lansia.

Referensi

- Alzheimer's Disease International. (2022). In World Alzheimer Report 2022: Life after diagnosis.
- Anttonen, A., & Karsio, O. (2016). Elderly care policy in Finland: From universalism to managerialism. *Journal of Aging Studies*, 38, 63–72.
- Baltes, P. ., & Smith, J. (2003). New frontiers in the future of aging: From successful aging of the young-old to the dilemmas of the fourth age. *Gerontology*, 49(2), 123–135.
- Cacioppo, S., & Cacioppo, J. . (2018). The biological impact of social isolation and loneliness on health. *Neuropsychopharmacology*, 43(1), 235–248.
- Cattan, M., White, M., Bond, J., & Learmouth, A. (2005). Preventing social isolation and loneliness among older people: A systematic review of health promotion intervention. *Ageing and Society*, 25(1), 41–67.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Health effects of social isolation and loneliness. cdc
- Chen, Y., Peng, Y., Xu, H., & O'Brien, W. . (2020). Age differences in stress and coping: Problem-focused strategies mediate the relationship between age and positive affect. *International Journal of Aging and Human Development*, 90(1), 1–18.
- Cohen-Mansfield, J. (2018). Effective communication strategies with older adults. *Journal of Aging Studies*, 45, 12–18.
- de Oliveira, L. D. S. S. C. B., Souza, E. C., Rodrigues, R. A. S., Fett, C. A., & Piva, A. B. (2019). The effects of physical activity on anxiety, depression, and quality of life in elderly people living in the community. *Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, 41(1), 36–42. <https://doi.org/10.1590/2237-6089-2017-0129>
- Dewi, S. U., Sinaga, M. R. E., Oktavia, N. A., Wahyuningsih, S., Yunike, Beo, Y. A., Pangaribuan, R., Anggeriyane, E., Fakhriyah, D., Kusumawaty, I., & Nuraeni, A. (2022). *Keperawatan gerontik* (M. Sari & R. M. Sahara (Eds.); 1st ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Elliot, R., Adams, J., & Bennet, P. (2017). The role of non-verbal communication in healthcare settings for older patients. *Geriatric Nursing*, 38(5), 345–352.
- Frishammar, J., Essen, A., Bergstrom, F., & Ekman, T. (2023). Digital health platforms for elderly? Key adoption and usage barriers and ways to address them. *Technological Forecasting & Social Change*, 189(November 2022). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122319>
- Hardianti, D., Hos, J., & Sarpin. (2020). Bentuk dukungan keluarga dalam menjaga kesehatan mental lansia. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 1(2), 138–147.

- Harvey, J., & Thoresen, C. . (2019). Social support, role involvement, and well-being in late adulthood. *Journal of Aging and Health*, 15(3), 435–459.
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. ., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227–237.
- Koenig, H, G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. *ISRN Psychiatry*, 278730.
- Kramer, A. ., & Erickson, K. . (2007). Effects of physical activity on cognition, well-being, and brain health. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(1), 58–76.
- Miller, R., & Smith, L. (2019). Visual cues and their impact on elderly communication. *Journal of Gerontology*, 74(2), 112–120.
- National Institute on Aging. (2017). Tips for Improving Communication with Older Patients.
- National Institute on Aging. (2023). Social isolation, loneliness in older people pose health risks. <https://www.nia.nih.gov>
- Nelson, M. ., Rejeski, W. ., Blair, S. ., Duncan, P. ., Judge, J. ., King, A. ., & Castaneda-Sceppa, C. (2007). Physical activity and public health in older adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39(8), 1435–1445.
- Pinquart, M., & Sorensen, S. (2007). Correlates of physical health of informal caregivers: A meta-analysis. *Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 62(2), 126–137.
- Schulz, R., Savla, J., Czaja, S. ., & Rockwood, K. (2020). Strategies for improving communication with older patients. *The Lancet Healthy Aging*, 1(3), 56–63.
- Sinaga, M. R. E. (2020). The Effectiveness of the Intervention Depression in the Elderly: A Systematic Review. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(4), 529. <https://doi.org/10.26714/jkj.8.4.2020.529-540>
- Sinaga, M. R. E., Simanjuntak, S. R., & Locsin, R. C. (2022). Factors Affecting the Quality of Life of Older People during the COVID-19 Pandemic. 12(August), 185–195.
- Stanley, Mickey, & Patricia Gauntlett Beare. (2007). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik* (2nd ed.). EGC.
- Verghese, J., Lipton, R. ., Katz, M. ., Hall, C. ., Derby, C. ., Kuslansky, G., & Buschke, H. (2003). Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. *New England Journal of Medicine*, 348(25), 2508–2516.
- Williams, K. ., & Herman, R. (2018). Communicating effectively with older adults: Best practices for healthcare providers. *The Gerontologist*, 58(4), 654–662.
- Wilson, R. ., Boyle, P. ., Yu, L., Barnes, L. ., Sytsma, J., & Bennet, D. . (2012). Life-span cognitive activity, neuropathologic burden, and cognitive aging. *Neurology*, 78(5), 305–311.

World Health Organization. (2020). Decade of Healthy Ageing: Baseline report 2020.

World Health Organization. (2021a). Guidelines on healthy ageing and quality of life in older adults.

World Health Organization. (2021b). Mental health of older adults.
<https://www.who.int>.

Glosarium

D

Depresi adalah keadaan yang sukar, gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan muram, sedih, perasaan tertekan.

Dukungan Emosional adalah bentuk dorongan positif yang diberikan kepada orang lain agar lebih bersemangat dan termotivasi dalam mencapai keinginan atau mampu menghadapi suatu masalah.

Dukungan Sosial adalah informasi verbal atau non-verbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.

E

Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Exercise adalah aktivitas yang membutuhkan aktivitas fisik atau mental, terutama ketika dilakukan untuk mengembangkan atau mempertahankan kebugaran.

H

Healthy Aging adalah proses mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsional yang memungkinkan kesejahteraan di usia yang lebih tua.

Hormon Endorfin adalah hormon peptide dan neuropeptide yang diproduksi di hipotalamus dan dilepaskan ke aliran darah oleh kelenjar pituitari.

K

Kesejahteraan Emosional adalah keseimbangan yang ada dalam diri seseorang perihal emosinya; keadaan dimana seseorang mampu mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi-emosinya secara sehat dan konstruktif.

Krusial adalah penting atau esensial untuk memecahkan masalah

BAB V

AKTIVITAS FISIK

YANG MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL LANSIA

A. Pendahuluan

Proses penuaan merupakan bagian dari siklus kehidupan yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang kompleks. Lansia menghadapi tantangan khusus dalam mempertahankan kesehatan mentalnya akibat berbagai faktor seperti perubahan kondisi fisik, penurunan fungsi kognitif, isolasi sosial, serta kemunduran kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari (Amiri, Behnezhad, & Hasani, 2021). Di tengah dinamika tersebut, aktivitas fisik muncul sebagai salah satu intervensi penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental lansia secara signifikan.

Aktivitas fisik merujuk pada setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan membutuhkan pengeluaran energi, meliputi aktivitas seperti berjalan, bersepeda, latihan aerobik, hingga aktivitas ringan seperti yoga dan Tai Chi (WHO, 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan mental pada lansia, termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan fungsi kognitif (Lee, Lee, & Park, 2022; Kim, Choi, & Son, 2020). Selain itu, aktivitas fisik juga diketahui efektif meningkatkan kualitas tidur, kesejahteraan emosional, serta rasa percaya diri dan harga diri pada lansia (Yoon, Kang, & Kim, 2023).

Dalam konteks kesehatan publik, integrasi aktivitas fisik sebagai strategi promotif dan preventif memiliki nilai signifikan, tidak hanya sebagai pendekatan individu, tetapi juga sebagai pendekatan komunitas yang mendukung kesejahteraan lansia secara luas (Kemenkes RI, 2022; CDC, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pentingnya aktivitas fisik, jenis aktivitas yang sesuai, serta strategi optimalisasi aktivitas fisik bagi lansia menjadi aspek penting dalam manajemen kesehatan mental pada kelompok ini.

Pendahuluan ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai signifikansi aktivitas fisik dalam mendukung kesehatan mental lansia, menguraikan relevansi topik ini dalam konteks global maupun lokal, serta menjadi pijakan dalam pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi praktis dan dukungan lingkungan sosial yang diperlukan untuk efektivitas intervensi ini.

B. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan untuk Lansia

Pemilihan aktivitas fisik yang tepat dan aman untuk lansia sangat penting, mengingat keterbatasan fisik serta risiko cedera yang mungkin dialami kelompok ini. Aktivitas fisik yang direkomendasikan mencakup berbagai latihan yang bertujuan meningkatkan kebugaran aerobik, kekuatan otot, keseimbangan, serta fleksibilitas. Berikut ini penjelasan jenis-jenis aktivitas fisik yang dianjurkan berdasarkan bukti ilmiah terbaru.

1. Aktivitas Aerobik

Aktivitas aerobik adalah jenis latihan yang meningkatkan konsumsi oksigen tubuh melalui gerakan berulang dalam periode tertentu, seperti berjalan kaki, bersepeda, dan berenang. Menurut World Health Organization (WHO, 2020), lansia disarankan untuk melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu atau sekitar 75 menit aktivitas intensitas tinggi. Penelitian terbaru menyatakan bahwa aktivitas aerobik secara rutin efektif menurunkan risiko depresi, kecemasan, meningkatkan fungsi kognitif serta memperbaiki kualitas hidup pada lansia (Amiri, Behnezhad, & Hasani, 2021; Lee, Lee, & Park, 2022). Selain itu, berenang dan bersepeda memiliki keuntungan tambahan dalam mengurangi tekanan pada persendian, sehingga lebih aman bagi lansia dengan masalah sendi atau osteoporosis (CDC, 2022).

2. Aktivitas Penguatan Otot

Latihan penguatan otot mencakup aktivitas fisik yang menggunakan beban tubuh sendiri, alat bantu seperti dumbbell atau resistance band, serta aktivitas yang melibatkan kontraksi otot secara teratur seperti yoga. Latihan ini sangat penting dalam mempertahankan massa otot, mencegah atrofi otot, dan menjaga kekuatan tulang. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa latihan resistensi secara konsisten mengurangi risiko jatuh, memperbaiki fungsi fisik, dan meningkatkan kesehatan mental lansia melalui peningkatan rasa percaya diri dan pengurangan kecemasan (de Oliveira et al., 2021). Sementara itu, yoga dikenal efektif dalam mengurangi stres, depresi, serta meningkatkan kualitas tidur pada lansia melalui gabungan antara latihan fisik ringan, pernapasan, dan meditasi (Silva, Oliveira, & Santos, 2021).

3. Latihan Keseimbangan dan Fleksibilitas

Latihan yang bertujuan meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas, seperti Tai Chi dan Pilates, memainkan peran vital dalam pencegahan jatuh serta cedera pada lansia. Tai Chi, yang berasal dari Tiongkok, merupakan latihan fisik yang mengombinasikan gerakan perlahan, konsentrasi mental, dan teknik

pernapasan. Studi menunjukkan bahwa Tai Chi terbukti efektif dalam meningkatkan keseimbangan tubuh, fungsi kognitif, serta mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada lansia secara signifikan (Kim, Choi, & Son, 2020). Sementara Pilates dikenal mampu meningkatkan fleksibilitas otot, mobilitas sendi, serta memberikan efek positif pada kesehatan mental lansia melalui pengurangan stres dan kecemasan (Engers et al., 2022).

Pemilihan jenis aktivitas fisik ini perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan, preferensi pribadi, serta aksesibilitas lingkungan lansia agar manfaat optimal terhadap kesehatan mental dapat diperoleh secara efektif dan aman.

C. Efek Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Mental Lansia

Aktivitas fisik memiliki dampak positif yang signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental lansia. Berbagai penelitian terbaru telah mengonfirmasi efektivitas aktivitas fisik dalam mengurangi gejala depresi, kecemasan, stres, serta memperbaiki kualitas tidur dan fungsi kognitif pada populasi lansia.

1. Hubungan Antara Aktivitas Fisik Rutin dan Penurunan Gejala Depresi pada Lansia

Depresi merupakan salah satu gangguan mental yang umum dialami lansia, dengan prevalensi yang terus meningkat. Aktivitas fisik rutin terbukti memiliki hubungan kuat dalam menurunkan risiko depresi dan mengurangi intensitas gejalanya. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa lansia yang melakukan aktivitas fisik teratur, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda, memiliki tingkat gejala depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang kurang aktif secara fisik (Lee, Lee, & Park, 2022). Penjelasan fisiologis mengenai hal ini adalah aktivitas fisik mampu merangsang pelepasan endorfin, serotonin, serta neurotransmitter lainnya yang bertanggung jawab atas peningkatan suasana hati dan kesejahteraan mental (Amiri, Behnezhad, & Hasani, 2021).

2. Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Penurunan Kecemasan dan Stres Lansia

Kecemasan dan stres seringkali dialami lansia akibat perubahan fisik, kehilangan kemampuan, atau isolasi sosial yang mereka alami. Aktivitas fisik secara rutin diketahui mampu menurunkan tingkat kecemasan dan stres dengan memperbaiki respons tubuh terhadap stres melalui regulasi hormon kortisol dan peningkatan aktivitas parasimpatik yang menenangkan tubuh (Silva, Oliveira, & Santos, 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa latihan yang melibatkan komponen relaksasi, seperti yoga dan Tai Chi, secara efektif menurunkan tingkat

kecemasan, memperbaiki kontrol emosi, serta meningkatkan ketahanan terhadap stres pada lansia (Kim, Choi, & Son, 2020; Engers, Rombaldi, & da Silva, 2022).

3. Aktivitas Fisik dalam Meningkatkan Kualitas Tidur dan Fungsi Kognitif Lansia

Gangguan tidur dan penurunan fungsi kognitif merupakan tantangan besar yang dihadapi lansia. Aktivitas fisik telah terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas tidur melalui pengaturan ritme sirkadian serta memperpanjang durasi tidur nyenyak (deep sleep) pada lansia. Sebuah studi kohort terbaru menemukan bahwa lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik memiliki kualitas tidur yang lebih baik, yang secara tidak langsung meningkatkan fungsi kognitif, konsentrasi, dan daya ingat mereka (Langhammer et al., 2022). Selain itu, latihan aerobik secara khusus juga terbukti mampu memperbaiki fungsi eksekutif otak dan menghambat penurunan kognitif yang terkait usia melalui peningkatan aliran darah ke otak dan stimulasi neuroplastisitas (Domingos et al., 2021).

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa integrasi aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari lansia adalah intervensi kunci yang harus diprioritaskan dalam kebijakan kesehatan masyarakat, demi mempertahankan kualitas hidup serta kesehatan mental lansia secara menyeluruh.

D. Protokol dan Intensitas Aktivitas Fisik yang Aman bagi Lansia

Aktivitas fisik yang aman bagi lansia membutuhkan pendekatan yang terencana dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko individual, kondisi kesehatan, serta tingkat kebugaran masing-masing individu. Panduan mengenai intensitas, durasi, serta jenis aktivitas fisik sangat penting untuk memastikan manfaat optimal dan mencegah cedera atau komplikasi kesehatan pada lansia (WHO, 2020).

1. Panduan Intensitas Aktivitas Fisik Menurut WHO

World Health Organization (WHO, 2020) memberikan panduan aktivitas fisik khusus untuk lansia (usia 65 tahun ke atas). WHO merekomendasikan lansia melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu atau aktivitas aerobik intensitas tinggi minimal 75 menit per minggu, dengan tambahan latihan penguatan otot minimal dua kali seminggu. Intensitas sedang dicirikan dengan meningkatnya detak jantung dan pernapasan, namun lansia masih dapat berbicara saat beraktivitas (seperti jalan kaki cepat atau bersepeda santai). Sementara itu, intensitas tinggi meliputi aktivitas yang menyebabkan peningkatan signifikan pada detak jantung dan pernapasan, seperti jogging atau berenang dengan kecepatan tinggi (CDC, 2022).

2. Menyusun Program Aktivitas Fisik Sesuai Kondisi Fisik Lansia

Kondisi fisik lansia dapat bervariasi secara signifikan, sehingga penting untuk menyesuaikan program latihan berdasarkan klasifikasi risiko fisik berikut ini:

a. Lansia dengan Risiko Rendah:

Lansia dalam kategori ini tidak memiliki penyakit kronis berat, gangguan mobilitas, atau riwayat cedera serius. Mereka dapat melakukan berbagai aktivitas fisik seperti jalan cepat, berenang, bersepeda, dan latihan kekuatan dengan intensitas sedang hingga tinggi sesuai rekomendasi WHO. Sebuah penelitian menunjukkan lansia sehat dengan aktivitas teratur memiliki kualitas hidup lebih baik secara fisik dan mental dibandingkan dengan lansia yang kurang aktif (Cunningham et al., 2020).

b. Lansia dengan Risiko Sedang:

Lansia yang memiliki gangguan kesehatan ringan hingga sedang (seperti hipertensi terkendali, diabetes tipe 2 stabil, atau osteoarthritis ringan) memerlukan pendekatan yang lebih berhati-hati. Program aktivitas fisik dianjurkan dalam intensitas rendah hingga sedang, dengan prioritas pada aktivitas berdampak rendah seperti berjalan kaki ringan, latihan resistensi ringan, yoga ringan, dan senam air (De Souto Barreto et al., 2021). Pengawasan medis secara berkala sangat dianjurkan untuk memantau respons tubuh terhadap aktivitas fisik.

c. Lansia dengan Risiko Tinggi:

Lansia dengan kondisi kronis yang lebih serius seperti penyakit jantung, osteoporosis berat, atau gangguan keseimbangan yang signifikan membutuhkan pendekatan yang sangat berhati-hati dan supervisi ketat dari profesional kesehatan. Program latihan harus sangat individual, melibatkan latihan ringan hingga sangat ringan seperti latihan fleksibilitas, keseimbangan (Tai Chi), latihan duduk, dan peregangan lembut dengan intensitas sangat rendah. Durasi dan intensitas latihan perlu ditingkatkan secara bertahap sesuai toleransi individu dengan pengawasan ketat (Tarazona-Santabalbina et al., 2022).

3. Strategi Pencegahan Cedera Selama Aktivitas Fisik Lansia

Cedera merupakan salah satu hambatan terbesar yang menyebabkan lansia enggan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Strategi berikut sangat penting diterapkan untuk mencegah cedera:

- a. **Pemanasan dan Pendinginan:** Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan ringan dan diakhiri dengan pendinginan selama 5-10 menit untuk mempersiapkan dan mengembalikan kondisi tubuh (Amiri, Behnezhad, & Hasani, 2021).
- b. **Latihan Bertahap:** Mulailah aktivitas fisik dengan intensitas rendah kemudian tingkatkan secara bertahap untuk mengurangi risiko cedera akibat stres berlebih pada otot dan sendi.
- c. **Peralatan dan Lingkungan Aman:** Gunakan alas kaki yang tepat, pakaian yang nyaman, serta lakukan aktivitas di lingkungan yang aman, bebas hambatan, dan permukaan yang rata.
- d. **Hidrasi dan Nutrisi Cukup:** Pastikan asupan cairan dan nutrisi cukup sebelum, selama, dan sesudah aktivitas fisik untuk mendukung stamina dan pemulihan otot yang optimal (CDC, 2022).

Dengan menerapkan protokol, intensitas yang tepat, serta strategi pencegahan cedera, lansia dapat meraih manfaat maksimal dari aktivitas fisik secara aman dan efektif.

E. Dukungan Sosial dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik Lansia

Keberhasilan pelaksanaan aktivitas fisik lansia tidak hanya bergantung pada kondisi fisik individu, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh dukungan sosial serta lingkungan yang kondusif. Dukungan sosial dan lingkungan komunitas yang ramah lansia menjadi faktor penting yang mendorong motivasi, konsistensi, serta keberlanjutan dalam menjalani aktivitas fisik secara rutin (Amiri, Behnezhad, & Hasani, 2021).

1. Peran Keluarga dalam Mendukung Lansia Beraktivitas Fisik

Keluarga memainkan peran vital dalam memberikan dorongan psikologis maupun fisik terhadap aktivitas fisik lansia. Dukungan keluarga berupa pendampingan langsung, motivasi verbal, hingga penyediaan fasilitas yang mendukung, secara signifikan mampu meningkatkan keterlibatan lansia dalam aktivitas fisik. Studi terbaru mengungkapkan bahwa lansia yang memperoleh dukungan aktif dari keluarga memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dalam menjalani program latihan fisik dibandingkan mereka yang kurang mendapat dukungan keluarga (Keadle et al., 2022). Keluarga juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga lansia termotivasi untuk beraktivitas secara mandiri maupun bersama keluarga (Moon, Rote, & Haley, 2020).

2. Pentingnya Lingkungan Komunitas yang Mendukung dan Ramah Lansia

Lingkungan komunitas yang ramah lansia adalah lingkungan yang menyediakan infrastruktur yang aman dan aksesibel, seperti taman publik yang dilengkapi jalur pejalan kaki, tempat duduk yang nyaman, dan fasilitas olahraga ringan yang mudah digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan fisik yang ramah lansia secara langsung meningkatkan aktivitas fisik dan kesejahteraan mental lansia, sekaligus mengurangi risiko isolasi sosial dan depresi (Huang et al., 2021). Lingkungan komunitas yang mendukung juga mencakup sikap positif dan inklusif dari masyarakat, sehingga lansia merasa dihargai, diterima, dan termotivasi untuk terus berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan olahraga (Van Hoof et al., 2021).

3. Program Berbasis Komunitas dalam Mempromosikan Aktivitas Fisik Lansia

Program berbasis komunitas merupakan pendekatan efektif dalam meningkatkan tingkat aktivitas fisik lansia secara kolektif. Program semacam ini biasanya mencakup kegiatan seperti senam kelompok, jalan sehat bersama, yoga lansia, serta berbagai kegiatan rekreasi sosial yang menarik bagi lansia. Sebuah tinjauan sistematis mengungkapkan bahwa lansia yang terlibat dalam program aktivitas fisik berbasis komunitas menunjukkan peningkatan signifikan dalam kebugaran fisik, penurunan tingkat depresi dan kecemasan, serta peningkatan kualitas hidup secara umum (Yoon, Kang, & Kim, 2023). Program komunitas juga memberikan manfaat tambahan berupa penguatan jaringan sosial, peningkatan rasa percaya diri, dan pemenuhan kebutuhan sosial lansia (Baxter et al., 2020).

Dari paparan di atas, jelas terlihat bahwa dukungan sosial dari keluarga, lingkungan komunitas yang kondusif, serta program berbasis komunitas secara terpadu berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan aktivitas fisik pada lansia, yang akhirnya berdampak positif pada peningkatan kesehatan mental secara keseluruhan.

F. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik pada Lansia

Pelaksanaan aktivitas fisik pada lansia sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat menurunkan motivasi serta tingkat partisipasi lansia dalam aktivitas tersebut. Hambatan tersebut dapat bersifat fisik maupun psikologis, yang apabila tidak diatasi secara efektif, berpotensi menghambat tercapainya manfaat optimal aktivitas fisik terhadap kesehatan mental dan fisik lansia (Amiri, Behnezhad, & Hasani, 2021).

1. Hambatan Fisik (Penyakit Kronis dan Keterbatasan Mobilitas)

Hambatan fisik yang umum dialami lansia meliputi penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, artritis, osteoporosis, dan keterbatasan mobilitas akibat masalah sendi atau otot. Kondisi ini secara signifikan dapat membatasi kapasitas lansia untuk menjalani aktivitas fisik yang memadai. Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia dengan penyakit kronis cenderung mengurangi aktivitas fisik karena takut mengalami cedera, nyeri, atau kelelahan yang meningkat selama aktivitas (Langhammer et al., 2022). Studi lain menegaskan bahwa keterbatasan mobilitas juga menyebabkan lansia mengalami kesulitan dalam mengikuti aktivitas fisik secara rutin, yang pada akhirnya memperburuk kondisi fisik dan mental mereka (De Souto Barreto et al., 2021).

2. Hambatan Psikologis (Kurang Motivasi dan Rendahnya Kepercayaan Diri)

Hambatan psikologis juga berperan penting dalam menurunkan partisipasi lansia dalam aktivitas fisik. Kurangnya motivasi, rendahnya kepercayaan diri, serta persepsi negatif mengenai kapasitas fisik mereka sendiri sering dialami lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa lansia dengan persepsi negatif terhadap kemampuan fisiknya cenderung menghindari aktivitas fisik karena khawatir gagal atau cedera, yang pada akhirnya menyebabkan siklus ketidakaktifan dan penurunan kesejahteraan mental (Moon, Rote, & Haley, 2020). Kurangnya dukungan sosial juga memperkuat hambatan psikologis ini, yang menyebabkan lansia semakin enggan untuk beraktivitas secara rutin (Baxter et al., 2020).

3. Solusi Praktis untuk Mengatasi Hambatan Tersebut

Untuk mengatasi hambatan fisik dan psikologis dalam pelaksanaan aktivitas fisik lansia, beberapa strategi praktis berikut ini direkomendasikan berdasarkan bukti ilmiah terbaru:

a. **Program Latihan yang Dipersonalisasi**

Menyusun program aktivitas fisik secara individual yang mempertimbangkan kondisi fisik, kesehatan, dan kemampuan mobilitas lansia dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan risiko cedera. Latihan berdampak rendah seperti yoga ringan, latihan keseimbangan (Tai Chi), atau latihan di air dapat menjadi pilihan efektif bagi lansia dengan keterbatasan mobilitas atau penyakit kronis (Kim, Choi, & Son, 2020; Silva, Oliveira, & Santos, 2021).

b. **Dukungan Psikososial dari Keluarga dan Komunitas**

Dukungan sosial dari keluarga, teman, serta komunitas dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri lansia dalam menjalani aktivitas fisik secara rutin. Program komunitas yang menawarkan aktivitas fisik

kelompok mampu meningkatkan keterlibatan sosial, motivasi, dan mengurangi rasa isolasi sosial yang sering dialami lansia (Yoon, Kang, & Kim, 2023).

c. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi ponsel pintar, wearable devices, serta program aktivitas fisik virtual dapat membantu memonitor kemajuan aktivitas fisik lansia serta memberikan motivasi tambahan melalui pemberian umpan balik instan dan positif. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan kepatuhan lansia terhadap aktivitas fisik dan menurunkan hambatan psikologis seperti kurangnya motivasi (Schlomann et al., 2021).

d. Edukasi dan Informasi yang Jelas

Memberikan edukasi yang jelas mengenai manfaat aktivitas fisik serta teknik pelaksanaan aktivitas yang aman dan nyaman dapat membantu mengurangi ketakutan lansia akan cedera atau kegagalan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, seminar, atau konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan yang kompeten (Kemenkes RI, 2022).

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, hambatan fisik dan psikologis yang dialami lansia dalam menjalani aktivitas fisik dapat diatasi secara efektif, sehingga lansia dapat menikmati berbagai manfaat positif dari aktivitas fisik baik secara fisik maupun mental.

G. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mendukung Aktivitas Fisik Lansia

Kemajuan teknologi digital kini menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya meningkatkan aktivitas fisik lansia. Pemanfaatan aplikasi mobile dan wearable technology menawarkan kemudahan dalam memonitor, mendokumentasikan, serta meningkatkan motivasi lansia untuk menjaga rutinitas aktivitas fisik mereka. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan keterlibatan lansia dalam aktivitas fisik yang berkelanjutan (Schlomann et al., 2021).

1. Aplikasi Mobile dan Wearable Technology dalam Pemantauan Aktivitas Fisik Lansia

Aplikasi mobile berbasis ponsel pintar serta perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker semakin populer digunakan untuk memantau aktivitas fisik secara real-time. Perangkat ini dapat merekam data seperti jumlah langkah, durasi latihan, kalori yang terbakar, hingga detak jantung selama aktivitas fisik. Studi terbaru menegaskan bahwa penggunaan aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk lansia dapat membantu meningkatkan motivasi melalui

fitur-fitur seperti pemberian target harian, pengingat aktivitas, serta laporan progres yang jelas dan mudah dipahami (Vseteckova et al., 2021).

Selain itu, wearable technology juga memberikan keunggulan dalam pemantauan yang lebih objektif dan akurat terhadap aktivitas fisik lansia. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan perangkat wearable, seperti fitness tracker, mampu secara signifikan meningkatkan kesadaran lansia akan tingkat aktivitas fisiknya, sekaligus mendorong mereka untuk mencapai target aktivitas harian yang disarankan secara konsisten (Brickwood et al., 2019; Schlomann et al., 2021). Informasi ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi lansia tetapi juga bagi keluarga dan tenaga kesehatan untuk menyesuaikan program aktivitas fisik secara individual berdasarkan data yang diperoleh.

2. Efektivitas Penggunaan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Adherensi Aktivitas Fisik Lansia

Penggunaan teknologi digital terbukti efektif dalam meningkatkan adherensi lansia terhadap aktivitas fisik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia yang menggunakan teknologi digital memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Salah satu alasannya adalah karena teknologi digital menawarkan umpan balik instan yang memotivasi, meningkatkan rasa pencapaian, serta memungkinkan lansia memantau perkembangan kondisi fisiknya secara real-time (Liao et al., 2022).

Selain itu, integrasi fitur sosial seperti komunitas virtual dan fitur berbagi pencapaian dalam aplikasi juga meningkatkan motivasi lansia untuk tetap aktif. Sebuah studi mengungkapkan bahwa lansia yang aktif menggunakan komunitas virtual dalam aplikasi aktivitas fisik cenderung memiliki adherensi lebih tinggi dan merasa lebih terhubung secara sosial dibandingkan lansia yang tidak menggunakan komunitas virtual (Schlomann et al., 2021). Fitur ini sangat penting untuk membantu lansia mengatasi hambatan psikologis seperti isolasi sosial atau kurangnya motivasi internal.

3. Tantangan Pemanfaatan Teknologi Digital pada Lansia

Meskipun efektif, pemanfaatan teknologi digital juga menghadapi beberapa tantangan seperti kesulitan teknis, keterbatasan literasi digital, serta keengganan lansia dalam mengadopsi teknologi baru. Untuk mengatasi tantangan ini, penting adanya pelatihan sederhana yang dirancang khusus untuk lansia agar mereka nyaman menggunakan teknologi tersebut (Vseteckova et al., 2021). Dukungan dari keluarga atau tenaga kesehatan juga diperlukan untuk memastikan lansia dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi ini secara maksimal.

Pemanfaatan teknologi digital, jika diterapkan dengan pendekatan yang tepat, memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi lansia dalam aktivitas fisik, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup serta kesehatan mental mereka secara menyeluruh.

H. Penutup

Aktivitas fisik memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan mental lansia. Berbagai studi terkini telah menegaskan bahwa aktivitas fisik rutin secara signifikan mampu menurunkan risiko depresi, kecemasan, stres, serta meningkatkan kualitas tidur dan fungsi kognitif pada populasi lansia (Amiri, Behnezhad, & Hasani, 2021; Lee, Lee, & Park, 2022). Dengan demikian, integrasi aktivitas fisik sebagai bagian penting dalam manajemen kesehatan mental lansia perlu terus diperkuat, baik melalui kebijakan publik maupun intervensi kesehatan komunitas.

Namun demikian, implementasi aktivitas fisik secara rutin pada lansia menghadapi berbagai tantangan, baik berupa hambatan fisik seperti penyakit kronis dan keterbatasan mobilitas, maupun hambatan psikologis seperti rendahnya motivasi dan kepercayaan diri lansia dalam melakukan aktivitas fisik (Langhammer et al., 2022; Moon, Rote, & Haley, 2020). Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan multidimensi yang mencakup program latihan yang dipersonalisasi, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi yang efektif (Schlomann et al., 2021; Yoon, Kang, & Kim, 2023).

Di masa depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus mengembangkan metode dan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap kondisi fisik, psikologis, serta lingkungan sosial lansia. Selain itu, integrasi teknologi digital yang lebih inklusif dan mudah digunakan oleh lansia perlu terus dikembangkan guna meningkatkan tingkat adherensi terhadap aktivitas fisik secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektoral antara keluarga, komunitas, tenaga kesehatan, serta institusi terkait juga penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan aktivitas fisik lansia.

Dengan komitmen yang tinggi serta dukungan dari berbagai pihak, aktivitas fisik dapat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara holistik, khususnya dalam aspek kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka.

Referensi

- Amiri, S., Behnezhad, S., & Hasani, J. (2021). Physical activity and mental health in elderly: A systematic review. *Journal of Aging and Physical Activity*, 29(3), 500–514.
- Baxter, S., Johnson, M., Payne, N., Buckley-Woods, H., Blank, L., & Hock, E. (2020). Promoting and maintaining physical activity in older age through community-based interventions: A systematic review of qualitative evidence. *Journal of Aging and Physical Activity*, 28(3), 404–421.
- Brickwood, K. J., Watson, G., O'Brien, J., & Williams, A. D. (2019). Consumer-based wearable activity trackers increase physical activity participation: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(4), e11819.
- Cunningham, C., O'Sullivan, R., Caserotti, P., & Tully, M. A. (2020). Consequences of physical inactivity in older adults: A systematic review of reviews and meta-analyses. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 30(5), 816–827.
- De Souto Barreto, P., Rolland, Y., Vellas, B., & Maltais, M. (2021). Association of long-term exercise training with mortality in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Gerontology: Medical Sciences*, 76(8), 1377–1386.
- Domingos, C., Pêgo, J. M., & Santos, N. C. (2021). Effects of physical activity on brain function and cognitive performance in older adults: A review. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 36(10), 1485–1500.
- Engers, P. B., Rombaldi, A. J., & da Silva, M. C. (2022). Effect of Pilates on anxiety symptoms among elderly: A systematic review and meta-analysis. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 48, 101585.
- Huang, C., Yang, Y., Lu, T., Huang, Y., & Chang, H. (2021). Influence of community environmental factors on older adults' physical activity and mental health: A cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4042.
- Keadle, S. K., Moore, S. C., Sampson, J. N., Xiao, Q., & Albanes, D. (2022). Family support and physical activity levels in older adults: findings from a longitudinal study. *Journal of Gerontology: Social Sciences*, 77(6), 1142–1150.
- Kim, Y., Choi, M., & Son, C. (2020). Impact of Tai Chi on cognitive function and depression in older adults: A randomized controlled trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 4520.
- Langhammer, B., Bergland, A., & Rydwick, E. (2022). The importance of physical activity exercise among older people. *BioMed Research International*, 2022, Article ID 9829756.

- Lee, J. H., Lee, J. Y., & Park, J. H. (2022). Effects of regular exercise on depressive symptoms among elderly adults: A meta-analysis. *Aging & Mental Health*, 26(8), 1620–1630.
- Liao, Y., Shonkoff, E. T., & Dunton, G. F. (2022). The effectiveness of mobile health interventions for improving physical activity adherence in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Aging and Physical Activity*, 30(4), 611–623.
- Moon, C., Rote, S., & Haley, W. E. (2020). Family support and older adults' physical activity: The mediating role of self-efficacy. *Journal of Applied Gerontology*, 39(3), 290–299.
- Schlomann, A., Wahl, H.-W., Bausche, A., & Gross, C. (2021). Impact of digital technology on physical activity in older adults: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(4), e28087.
- Silva, V. F., Oliveira, G. G., & Santos, A. M. (2021). Effects of yoga on anxiety and depression symptoms among older adults: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Psychiatric Research*, 137, 87–95.
- Tarazona-Santabalbina, F. J., Gómez-Cabrera, M. C., Pérez-Ros, P., Martínez-Arnau, F. M., & Cabo, H. (2022). Exercise interventions for frail older adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Medical Directors Association*, 23(2), 236–245.
- Van Hoof, J., Kazak, J. K., & Perek-Białas, J. M. (2021). The challenges of creating age-friendly environments in Europe: A review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1044.
- Vseteckova, J., Methley, A., Jones, R., & Howarth, A. (2021). Evaluating mobile health technology to support older adults' engagement in physical activity: A mixed-method systematic review. *Gerontology and Geriatric Medicine*, 7, 1–18.
- Yerrakalva, D., Yerrakalva, D., Hajna, S., & Griffin, S. (2019). Effects of mobile health app interventions on sedentary time, physical activity, and fitness in older adults: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 21(11), e14343.
- Yoon, D. H., Kang, D., & Kim, J. H. (2023). Effectiveness of community-based exercise programs in reducing anxiety and depression in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Geriatric Nursing*, 44, 25–34.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). *Physical Activity for Older Adults*. Retrieved from https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/older_adults/index.htm.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Aktivitas Fisik untuk Lansia*. Jakarta: Direktorat Promosi Kesehatan.

World Health Organization (WHO). (2020). *Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. WHO Press.

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING LANSIA

A. Pendahuluan

Lansia merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya akibat berbagai faktor, termasuk penurunan fungsi fisik, sosial, dan isolasi sosial. Tantangan ini semakin kompleks ketika akses layanan konseling konvensional menjadi terbatas, baik karena hambatan geografis, ekonomi, atau keterbatasan mobilitas fisik. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam layanan konseling bagi lansia menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta efektivitas layanan kesehatan mental di populasi ini (Charness, Boot, & Czaja, 2021).

Teknologi telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan mental. Pemanfaatan teknologi, seperti telekonseling, aplikasi kesehatan mental, dan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI), menawarkan potensi besar untuk mengatasi kendala layanan kesehatan mental tradisional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis teknologi mampu memberikan hasil signifikan dalam peningkatan kesejahteraan psikologis lansia, mengurangi gejala kecemasan, depresi, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara umum (Zhao, Feng, Hu, & Hu, 2021; Lee, Kim, Rim, & Kim, 2022).

Namun demikian, implementasi teknologi dalam konseling lansia juga menghadapi beberapa tantangan yang khas. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital, keterbatasan akses internet, serta isu terkait privasi dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, dalam menerapkan layanan berbasis teknologi ini, penting untuk memperhatikan strategi inklusif yang memungkinkan lansia dapat menerima manfaat penuh dari layanan digital tersebut (WHO, 2021; Pew Research Center, 2022).

Pendahuluan ini bertujuan menguraikan pentingnya integrasi teknologi dalam layanan konseling kesehatan mental bagi lansia, mengeksplorasi manfaat, tantangan, serta peluang pengembangan teknologi lanjutan dalam rangka mendukung kesehatan mental lansia secara optimal dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Teknologi untuk Konseling Lansia

Perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam penyediaan layanan konseling, terutama bagi kelompok lanjut usia (lansia). Jenis teknologi yang tersedia semakin beragam dan mampu menjawab tantangan keterbatasan fisik, jarak, dan akses yang sering dialami lansia. Berikut beberapa teknologi utama yang telah digunakan dan terbukti efektif dalam mendukung konseling kesehatan mental pada lansia:

1. Telekonseling Berbasis Video (Telehealth)

Telekonseling atau telehealth adalah layanan konseling yang disediakan melalui komunikasi jarak jauh menggunakan perangkat video. Teknologi ini memungkinkan lansia berkomunikasi langsung dengan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor tanpa perlu meninggalkan rumah mereka. Penelitian menunjukkan bahwa telekonseling berbasis video memiliki efektivitas yang sebanding dengan konseling tatap muka, khususnya dalam mengurangi tingkat depresi, kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia secara signifikan (Wang et al., 2021; Zhao et al., 2021). Telekonseling juga mampu mengatasi hambatan akses akibat keterbatasan mobilitas fisik, jarak, maupun kondisi geografis (Chen et al., 2022).

2. Aplikasi Mobile Kesehatan Mental Lansia

Pemanfaatan aplikasi berbasis mobile (aplikasi smartphone) untuk mendukung kesehatan mental lansia semakin populer karena mudah diakses, praktis, dan hemat biaya. Aplikasi ini umumnya dilengkapi fitur-fitur seperti latihan relaksasi, mindfulness, jurnal kesehatan mental, dan intervensi berbasis terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavioral Therapy atau CBT). Studi terbaru menemukan bahwa penggunaan aplikasi mobile secara rutin dapat secara signifikan mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada lansia, serta memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Lee et al., 2022; Ahmad & Chan, 2023). Namun, penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut mudah digunakan, sesuai dengan tingkat literasi digital lansia, dan aman dari segi privasi data (WHO, 2021).

3. Platform Konseling Online Berbasis Chatbot dan AI

Chatbot berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) merupakan teknologi baru yang mulai banyak digunakan dalam layanan konseling kesehatan mental. Chatbot menggunakan algoritma AI yang mampu memberikan respons otomatis berdasarkan kondisi emosional dan pertanyaan pengguna secara real-time. Teknologi ini memberikan manfaat khusus karena

tersedia selama 24 jam, memberikan rasa aman dan nyaman bagi lansia yang membutuhkan dukungan segera (Kuo et al., 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa chatbot konseling terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi ringan hingga sedang pada lansia (Inkster et al., 2021). Meski demikian, untuk penggunaan jangka panjang, chatbot perlu dikombinasikan dengan intervensi konseling profesional agar efektifitasnya terjaga (Kuo et al., 2023).

Pemanfaatan berbagai teknologi ini menawarkan pendekatan inovatif yang menjanjikan dalam pelayanan konseling lansia. Namun, implementasi teknologi harus mempertimbangkan faktor usia, literasi digital, serta preferensi personal lansia agar dapat memberikan manfaat optimal dan inklusif.

C. Efektivitas Pemanfaatan Teknologi dalam Konseling Lansia

Pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling lansia semakin menjadi solusi yang diandalkan, khususnya untuk menjangkau populasi lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas atau akses layanan secara langsung. Efektivitas teknologi dalam layanan ini telah terbukti dalam berbagai penelitian, terutama dalam menurunkan gejala gangguan mental dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan.

1. Dampak Positif Teknologi dalam Mengurangi Gejala Kecemasan dan Depresi

Teknologi digital, seperti aplikasi mobile kesehatan mental dan platform berbasis telekonseling, secara luas telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi pada lansia. Penelitian Zhao et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi telehealth berbasis video mampu secara signifikan menurunkan tingkat depresi lansia dibandingkan dengan layanan konvensional. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad dan Chan (2023) juga menunjukkan aplikasi mobile yang menawarkan terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) berhasil menurunkan gejala kecemasan pada lansia setelah intervensi selama 8 minggu. Teknologi ini memberikan dukungan psikologis yang berkelanjutan dan dapat diakses kapan saja, memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepatuhan lansia dalam mengikuti intervensi.

2. Efektivitas Telekonseling terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Lansia

Telekonseling telah menjadi salah satu metode penting yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Menurut Chen et al. (2022), telekonseling tidak hanya efektif dalam aspek psikologis, tetapi juga terbukti meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional lansia secara umum. Hal ini didukung oleh studi sistematis yang dilakukan oleh Wang, Mark, dan Hansen (2021), yang

menemukan bahwa telepsikologi secara signifikan mampu meningkatkan rasa percaya diri lansia, memperkuat interaksi sosial, serta menurunkan tingkat kesepian yang menjadi faktor risiko penting dalam penurunan kualitas hidup lansia. Telekonseling memungkinkan komunikasi interaktif yang lebih sering antara lansia dengan konselor profesional, memberikan perasaan didukung secara emosional, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup lansia secara holistik.

3. Studi Kasus Implementasi Teknologi dalam Layanan Kesehatan Mental Lansia

Implementasi teknologi dalam layanan kesehatan mental lansia telah didokumentasikan dalam beberapa studi kasus di berbagai negara. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Kuo et al. (2023) tentang penggunaan chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI) di Taiwan menunjukkan bahwa chatbot dapat mengurangi tingkat kecemasan lansia secara signifikan dalam waktu dua bulan implementasi. Studi lainnya oleh Lee et al. (2022) di Korea Selatan menunjukkan efektivitas penggunaan aplikasi mobile berbasis CBT pada lansia dengan gejala depresi ringan hingga sedang, yang menghasilkan penurunan skor depresi yang signifikan dalam kurun waktu intervensi selama 4 minggu. Studi kasus tersebut memberikan gambaran nyata mengenai manfaat konkret yang dapat diperoleh lansia melalui teknologi dalam layanan kesehatan mental, meskipun tantangan seperti literasi digital dan keterbatasan akses tetap perlu menjadi perhatian khusus (WHO, 2021).

Secara keseluruhan, berbagai bukti ilmiah dan studi kasus di atas menegaskan efektivitas penggunaan teknologi dalam mendukung layanan konseling lansia. Implementasi teknologi ini tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi gejala psikologis tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup lansia secara nyata dan berkelanjutan.

D. Strategi Implementasi Teknologi untuk Konseling Lansia

Implementasi teknologi dalam konseling lansia perlu didukung oleh berbagai strategi yang sistematis dan terintegrasi agar mampu memberikan manfaat optimal bagi kesehatan mental lansia. Strategi tersebut meliputi pelatihan bagi tenaga profesional, pengembangan kebijakan dan regulasi yang jelas, serta kolaborasi multidisiplin yang efektif.

1. Pelatihan Konselor dan Tenaga Kesehatan terkait Teknologi Digital

Pelatihan tenaga kesehatan, termasuk konselor dan tenaga medis lainnya, merupakan kunci utama dalam keberhasilan implementasi teknologi digital pada layanan konseling lansia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi

digital, kemampuan teknis, serta pemahaman etika dalam menggunakan teknologi digital (Armitage, Nellums, & Tam, 2020). Studi menunjukkan bahwa pelatihan khusus mengenai telekonseling atau aplikasi kesehatan mental secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri konselor dalam memberikan layanan digital, yang berdampak positif terhadap kepuasan lansia terhadap layanan yang diterima (Chen et al., 2022). Selain keterampilan teknis, pelatihan juga perlu mencakup aspek komunikasi empatik dalam konteks digital agar lansia tetap merasa nyaman dan terbantu meskipun interaksi berlangsung secara virtual (Wang, Mark, & Hansen, 2021).

2. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pemanfaatan Teknologi untuk Konseling Lansia

Pengembangan dan implementasi teknologi digital dalam konseling kesehatan mental lansia membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk menjamin efektivitas dan keamanan layanan. Kebijakan ini mencakup regulasi terkait perlindungan data pribadi, standar kualitas layanan telekonseling, serta panduan etika profesional dalam menggunakan teknologi digital (WHO, 2021). Menurut Charness, Boot, dan Czaja (2021), kebijakan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan lansia dan keluarganya terhadap layanan digital, serta mencegah risiko penyalahgunaan data dan informasi pribadi lansia. Penyusunan kebijakan juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus populasi lansia, seperti tingkat literasi digital yang rendah dan risiko terjadinya kesalahan teknis atau komunikasi dalam interaksi digital (Pew Research Center, 2022).

3. Kolaborasi Multidisiplin dalam Penerapan Teknologi

Kolaborasi multidisiplin menjadi elemen penting dalam implementasi teknologi untuk konseling lansia. Pendekatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, keperawatan, kedokteran geriatri, teknologi informasi, dan kebijakan publik dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Kolaborasi multidisiplin mampu menciptakan pendekatan holistik dan terpadu dalam memberikan layanan konseling berbasis teknologi digital (Kuo, Liu, & Lee, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus lansia, mengembangkan solusi teknologi yang tepat sasaran, serta mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama implementasi teknologi, seperti masalah teknis atau penyesuaian metode konseling dengan kondisi spesifik lansia (Inkster, Sarda, & Subramanian, 2021).

Secara keseluruhan, strategi implementasi teknologi untuk konseling lansia yang mencakup pelatihan profesional, kebijakan dan regulasi yang jelas, serta kolaborasi multidisiplin, menjadi faktor krusial dalam memastikan keberhasilan

jangka panjang pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan mental lansia.

E. Hambatan dan Solusi dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Konseling Lansia

Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan konseling lansia memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan mental. Namun, implementasi teknologi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang harus diatasi secara efektif agar layanan yang diberikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Hambatan Teknologi dalam Konseling Lansia

a. Aksesibilitas Teknologi

Hambatan utama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk konseling lansia adalah masalah aksesibilitas. Banyak lansia yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses perangkat atau koneksi internet yang stabil, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Studi menunjukkan bahwa akses terbatas ini sering kali menjadi penghalang signifikan dalam partisipasi lansia pada layanan konseling berbasis teknologi (Chen et al., 2022).

b. Literasi Digital yang Rendah

Literasi digital yang rendah merupakan tantangan lain dalam penerapan teknologi digital bagi lansia. Lansia cenderung memiliki kesulitan dalam memahami cara menggunakan teknologi baru, seperti aplikasi smartphone atau platform online, yang menjadi hambatan signifikan dalam keberhasilan layanan konseling berbasis teknologi (Charness, Boot, & Czaja, 2021). Hambatan ini menyebabkan banyak lansia merasa frustrasi, kurang percaya diri, atau bahkan menolak penggunaan teknologi tersebut.

c. Isu Privasi dan Keamanan Data

Isu privasi dan keamanan data pribadi menjadi perhatian besar dalam layanan konseling digital bagi lansia. Lansia mungkin khawatir tentang potensi penyalahgunaan data pribadi mereka atau risiko bocornya informasi sensitif. Kekhawatiran ini dapat menyebabkan lansia enggan menggunakan layanan digital, meskipun teknologi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental mereka (WHO, 2021; Pew Research Center, 2022).

2. Strategi Mengatasi Tantangan Teknologi pada Lansia

a. Strategi Meningkatkan Aksesibilitas

Untuk mengatasi hambatan aksesibilitas, diperlukan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang kuat dari pemerintah dan stakeholder terkait. Peningkatan akses internet di daerah terpencil serta distribusi perangkat teknologi kepada lansia yang membutuhkan dapat menjadi solusi konkret

(WHO, 2021). Selain itu, penyediaan pusat layanan konseling digital terpadu yang mudah diakses oleh lansia juga dapat memperluas jangkauan layanan teknologi ini.

b. Pendidikan dan Pelatihan Literasi Digital

Pendidikan dan pelatihan literasi digital khusus bagi lansia sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi. Program pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lansia, dengan pendekatan yang sederhana, bertahap, dan ramah pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital yang terstruktur dapat meningkatkan rasa percaya diri lansia, mengurangi kecemasan dalam menggunakan teknologi, dan secara signifikan meningkatkan penggunaan teknologi digital secara konsisten (Charness et al., 2021; Wang, Mark, & Hansen, 2021).

c. Perlindungan Privasi dan Keamanan Data

Pengembangan regulasi dan standar ketat terkait privasi dan keamanan data merupakan solusi penting dalam mengatasi hambatan penggunaan teknologi digital. Standar ini mencakup enkripsi data, pengelolaan informasi sensitif secara aman, serta komunikasi terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, konselor atau tenaga profesional harus secara jelas mengedukasi lansia tentang bagaimana data mereka dilindungi dan digunakan selama proses konseling, sehingga meningkatkan rasa percaya lansia terhadap layanan digital tersebut (Kuo, Liu, & Lee, 2023).

Implementasi berbagai strategi ini secara terintegrasi akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi lansia dalam penggunaan teknologi untuk layanan konseling kesehatan mental. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan mental lansia.

F. Praktik Terbaik dan Rekomendasi

Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan konseling lansia telah memberikan dampak signifikan dalam mendukung kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Agar dampak positif tersebut optimal dan berkelanjutan, implementasi teknologi perlu didasarkan pada praktik terbaik yang teruji secara ilmiah serta didukung rekomendasi pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lansia di masa depan.

1. Best Practice Penggunaan Teknologi untuk Konseling Lansia Berdasarkan Bukti Ilmiah

a. **Pemilihan Teknologi yang Ramah Lansia**

Best practice pertama adalah penggunaan teknologi yang ramah lansia, yang mencakup desain antarmuka sederhana, huruf besar, petunjuk yang jelas, serta navigasi yang intuitif. Studi oleh Lee et al. (2022) menunjukkan bahwa aplikasi dengan desain user-friendly secara signifikan meningkatkan tingkat adopsi dan kepatuhan lansia dalam mengikuti program konseling digital.

b. **Konseling Berbasis Video (Telehealth)**

Telekonseling melalui video call yang dilakukan secara terjadwal terbukti efektif dan memberikan hasil positif dalam mengurangi gejala depresi, kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional lansia (Zhao et al., 2021; Wang, Mark, & Hansen, 2021). Frekuensi interaksi yang konsisten serta pembentukan hubungan terapeutik yang kuat antara konselor dengan lansia menjadi praktik terbaik dalam layanan ini.

c. **Pendekatan Kombinasi (Blended Approach)**

Pendekatan kombinasi atau blended approach yang menggabungkan konseling tatap muka secara langsung dan layanan konseling digital terbukti memberikan hasil terbaik bagi lansia. Pendekatan ini mampu mempertahankan interaksi sosial langsung yang esensial bagi lansia, sekaligus memberikan fleksibilitas akses melalui teknologi digital. Studi oleh Armitage, Nellums, dan Tam (2020) menyarankan bahwa pendekatan kombinasi lebih efektif dibandingkan dengan metode tunggal digital atau tatap muka dalam meningkatkan hasil kesehatan mental lansia.

2. Rekomendasi Pengembangan Teknologi ke Depan

a. **Pengembangan Teknologi Adaptif Berbasis AI**

Salah satu rekomendasi utama adalah pengembangan teknologi adaptif berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan spesifik tiap individu lansia. Chatbot berbasis AI yang dikembangkan lebih lanjut dengan kemampuan empati, pengenalan emosi secara real-time, serta interaksi yang menyerupai percakapan manusia menjadi area pengembangan penting di masa depan (Kuo, Liu, & Lee, 2023; Inkster, Sarda, & Subramanian, 2021).

b. **Integrasi Teknologi Kesehatan dan Sosial**

Pengembangan teknologi ke depan juga harus mencakup integrasi layanan kesehatan mental dengan layanan sosial berbasis komunitas. Integrasi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang holistik untuk lansia, sehingga mereka bisa memperoleh dukungan psikologis dan sosial dalam satu platform terpadu (WHO, 2021). Hal ini juga didukung oleh rekomendasi Pew

Research Center (2022), yang menyebutkan perlunya pengembangan platform yang menyatukan berbagai aspek kebutuhan lansia secara komprehensif.

c. Penelitian Lanjutan Mengenai Efektivitas dan Dampak Jangka Panjang

Penelitian lanjutan yang berfokus pada evaluasi efektivitas jangka panjang dan dampak sosial dari teknologi konseling digital bagi lansia sangat penting untuk dilakukan. Penelitian tersebut dapat memberikan bukti yang lebih kuat untuk penyempurnaan teknologi yang ada serta memberikan informasi mengenai pendekatan intervensi yang paling efektif bagi lansia dengan berbagai kondisi kesehatan mental (Charness, Boot, & Czaja, 2021).

Dengan menerapkan praktik terbaik dan mengikuti rekomendasi pengembangan teknologi ini, diharapkan layanan konseling digital mampu secara berkelanjutan memberikan manfaat maksimal dalam mendukung kesejahteraan mental lansia di masa depan.

G. Penutup

Pemanfaatan teknologi dalam konseling lansia telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mendukung kesehatan mental lansia secara signifikan. Berbagai jenis teknologi, seperti telekonseling berbasis video, aplikasi mobile kesehatan mental, serta platform chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI), mampu mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara umum (Zhao et al., 2021; Lee et al., 2022). Strategi implementasi yang efektif melibatkan pelatihan tenaga kesehatan, kebijakan regulasi yang mendukung, serta kolaborasi multidisiplin. Namun, tantangan berupa aksesibilitas teknologi, literasi digital yang rendah, serta isu privasi dan keamanan data pribadi masih perlu mendapat perhatian khusus (Charness, Boot, & Czaja, 2021; Chen et al., 2022).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan berupa pelatihan literasi digital, peningkatan infrastruktur teknologi, serta kebijakan ketat mengenai privasi data merupakan solusi yang perlu diterapkan secara konsisten. Praktik terbaik yang berbasis bukti ilmiah, seperti desain teknologi ramah lansia dan pendekatan kombinasi antara layanan digital dan tatap muka, telah terbukti efektif dan harus terus dikembangkan (Armitage, Nellums, & Tam, 2020; WHO, 2021).

Penelitian lanjutan perlu terus dikembangkan untuk memperluas bukti ilmiah mengenai efektivitas teknologi digital dalam konseling lansia. Fokus penelitian berikutnya sebaiknya mencakup evaluasi dampak jangka panjang, efektivitas biaya layanan teknologi digital, serta eksplorasi lebih lanjut tentang preferensi lansia dalam menggunakan teknologi konseling (Kuo, Liu, & Lee, 2023). Penelitian terkait adaptasi teknologi berbasis AI yang lebih sensitif terhadap kondisi emosional lansia juga menjadi area penting untuk dikembangkan.

Selain itu, penelitian intervensi berbasis komunitas yang mengintegrasikan teknologi dengan dukungan sosial dan komunitas perlu lebih digalakkan. Hal ini akan membantu menciptakan ekosistem layanan kesehatan mental digital yang lebih komprehensif dan inklusif bagi lansia (Pew Research Center, 2022). Penelitian masa depan juga diharapkan mengeksplorasi metode terbaik untuk meningkatkan literasi digital lansia secara efektif, agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan merata (Wang, Mark, & Hansen, 2021).

Dengan terus berkembangnya penelitian di bidang ini, diharapkan layanan konseling berbasis teknologi dapat terus meningkat dalam menjawab kebutuhan kesehatan mental lansia, seiring dengan bertambahnya populasi lansia di masa depan.

Referensi

- Ahmad, A., & Chan, Y. F. Y. (2023). Mobile mental health applications for older adults: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 38(2), e5869. <https://doi.org/10.1002/gps.5869>
- Armitage, R., Nellums, L. B., & Tam, C. W. C. (2020). Remote mental health interventions for older adults during COVID-19: Rapid review and recommendations. *BJPsych Open*, 6(5), e91. <https://doi.org/10.1192/bjo.2020.79>
- Charness, N., Boot, W. R., & Czaja, S. J. (2021). Technology use and cognitive aging: Challenges and opportunities. *The Journals of Gerontology: Series B*, 76(Suppl 1), S30–S38. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa092>
- Chen, A. T., Chen, K., Barriers, L., & Wootton, R. (2022). Factors influencing the use of telemedicine among older adults: A systematic review. *Telemedicine and e-Health*, 28(4), 503–512. <https://doi.org/10.1089/tmj.2021.0123>
- Inkster, B., Sarda, S., & Subramanian, V. (2021). An empathy-driven conversational chatbot (Woebot) for digital mental health: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 23(9), e31321. <https://doi.org/10.2196/31321>
- Kuo, M. C., Liu, C. F., & Lee, P. H. (2023). Evaluating chatbot-driven teletherapy for anxiety reduction in elderly patients: A pilot randomized trial. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, 36(2), 107–115. <https://doi.org/10.1177/08919887221125670>
- Lee, S. H., Kim, S., Rim, H. D., & Kim, H. (2022). A smartphone-based cognitive behavioral therapy app for older adults with depressive symptoms: A pilot randomized controlled trial. *Aging & Mental Health*, 26(3), 509–517. <https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1884841>
- Wang, X., Mark, M., & Hansen, A. (2021). Telepsychology for older adults: A systematic review of feasibility and effectiveness. *International Psychogeriatrics*, 33(12), 1257–1270. <https://doi.org/10.1017/S1041610220001182>
- Zhao, Y., Feng, H., Hu, M., & Hu, H. (2021). Effectiveness of telehealth-based counseling interventions in reducing depression among elderly people: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 27(10), 624–637. <https://doi.org/10.1177/1357633X211011764>
- Pew Research Center. (2022). *Older adults and technology use*. Retrieved from <https://www.pewresearch.org/internet/2022/older-adults-and-technology-use>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Digital health and older people*. Retrieved from <https://www.who.int/publications/digital-health-and-older-people>

BAB VII

KOLABORASI MULTIDISPLIN DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL LANSIA

A. Pendahuluan

Populasi lansia di dunia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut *Prospek Populasi Dunia 2019*, pada tahun 2050, satu dari enam orang di dunia akan berusia 65 tahun atau lebih, meningkat dari satu dari sebelas orang pada tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah lansia global tercatat sebanyak 703 juta jiwa, dan diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050 (Setyarini, 2022). *The National Populations Division* juga memperkirakan bahwa pada tahun 2025, jumlah lansia dunia akan mencapai 1,2 miliar, dengan sekitar 840 juta di antaranya berada di negara berkembang (Muhith & Siyoto, 2016). Data terbaru menunjukkan bahwa populasi lansia global akan meningkat dari 1,4 miliar pada tahun 2020 menjadi 2,1 miliar pada tahun 2050 (Girsang et al., 2022). Tren ini menunjukkan bahwa jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia meningkat secara global, sehingga menuntut perhatian lebih terhadap kebutuhan kesehatan mereka, termasuk kesehatan mental.

Di Indonesia, jumlah lansia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2016*, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah lansia mencapai 22,6 juta jiwa dan meningkat menjadi 31,3 juta jiwa pada tahun 2022. Secara nasional, jumlah lansia pada tahun 2019 tercatat sebanyak 27,5 juta jiwa atau 10,3% dari total populasi, dan diproyeksikan meningkat menjadi 57 juta jiwa atau 17,9% pada tahun 2045 (Saidah, 2024). Peningkatan jumlah lansia ini berpotensi meningkatkan angka kejadian gangguan kesehatan mental, yang sering kali tidak terdiagnosis atau kurang mendapatkan perhatian dalam layanan kesehatan.

Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Kesehatan mental lansia mencerminkan kondisi di mana seseorang merasa sehat, terbebas dari gangguan mental, serta mampu berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, proses penuaan sering kali dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan demensia (Saidah, 2024). Diperkirakan bahwa sekitar 6,6% dari total kecacatan pada lansia berkaitan dengan gangguan mental atau neurologis, dengan prevalensi

demensia dan depresi masing-masing berkisar antara 5-7%, sementara gangguan kecemasan memengaruhi sekitar 3,8% populasi lansia. Selain itu, hampir seperempat kasus kematian lansia diakibatkan oleh tindakan menyakiti diri sendiri (Wu Y-T, 2020).

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa gangguan mental lebih sering terjadi pada lansia dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. WHO melaporkan bahwa 236 orang lansia per 100.000 jiwa mengalami gangguan kejiwaan, dibandingkan dengan 93 orang pada kelompok usia 45-64 tahun (Petrova, 2021). Di Swedia, prevalensi gangguan mental pada lansia mencapai 33%, dengan demensia (16%), depresi (12%), dan kecemasan (11%) sebagai kondisi yang paling umum. Sebuah meta-analisis menemukan bahwa prevalensi seumur hidup gangguan afektif pada lansia mencapai 16,52%, gangguan kecemasan 2,63%, gangguan penyalahgunaan zat 11,71%, dan psikosis 4,7% (McCombe, 2018).

Tingginya angka kejadian gangguan kesehatan mental pada lansia menunjukkan pentingnya perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan multidisiplin menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi permasalahan ini. Perawatan yang hanya berfokus pada satu aspek, seperti medis atau psikologis saja, sering kali tidak cukup untuk memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai tenaga profesional seperti dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, terapis okupasi, serta dukungan dari keluarga sangat diperlukan untuk memastikan lansia mendapatkan perawatan yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan multidisiplin memungkinkan deteksi dini, intervensi yang lebih efektif, serta pengelolaan kesehatan mental yang lebih baik bagi lansia. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarprofesi, layanan yang diberikan menjadi lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan individu lansia. Selain itu, dukungan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kesehatan mental lansia sangat penting untuk memastikan keberlanjutan perawatan multidisiplin ini.

Dengan meningkatnya jumlah lansia di Indonesia dan dunia, kesehatan mental lansia harus menjadi prioritas dalam sistem pelayanan kesehatan. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, baik tenaga kesehatan, akademisi, pemerintah, maupun masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental lansia. Dengan pendekatan yang tepat, lansia dapat menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik, kesejahteraan psikologis yang optimal, serta tetap memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial dan keluarga.

B. Kashagan Mental Pada Lansia

Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Penurunan fungsi tubuh yang terjadi secara alami sering kali memengaruhi keseimbangan emosional dan kognitif, yang berkontribusi terhadap timbulnya berbagai gangguan mental. Kesehatan mental yang baik memungkinkan lansia untuk beradaptasi dengan perubahan, mempertahankan stabilitas diri, serta memiliki penilaian yang realistis terhadap kehidupan dan dirinya sendiri (Mujib & Muzakir, 2001). Namun, banyak lansia mengalami tantangan mental yang signifikan, seperti perasaan kesepian, kehilangan makna hidup, kecemasan terhadap masa depan, serta penurunan kepercayaan diri akibat perubahan kondisi fisik dan sosial. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental lansia menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berbagai gangguan mental dapat terjadi pada lansia, di antaranya gangguan kognitif yang ditandai dengan lupa, pikun, bingung, serta meningkatnya rasa curiga terhadap orang lain. Selain itu, gangguan perasaan seperti mudah tersinggung, kelelahan, serta apatis juga sering dialami oleh lansia. Gangguan perilaku pun dapat muncul, seperti kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, hilangnya minat untuk berinteraksi, serta ketidakmampuan dalam merawat diri sendiri (Muna, 2020). Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan-gangguan ini dapat memperburuk kondisi mental lansia, menyebabkan depresi, bahkan meningkatkan risiko tindakan menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, deteksi dini dan intervensi yang tepat sangat diperlukan agar lansia dapat menjalani kehidupan dengan kualitas mental yang lebih baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental lansia sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah perubahan fisik akibat penuaan, kesehatan umum yang menurun, tingkat pendidikan, faktor keturunan, serta lingkungan sosial (Nasrullah, 2016). Selain itu, perubahan besar dalam hidup seperti pensiun dari pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, dan berkurangnya peran dalam keluarga atau masyarakat juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan emosi lansia. Lansia yang merasa kehilangan identitas dan tujuan hidup setelah pensiun cenderung mengalami stres dan depresi. Tidak hanya itu, masalah ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta kurangnya dukungan sosial juga menjadi faktor yang dapat memperburuk kondisi mental mereka.

Selain tantangan yang dihadapi, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental lansia. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah menumbuhkan kebersyukuran dalam kehidupan sehari-hari. Kebersyukuran merupakan kecenderungan untuk menyadari dan menghargai

pengalaman positif serta kebaikan yang diterima dalam hidup (McCullough, Emmons, & Tsang, 2002). Lansia yang mampu bersyukur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, lebih mampu menerima perubahan dalam hidup, serta memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Dalam ajaran Islam, kebersyukuran juga ditekankan sebagai cara untuk memperoleh ketenangan batin, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ibrahim ayat 7 bahwa bersyukur akan mendatangkan lebih banyak nikmat, sedangkan mengingkari nikmat dapat membawa penderitaan (Muna, 2020). Dengan menanamkan sikap bersyukur, lansia dapat menghadapi masa tua dengan lebih positif dan damai.

Meskipun perubahan drastis dalam kepribadian lansia jarang terjadi, beberapa kecenderungan umum dapat diamati, seperti meningkatnya sikap egosentris, mudah curiga, serta keinginan untuk tetap mempertahankan hak dan harta yang dimilikinya. Lansia juga umumnya memiliki harapan untuk tetap berperan dalam masyarakat, dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, serta menjalani kehidupan yang bermartabat hingga akhir hayat. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk memenuhi harapan ini dapat menimbulkan perasaan tidak berharga dan frustrasi. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan emosional yang cukup, menjaga komunikasi yang baik, serta melibatkan lansia dalam kegiatan sosial agar mereka tetap merasa dihargai dan memiliki tujuan dalam hidup.

Dengan meningkatnya jumlah lansia di Indonesia dan dunia, perawatan kesehatan mental mereka harus menjadi prioritas dalam sistem layanan kesehatan. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, serta dukungan keluarga sangat penting dalam memastikan kesejahteraan mental lansia. Program-program sosial yang mendorong lansia untuk tetap aktif secara fisik dan mental, serta kebijakan yang mendukung akses terhadap layanan kesehatan mental, juga harus terus dikembangkan. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih bahagia, sejahtera, serta tetap memiliki peran yang berarti dalam kehidupan sosial dan keluarga mereka.

C. Peran Beragam Profesi dalam Layanan Kesehatan Mental Lansia

Layanan kesehatan mental bagi lansia membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi dengan keahlian yang berbeda-beda. Menurut rekomendasi Departemen Kesehatan Mental WHO (2005), pekerja kesehatan mental mencakup psikiater, psikolog, perawat kesehatan jiwa, dan pekerja sosial. Sementara itu, Trull (2005) menambahkan bahwa pekerja kesehatan mental juga mencakup psikolog konseling, pekerja sosial bidang kejiwaan, psikolog sekolah, psikolog

rehabilitasi, psikolog kesehatan, serta perawat kesehatan. Dari berbagai referensi ini, dapat disimpulkan bahwa layanan kesehatan mental, terutama bagi lansia, memerlukan kolaborasi dari berbagai profesi untuk memastikan pendekatan yang holistik dan efektif.

Undang-Undang Kesehatan Mental (Mental Health National Policy) yang merupakan hasil dari pertemuan pengembangan kebijakan kesehatan mental nasional pada 4-8 Oktober 2000 (Mawarpury, 2013), juga menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai profesi dalam pelayanan kesehatan mental. Profesi yang disebutkan dalam kebijakan tersebut meliputi psikiater, neurolog, psikolog atau psikolog klinis, praktisi umum, dokter keluarga spesialis kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan, konselor profesional, pedagog, terapis, terapis wicara, serta terapis fisik. Beragamnya profesi ini menunjukkan bahwa kesehatan mental lansia tidak hanya ditangani dari aspek medis saja, tetapi juga dari aspek psikologis, sosial, dan rehabilitasi.

Psikiater memiliki peran utama dalam mendiagnosis dan menangani gangguan mental pada lansia dengan pendekatan medis, termasuk pemberian obat-obatan psikotropika yang dibutuhkan. Sementara itu, psikolog membantu lansia dalam mengatasi tekanan emosional dan psikologis melalui terapi serta konseling. Konselor profesional berperan dalam memberikan dukungan psikososial untuk membantu lansia menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka, seperti pensiun atau kehilangan pasangan. Keberadaan pekerja sosial juga sangat penting, terutama dalam membantu lansia mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental, fasilitas pendukung, dan dukungan komunitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain profesi di bidang psikologi dan psikiatri, perawat kesehatan jiwa juga memainkan peran kunci dalam memberikan perawatan langsung bagi lansia dengan gangguan mental. Mereka tidak hanya membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan mental pasien tetapi juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara merawat lansia yang mengalami gangguan mental. Di sisi lain, ahli terapi wicara dan terapis fisik berperan dalam membantu lansia yang mengalami gangguan komunikasi atau gangguan mobilitas akibat kondisi neurologis tertentu yang memengaruhi kesehatan mental mereka.

Dukungan dari dokter umum dan dokter keluarga juga sangat penting dalam mendeteksi dini gangguan mental pada lansia dan memberikan rujukan kepada spesialis yang sesuai. Neurolog, yang memiliki keahlian dalam menangani gangguan otak dan sistem saraf, juga sering kali diperlukan dalam menangani lansia yang mengalami demensia atau gangguan kognitif lainnya. Dengan adanya sinergi antara berbagai profesi ini, lansia dapat menerima perawatan yang lebih komprehensif dan

sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga kualitas hidup mereka dapat lebih terjaga.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental bagi lansia, dibutuhkan kebijakan yang lebih progresif dalam mengintegrasikan berbagai profesi dalam layanan kesehatan mental. Kolaborasi yang erat antara psikiater, psikolog, perawat kesehatan jiwa, pekerja sosial, dokter umum, serta berbagai terapis dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif bagi lansia. Oleh karena itu, penguatan sistem layanan kesehatan mental dengan melibatkan berbagai profesi secara optimal menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan terbaik yang mereka butuhkan.

D. Strategi dan Implementasi Kolaborasi Multidisiplin dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Lansia

Upaya meningkatkan kesehatan mental lansia memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi di berbagai tatanan layanan, mulai dari komunitas, rumah sakit umum dengan layanan geriatri, rumah sakit jiwa dengan ruang khusus geriatri, panti lansia, hingga lembaga pemasyarakatan khusus lansia. WHO (2005) merekomendasikan bahwa pekerja kesehatan mental mencakup psikiater, psikolog, perawat kesehatan jiwa, dan pekerja sosial. Sementara itu, Trull (2005) menambahkan profesi seperti psikolog konseling, psikolog sekolah, psikolog rehabilitasi, psikolog kesehatan, serta dokter umum sebagai bagian dari sistem kesehatan mental. Dalam konteks Indonesia, kebijakan kesehatan mental nasional juga mencakup neurolog, praktisi umum, dokter keluarga, konselor profesional, pedagogis, serta berbagai jenis terapis (Mawarpury, 2013). Dengan adanya berbagai profesi ini, setiap tatanan pelayanan memiliki struktur kerja yang spesifik untuk memastikan kesejahteraan lansia.

1. Pelayanan Kesehatan Lansia Berbasis Masyarakat (Community-Based Geriatric Service)

Pelayanan berbasis masyarakat bertujuan untuk memberdayakan lansia dan lingkungan sekitarnya dalam menjaga kesehatan mental. Puskesmas dan dokter praktik swasta menjadi tulang punggung dalam layanan ini dengan membentuk kelompok lansia serta menyediakan penyuluhan kesehatan mental (Mawarpury, 2013). Dalam sistem ini, psikolog dan konselor bertugas melakukan asesmen kesehatan mental lansia dan memberikan terapi psikologis. Pekerja sosial berperan dalam membangun jejaring sosial lansia agar tidak mengalami isolasi, sementara perawat kesehatan jiwa memberikan pemantauan dan intervensi terhadap lansia yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dokter umum atau

dokter keluarga menangani aspek medis dasar dan merujuk lansia ke spesialis jika diperlukan.

2. Pelayanan Kesehatan Lansia di Rumah Sakit Umum dengan Layanan Geriatri (Hospital-Based Geriatric Service)

Rumah sakit umum yang memiliki layanan geriatri bertanggung jawab atas perawatan lansia dengan kondisi medis dan mental yang kompleks. Layanan ini mencakup poliklinik geriatri, rawat inap khusus geriatri, serta program rehabilitasi bagi lansia dengan gangguan kesehatan mental maupun fisik (Nasrullah, 2016). Psikiater geriatri menangani gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau demensia yang memerlukan terapi farmakologi. Dokter spesialis geriatri bekerja sama dengan dokter neurologi untuk menangani penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Perawat geriatri bertanggung jawab atas pemantauan kondisi harian lansia, sedangkan psikolog rehabilitasi membantu lansia dalam meningkatkan fungsi kognitif mereka. Terapis okupasi dan terapis fisik memberikan latihan untuk membantu lansia mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.

3. Pelayanan Kesehatan Mental Lansia di Rumah Sakit Jiwa dengan Ruang Khusus Geriatri

Rumah sakit jiwa (RSJ) yang memiliki ruang khusus geriatri berperan dalam menangani lansia dengan gangguan mental berat yang membutuhkan perawatan intensif. Layanan ini dirancang untuk merawat lansia dengan gangguan psikotik, depresi berat, demensia berat, serta gangguan perilaku akibat penyakit neurodegeneratif (Mawarpury, 2013). Psikiater geriatri berperan dalam diagnosis dan pengobatan farmakologis, sedangkan psikolog klinis memberikan terapi perilaku kognitif untuk membantu lansia mengelola emosinya. Perawat kesehatan jiwa memastikan lansia menerima perawatan yang sesuai dan memantau kondisi mental mereka secara berkala. Pekerja sosial kesehatan membantu dalam merancang program reintegrasi lansia yang stabil secara mental ke dalam masyarakat atau ke lingkungan panti lansia. Terapis okupasi di RSJ fokus pada latihan yang membantu lansia mempertahankan keterampilan sosial dan kognitif mereka, sementara terapis fisik menangani lansia yang mengalami gangguan gerak akibat gangguan mental atau kondisi neurologis.

4. Pelayanan Kesehatan Mental Lansia di Panti Jompo

Di panti lansia, layanan kesehatan mental difokuskan pada aspek psikososial dan kesejahteraan emosional. Lansia yang tinggal di panti sering mengalami

perasaan kesepian dan kehilangan, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif. Psikolog klinis dan konselor profesional memberikan terapi psikologis serta mendampingi lansia dalam mengatasi kecemasan atau depresi. Pekerja sosial berperan dalam memastikan lansia tetap memiliki keterlibatan sosial yang aktif. Dokter geriatri menangani kondisi medis kronis yang dapat berdampak pada kesehatan mental, sementara terapis okupasi menyediakan kegiatan harian yang meningkatkan keterampilan motorik dan kognitif lansia (Fibiyanto & Subroto, 2021). Perawat kesehatan jiwa di panti lansia memiliki peran penting dalam memberikan perawatan emosional dan psikologis secara langsung. Mereka bertugas dalam pemantauan kesehatan mental lansia sehari-hari, memberikan terapi suportif, serta membantu lansia dalam mengelola stres dan kecemasan. Selain itu, perawat jiwa juga mendukung pelaksanaan program rehabilitasi mental dengan berkoordinasi dengan psikolog dan pekerja sosial untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial lansia.

5. Pelayanan Kesehatan Mental Lansia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Lansia

Lansia di dalam lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan kesehatan mental yang unik, termasuk isolasi sosial, kecemasan, dan depresi (Afrizal & Rizki Noor, 2023). Psikolog dan konselor di lapas bertanggung jawab dalam mendeteksi dini masalah kesehatan mental serta memberikan intervensi yang sesuai. Petugas pemasyarakatan perlu dilatih dalam mengenali tanda-tanda gangguan mental dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan kepada lansia. Psikiater dan dokter umum menangani gangguan mental yang lebih kompleks, sedangkan terapis okupasi dan perawat kesehatan jiwa membantu lansia tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan rehabilitatif.

Setiap tatanan pelayanan kesehatan mental lansia memiliki peran dan strategi unik dalam memastikan kesejahteraan lansia. Dengan kolaborasi multidisiplin yang kuat, lansia dapat memperoleh layanan kesehatan mental yang optimal sesuai dengan kebutuhannya

E. Tantangan dan Solusi dalam Kolaborasi Multidisiplin

Kesehatan mental lansia merupakan aspek yang semakin mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya populasi lanjut usia di dunia. WHO (2013) mencanangkan visi dalam rencana aksi kesehatan mental 2013–2020, yang menekankan bahwa kesehatan mental harus dihargai, dipromosikan, dan dilindungi. Upaya ini bertujuan agar individu dengan gangguan mental mendapatkan hak asasi manusia secara penuh, serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan

berkualitas tinggi yang responsif terhadap kebutuhan mereka tanpa diskriminasi dan stigma. Dalam implementasinya, pendekatan multidisiplin sangat diperlukan guna memastikan bahwa pelayanan kesehatan mental bagi lansia dapat berjalan optimal, terutama di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum dengan layanan khusus geriatri, rumah sakit jiwa dengan ruang geriatri, serta panti werdha dan lembaga pemasyarakatan. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam kolaborasi multidisiplin yang dapat menghambat efektivitas pelayanan.

1. Hambatan dalam Kolaborasi Multidisiplin

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Tenaga Profesional

Salah satu tantangan utama dalam pelayanan kesehatan mental lansia adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal fasilitas maupun tenaga kesehatan yang kompeten di bidang geriatri dan psikiatri geriatri (Irfansyah & Subroto, 2023). Di banyak rumah sakit dan panti werdha, jumlah dokter spesialis kejiwaan (psikiater), psikolog klinis, serta perawat jiwa masih sangat terbatas. Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan yang ramah lansia, seperti ruang perawatan khusus dan program rehabilitasi yang komprehensif, juga masih belum merata di berbagai wilayah.

b. Stigma terhadap Gangguan Kesehatan Mental

Stigma terhadap gangguan mental pada lansia masih menjadi hambatan besar, baik di masyarakat umum maupun dalam lingkungan fasilitas kesehatan dan lembaga pemasyarakatan (Mudumi & Subroto, 2023). Banyak lansia yang enggan mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau tidak mampu mengendalikan diri. Dalam beberapa kasus, stigma ini juga hadir di antara tenaga kesehatan atau petugas yang menangani lansia, sehingga pendekatan yang diberikan menjadi kurang optimal.

c. Hambatan Administratif dan Regulasi yang Kompleks

Hambatan administratif sering kali memperlambat pemberian layanan kesehatan mental yang efektif bagi lansia. Proses birokrasi yang panjang, kurangnya regulasi yang jelas terkait integrasi layanan kesehatan mental dengan layanan kesehatan umum, serta keterbatasan dana dari pemerintah atau asuransi kesehatan menjadi kendala dalam implementasi program yang holistik (Ayuningtyas, 2018).

d. Kurangnya Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan dan Petugas Terkat

Tidak semua tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan lansia memiliki pemahaman yang baik mengenai kesehatan mental pada kelompok usia ini. Petugas panti werdha, perawat di rumah sakit umum, hingga petugas lembaga pemasyarakatan sering kali belum mendapatkan pelatihan khusus

terkait deteksi dini, intervensi, dan manajemen gangguan kesehatan mental pada lansia (WHO, 2020).

2. Solusi dalam Meningkatkan Kolaborasi Multidisiplin

Untuk mengatasi berbagai hambatan di atas, diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai sektor, baik kesehatan, sosial, hukum, maupun komunitas.

a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pendukung

Pemerintah dan institusi kesehatan perlu meningkatkan jumlah tenaga profesional di bidang psikiatri geriatri dan psikologi klinis lansia melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif. Selain itu, rumah sakit dan panti werdha perlu dilengkapi dengan fasilitas yang lebih ramah lansia, termasuk ruang perawatan khusus geriatri dengan pendekatan holistik (Irfansyah & Subroto, 2023).

b. Edukasi dan Kampanye untuk Mengurangi Stigma

Upaya edukasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, dan petugas lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk mengurangi stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Kampanye berbasis komunitas, seminar, serta pelatihan bagi tenaga medis dan petugas sosial perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya dukungan bagi lansia dengan gangguan mental (Mudumi & Subroto, 2023).

c. Reformasi Administratif dan Integrasi Layanan Kesehatan Mental

Perubahan regulasi diperlukan agar layanan kesehatan mental lebih mudah diakses oleh lansia, baik di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, maupun panti werdha. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan kesehatan mental tidak hanya tersedia di rumah sakit jiwa, tetapi juga di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan rumah sakit umum dengan layanan khusus geriatri. Pendanaan layanan kesehatan mental juga perlu ditingkatkan agar setara dengan layanan kesehatan fisik (Ayuningtyas, 2018).

d. Pelatihan Berkelanjutan bagi Tenaga Kesehatan dan Petugas Terkait

Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat jiwa, pekerja sosial, serta petugas di lembaga pemasyarakatan, perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait deteksi dini, intervensi psikososial, dan penanganan krisis bagi lansia dengan gangguan mental. Pelatihan ini harus berbasis praktik dan disertai supervisi dari tenaga ahli untuk memastikan efektivitasnya (WHO, 2020).

Kolaborasi multidisiplin dalam pelayanan kesehatan mental lansia sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang komprehensif dan holistik. Tantangan utama dalam implementasi layanan ini

mencakup keterbatasan sumber daya, stigma sosial, hambatan administratif, serta kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan dan petugas terkait. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma, reformasi administratif guna mempercepat akses layanan, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dan petugas sosial. Dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi, pelayanan kesehatan mental bagi lansia dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup mereka.

F. Penutup

Kolaborasi multidisiplin dalam pelayanan kesehatan mental lansia sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap tatanan layanan memiliki struktur peran yang berbeda, namun semuanya berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Rumah sakit umum dengan layanan geriatri berfokus pada perawatan kesehatan mental yang terintegrasi dengan layanan medis lainnya, sedangkan rumah sakit jiwa dengan ruang khusus geriatri menangani lansia dengan gangguan mental berat. Panti lansia dan lembaga pemasyarakatan juga memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan layanan kesehatan mental yang efektif.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan mental lansia, setiap profesi memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi. Psikiater berperan dalam diagnosis dan pengobatan gangguan mental yang lebih kompleks, sedangkan psikolog klinis dan konselor memberikan terapi psikologis serta intervensi perilaku yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Perawat kesehatan jiwa berperan dalam pemantauan kondisi mental lansia secara langsung serta memberikan dukungan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja sosial kesehatan membantu membangun jejaring sosial dan mendukung lansia dalam beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dokter spesialis geriatri dan dokter umum menangani gangguan fisik yang dapat berdampak pada kesehatan mental lansia. Sementara itu, terapis okupasi, terapis fisik, dan terapis wicara memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup lansia melalui berbagai intervensi rehabilitatif.

Pemantauan berkelanjutan serta evaluasi program menjadi kunci dalam memastikan efektivitas layanan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan integratif, serta sinergi dari berbagai profesi yang terlibat, diharapkan lansia dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, bermartabat, dan sejahtera di berbagai lingkungan.

Referensi

- Afrizal, R., & Rizki Noor, M. (2023). Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Pagaruyuang*, 6(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Ayuningtyas, D. (2018). *Kesehatan mental dalam perspektif kebijakan kesehatan*. Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)*. Diambil dari <https://sirusa.bps.go.id/index.php/dasar/pdf>
- Elfira, E., Girsang, B. M., & Nurbaiti, N. (2022). Application of digital electromyography portable (DEP) in Arduino Uno-based progressive muscle relaxation (PMR) exercise in the elderly. *EDUTEC: Journal of Education and Technology*, 5(3), 805-816.
- Fibiyanto, K. N., & Subroto, M. (2021). Implementasi pelayanan pemenuhan kesehatan terhadap narapidana lanjut usia. *Hukum Responsif*, 12(2). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/responsif>
- Irfansyah, A., & Subroto, T. (2023). Hambatan implementasi pelayanan kesehatan mental bagi lansia di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita*, 12(2), 122-123.
- Mawarpury, M., & Humam, F. (2013). Peran psikologi dalam pelayanan kesehatan mental di puskesmas. *Jurnal Psikogenesis*, 2(75), 2303-3177.
- McCombe, G., Fogarty, F., Swan, D., Hannigan, A., Fealy, G. M., Kyne, L., & Cullen, W. (2018). Identified mental disorders in older adults in primary care: A cross-sectional database study. *European Journal of General Practice*, 24(1), 84-91.
- McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. A. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(1), 112.
- Mujib, A., & Mudzakir, J. (2001). *Nuansa-nuansa psikologi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Muhith, A., & Siyoto, S. (2016). Pengaruh pola makan dan merokok terhadap kejadian gastritis pada lansia. *Jurnal Keperawatan*, 9(3), 136-139.
- Muna, Z., & Adyani, L. (2020). Analisis kesehatan mental pada lansia (Memahami kebersyukuran pada lansia Muslim di Aceh Utara). *Jurnal Psikologi Terapan (JPT)*, 3(1), 7-11.
- Mudumi, R., & Subroto, T. (2023). Stigma sosial terhadap gangguan kesehatan mental pada lansia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(1), 45-60.
- Nasrullah, D. (2016). *Buku ajar keperawatan gerontik dengan pendekatan asuhan keperawatan NANDA-NIC-NOC*.

- Petrova, N. N., & Khvostikova, D. A. (2021). Prevalence, structure, and risk factors for mental disorders in older people. *Advances in Gerontology*, 11, 409-415.
- Saidah Syamsuddin, S. K., Limoa, E. K. J., Jaya, M. A. K. J., Karsa, N. S., & Pratama, M. G. (2024). *Buku ajar psikogeriatri*. Nas Media Pustaka.
- Setyarini, E. A., Niman, S., Parulian, T. S., & Hendarsyah, S. (2022). Prevalensi masalah emosional: Stres, kecemasan, dan depresi pada usia lanjut. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(1), 21-27.
- Trull, T. J. (2005). Dimensional models of personality disorder: Coverage and cutoffs. *Journal of Personality Disorders*, 19(3), 262-282.
- World Health Organization. (2005). *WHO recommendation for mental health in Aceh*. Retrieved March 2, 2025, from <http://www.who.or.id/eng/contents/aceh/whorecommendation/mental/health/aceh>
- World Health Organization. (2013). *Mental health action plan 2013–2020*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *Guidelines on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches*. Geneva: World Health Organization.
- Wu, Y. T., Kralj, C., Acosta, D., Guerra, M., Huang, Y., Jotheeswaran, A. T., & Prina, A. M. (2020). The association between depression, anxiety, and mortality in older people across eight low- and middle-income countries: Results from the 10/66 cohort study. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 35(1), 29-36.

Profil Penulis



Ns. Fitrio Deviantony, S.Kep., M.Kep

Penulis Lahir di Banyuwangi, 1 Mei 1990, menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Indonesia tahun 2017. Bekerja sebagai dosen di Fakultas Keperawatan, Universitas Jember mulai tahun 2018 hingga sekarang sebagai dosen pengajar Keperawatan Jiwa. Penulis saat ini aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat bersumber dana internal dari Universitas Jember maupun hibah kompetitif nasional. Fokus kajian riset penulis pada keperawatan jiwa.

Motto: "Jalanilah Hidup Seperti anda Bernapas Setiap Hari"



Ns. Suwarningsih, S.Kep., M.Kep

Lahir di Jakarta, 21 April 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan pada Akper Pertamedika lulus tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2007. Melanjutkan pendidikan S2

Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2017. Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang aktif menjadi Dosen di Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas MH. Thamrin. Penulis mengampu beberapa mata kuliah yaitu kebutuhan Dasar Keperawatan, Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, Keperawatan Kesehatan Jiwa, Keperawatan Psikiatri dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, publikasi, menulis buku, pengabdian kepada masyarakat, pengajaran, pelatihan dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui email suwarningsih.agustiana@gmail.com



Syisnawati, S.Kep., Ns, M.Kep., Sp.Kep.J

Lahir di Sinjai, 1 November 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2008, jenjang profesi ners pada Program Studi Ilmu keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2014, Program ners spesialis jiwa pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009, penulis bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Ners FKIK UIN Alauddin mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan jiwa dan psikososial dan Keperawatan Psikiatri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syisnawati.syarif@uin-alauddin.ac.id



Mei Rianita Elfrida Sinaga, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Pematangsiantar, 29 Mei 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara tahun 2007, dilanjutkan Profesi Ners di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan tahun 2018 di Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sampai 2013 sebagai Perawat Primer di RSU Bunda Thamrin Medan, Sumatera Utara. Kemudian tahun 2014 sampai saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, dan Keperawatan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, pembuat soal uji kompetensi keperawatan nasional, dan pengelola jurnal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat terakreditasi nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mei@stikesbethesda.ac.id

Motto: "Teruslah belajar, belajarliah terus karena pembelajaran adalah kunci pertumbuhan, dan pertumbuhan adalah jalan menuju kebermaknaan hidup"



Herlina, S.Kep., Ns., M.Kes

Lahir di Bulukumba, 25 Februari 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Keperawatan Tahun 2017 dan Pendidikan Profesi Ners Tahun 2019 pada kampus STIKES GIA Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muslim Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011. Penulis bekerja sebagai dosen tetap di Akper Pemkab Bulukumba (Tahun 2011-2013) Kemudian pada tahun 2014 sampai sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Megarezky mengampu mata kuliah di Program studi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners dengan Mata Kuliah: Keperawatan Gerontik, Komunikasi Dasar Keperawatan, Kperawatan Jiwa, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: inhaherlina002@gmail.com



Ns. Endang Fauziyah Susilawati, M.Kep

Lahir di Pamekasan, 29 November 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis adalah D3 Keperawatan pada Akper Depkes Malang tahun 1996, melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan profesi Ners pada Universitas Airlangga lulus tahun 2006. Pendidikan S2 Keperawatan ditempuh di perguruan tinggi yang sama lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan penulis diawali sebagai dosen di Akper Pemkab Pamekasan. Saat ini penulis sebagai dosen di Politeknik Negeri Madura dengan mengampu mata kuliah keperawatan Jiwa, gerontik, dan keperawatan keluarga. Selain sebagai pengajar, penulis aktif di berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai penulis, seminar pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan jiwa, Lansia, dan kesehatan keluarga. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail endang@poltera.ac.id atau endangfauziyah.nawawi@gmail.com



Ns. Nurul Hidayah, M.Kep,

Lahir di Pontianak pada 19 Juli 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan di STIKES YARSI Pontianak, S1 dan Ners di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, serta S2 Magister Keperawatan di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Saat ini, penulis mengajar di STIKES YARSI Pontianak pada Departemen Jiwa Komunitas. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman dalam dunia keperawatan jiwa, penulis memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental, terutama bagi lansia. Dedikasi penulis dalam mengembangkan pendekatan multidisiplin tercermin dalam berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi tenaga kesehatan serta masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurul16040@mail.unpad.ac.id
Motto: "Menjadi cahaya bagi sesama melalui ilmu dan kepedulian"

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul "**Manajemen Kesehatan Mental pada Lansia**" merupakan sumber referensi yang komprehensif dan aplikatif untuk memahami serta menangani berbagai aspek kesehatan jiwa pada kelompok usia lanjut. Disusun berdasarkan pendekatan interdisipliner dan berbasis bukti terkini, buku ini membekali pembaca dengan wawasan konseptual dan strategi praktis dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara mental, emosional, dan sosial.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap munculnya gangguan mental di usia lanjut, seperti perubahan peran sosial, kehilangan pasangan hidup, isolasi sosial, serta penurunan fungsi fisik. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya edukasi dan literasi kesehatan mental bagi lansia dan keluarganya sebagai langkah preventif yang krusial.

Pendekatan komunitas, dukungan keluarga, aktivitas fisik, serta pemanfaatan teknologi modern untuk layanan konseling turut menjadi bagian penting dari strategi yang ditawarkan. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan pemerintah dalam menciptakan sistem dukungan kesehatan mental lansia yang terpadu.

Dengan gaya penulisan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, psikologi, serta para profesional dan pemerhati lansia. Buku ini juga relevan bagi pengambil kebijakan dan komunitas yang terlibat dalam pelayanan dan perlindungan hak-hak lansia.

Buku Referensi yang berjudul "Manajemen Kesehatan Mental pada Lansia" merupakan sumber referensi yang komprehensif dan aplikatif untuk memahami serta menangani berbagai aspek kesehatan jiwa pada kelompok usia lanjut. Disusun berdasarkan pendekatan interdisipliner dan berbasis bukti terkini, buku ini membekali pembaca dengan wawasan konseptual dan strategi praktis dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara mental, emosional, dan sosial.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap munculnya gangguan mental di usia lanjut, seperti perubahan peran sosial, kehilangan pasangan hidup, isolasi sosial, serta penurunan fungsi fisik. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya edukasi dan literasi kesehatan mental bagi lansia dan keluarganya sebagai langkah preventif yang krusial.

Pendekatan komunitas, dukungan keluarga, aktivitas fisik, serta pemanfaatan teknologi modern untuk layanan konseling turut menjadi bagian penting dari strategi yang ditawarkan. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan pemerintah dalam menciptakan sistem dukungan kesehatan mental lansia yang terpadu.

Dengan gaya penulisan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, psikologi, serta para profesional dan pemerhati lansia. Buku ini juga relevan bagi pengambil kebijakan dan komunitas yang terlibat dalam pelayanan dan perlindungan hak-hak lansia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-72-2



9

786347

294722